

目 录

内 科

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. 胃肠型感冒…… (1) | 15. 反甲…… (23) |
| 2. 放射性肺炎…… (2) | 16. 化学疗法所致造
血功能障碍…… (24) |
| 3. 老年性肺炎…… (3) | 17. 低蛋白血症…… (25) |
| 4. 不稳定型心绞
痛…… (5) | 18. 狼疮性肾炎…… (26) |
| 5. 失血性休克…… (6) | 19. 乳糜尿…… (28) |
| 6. 幽门弯曲菌相关性
胃炎…… (7) | 20. 多发性硬化症… (31) |
| 7. 胃酸过多…… (10) | 21. 咳嗽晕厥综合
征…… (35) |
| 8. 倾倒综合征 (餐后
早发综合征) … (11) | 22. 椎管狭窄症…… (36) |
| 9. 短肠综合征…… (13) | 23. 面部单侧味觉神经
性多汗症…… (39) |
| 10. 吸收不良综合
征…… (14) | 24. 焦虑性神经症… (40) |
| 11. 高胆红素血症… (16) | 25. 良性性交时头
痛…… (43) |
| 12. 无症状HBsAg
携带者…… (17) | 26. 末梢神经炎…… (44) |
| 13. 肝脾肿大…… (19) | 27. 股外侧皮神经
炎…… (46) |
| 14. 老年性贫血…… (20) | 28. 桡神经麻痹…… (48) |

29. 氟骨症····· (49)	变····· (66)
30. 化脓性关节炎·· (51)	36. 糙皮病····· (67)
31. 肩关节结核···· (53)	37. 低钙血症····· (68)
32. 创伤性关节炎·· (55)	38. 疟疾····· (70)
33. 减压病····· (57)	39. 急性砒霜(砷)
34. 癌性疼痛····· (59)	中毒····· (72)
35. 糖尿病周围神经病	40. 鱼胆中毒····· (73)

妇 产 科

41. 女性尿道综合 征····· (75)	47. 子宫内膜增生不 孕症····· (82)
42. 阿米巴性阴道 炎····· (75)	48. 葡萄胎····· (84)
43. 痛性脂肪过多综 合征····· (77)	49. 妊娠合并疟疾·· (86)
44. 阴道痉挛····· (79)	50. 过期妊娠····· (88)
45. 盆腔脓肿····· (80)	51. 产后血栓性静脉 炎····· (89)
46. 女性外伤性外阴 血肿····· (81)	52. 产褥中暑····· (91)
	53. 产后子宫复旧不 良····· (92)

儿 科

54. 新生儿肝炎综合 征····· (95)	59. 小儿毛细支气管 肺炎····· (102)
55. 新生儿窒息···· (96)	60. 小儿腺病毒肺 炎····· (103)
56. 新生儿脐炎···· (98)	61. 小儿迁延性肠 炎····· (105)
57. 小儿反复呼吸道 感染····· (99)	62. 小儿神经性尿 频····· (107)
58. 小儿肺部罗音久 不吸收····· (100)	



- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 63. 小儿急性偏瘫… (108) | 65. 幼女性阴道炎… (114) |
| 64. 幼儿蛲虫感染性
阴道炎…………… (113) | 66. 小儿过敏性包皮
水肿…………… (116) |

外 科

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 67. 外伤性截瘫… (117) | 症…………… (133) |
| 68. 手术切口久不愈
合…………… (121) | 75. 急性腰椎后关节紊
乱症…………… (134) |
| 69. 药物性龟头炎… (122) | 76. 第三腰椎横突综合
征…………… (136) |
| 70. 化脓性肉芽肿… (124) | 77. 骶髂关节错位… (138) |
| 71. 颈肩综合征… (125) | 78. 股骨头无菌性
坏死…………… (140) |
| 72. 岗下肌综合征… (128) | 79. 血胸…………… (141) |
| 73. 骨筋膜间隔区综
合征…………… (130) | |
| 74. 胸椎小关节紊乱 | |

皮 肤 科

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 80. 剥脱性角质松
解症…………… (144) | 83. 眼睑黄疣…………… (147) |
| 81. 射线皮炎…………… (145) | 84. 中毒性红斑…………… (148) |
| 82. 播散性颜面粟粒
性狼疮…………… (146) | 85. 关节型银屑病… (150) |
| | 86. 脓疱型银屑病… (152) |

眼 科

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 87. 交感性眼炎…………… (154) | 炎…………… (158) |
| 88. 电光性眼炎…………… (155) | 92. 一般性角膜溃
疡…………… (160) |
| 89. 视神经乳头水
肿…………… (156) | 93. 霉菌性角膜溃
疡…………… (162) |
| 90. 闪辉性暗点症… (157) | |
| 91. 浅层点状角膜 | 94. 匍行性角膜溃 |

疡…………… (164) | 95. 玻璃体积血………… (166)

耳 鼻 喉 科

96. 爆震性耳聋………… (169) | 98. 鼻粘膜糜烂………… (171)

97. 耳廓软骨膜炎…(170)

口 腔 科

99. 放射性口腔炎… (172) | 1~8集总目录………… (175)

100. 牙本质过敏………… (173) | 后记…………… (195)

内 科

1. 胃肠型感冒

胃肠型感冒是指感冒伴有胃肠道症状而血象和大便常规检查无明显异常的一种常见病，多发生于六、七、八月份。临床表现为：鼻塞，清涕，恶寒，全身困重，酸楚乏力，胸闷脘胀，头昏沉重，恶心呕吐，口淡纳差，腹泻水样便或便溏，或有低热，面色无华。

胃肠型感冒属于祖国医学的“外感挟湿”、“湿阻”范畴。中医认为系外感风邪，湿阻中焦，脾胃运化失司所致。治宜芳香化湿，疏风解表。

方药：藿香12克，厚朴12克，法半夏12克，茯苓15克，杏仁12克，陈皮10克，苏叶10克，白芷10克，苡仁30克，白豆蔻10克，白术12克，苍术30克。水煎服，每日1剂，连服3~7剂。或服藿香正气水或藿香正气液、藿香正气丸等成药均可。

加减：身困重加羌活、独活。热重加黄芩、银花。恶寒较重加荆芥、香薷。

方中藿香芳香化湿，理气和中而兼解表，厚朴、半夏除湿消痞理气散满，茯苓、苡仁健脾利湿，白术、苍术祛湿，陈皮醒脾祛痰湿，杏仁通利肺气，苏叶解表，白豆蔻化湿舒脾，白芷解表。诸药合用，共奏芳香化湿，理气健脾，疏风解表之功，本方为治疗胃肠型感冒的传统良方。

2. 放射性肺炎

胸部肿瘤如乳腺癌、食管癌、肺癌和其他恶性肿瘤接受放射治疗后，在放射野内的正常肺组织发生放射性损伤，表现为炎症反应，称为放射性肺炎。

放射性肺炎的常见症状为刺激性干咳，气急，胸痛，有时可发热，一般在 38°C 左右，同时常有食管炎的症状，如胸闷胀，呃逆，吞咽不畅等。

放射线照射部位的皮肤可有萎缩和硬结，局部毛细血管扩张。肺部可听到干、湿罗音及摩擦音。若炎症严重，则干咳持续存在，气急明显，活动后气急更剧。

放射性肺炎患者易发生呼吸道感染，每次感染持续时间较长，可加重肺部病变，最后可并发右心衰竭（紫绀，呼吸困难，颈静脉曲张，肝肿大并有压痛，全身浮肿等）。

根据放射治疗史和干咳、气急、胸痛、低热等临床症状及X线的征象（急性期在射线照射的肺野上出现弥漫性模糊阴影，边缘不整齐，病变的范围与胸廓表面照射也一致。慢性期发生肺纤维化，病变呈条索状或团块状收缩或局限性肺不张。纵膈胸膜和心包有大量粘连，纵膈向患侧移位，膈升高，一侧胸廓收缩），诊断一般不困难。但若将放射性肺炎误作肺转移性肿瘤，继续放射治疗，则可造成死亡。

中医认为，肺为娇脏，喜润而恶燥，肺气以清肃下降为顺，如病邪犯肺，包括射线的侵害与损伤，影响肺的清肃下降，则可出现咳嗽，气逆，胸痛等证候，肺为燥伤，肃降失

职，气逆而咳，诸症由生。《慎斋遗书》说：“肺为五脏华盖，统摄诸气，运行不息，乃至清之分，秋毫难犯。”《临证指南医案》说：“肺为呼吸之橐龠，位居最高，受脏腑上朝之清气，禀清肃之体，性主乎降，又为娇脏，不耐邪侵，凡六淫之气，一有所著，即能致病。”说明肺受病邪侵袭，即能发生症状。治宜滋阴清热润肺。

方药：沙参30克，麦冬30克，生地30克，鱼腥草30克，桃仁10克，红花10克，丹皮15克，川贝6克，阿胶10克（冲服），枇杷叶10克，桑白皮15克。水煎服，每日1剂，连服30～60剂。

加减：气短加黄芪、党参。痰中带血加白芨、茅根。痰湿重则加法半夏、瓜蒌。阳虚肢冷加补骨脂、肉桂、附片片

3. 老年性肺炎

老年人罹患肺炎后，由于抗病能力低下，肺炎病灶久不吸收，这就是老年性肺炎的特点。老年性肺炎的临床表现：咳嗽，咯痰，咳血，胸痛，呼吸困难，肺部呼吸音减弱，语颤增强，可闻及罗音，X线检查肺部有片状阴影，白细胞总数及中性粒细胞均可升高。

老年性肺炎属于祖国医学的“风温”、“咳喘”等范畴。中医认为多由痰热壅肺所致。叶天士说：“温邪上受，首先犯肺。”老年人正气虚弱，抗病力差，一旦染病，气阴两虚更为明显，痰热互结，肺气难以肃降，表现为一派正虚邪实之象。治宜扶正祛邪。虚实兼治。

辨证分型治疗

(一) 痰热壅肺型：咳嗽，胸痛，发热，痰中带血，血色鲜红，气短乏力，纳差神疲，舌红苔黄脉滑数。治宜清热祛痰。

方药：胆南星10克，杏仁15克，法半夏10克，陈皮10克，黄芩30克，瓜蒌15克，茯苓30克，冬瓜子30克，苡仁30克，赤芍30克，丹皮15克，玄参30克，麦冬30克，黄芪30克。水煎服，每日1剂，连服20～40剂。

(二) 气阴两虚型：形体瘦弱，午后低热，干咳无痰，气短，汗出，咳血，手足心热，心烦失眠，舌红无苔脉细数。治宜益气养阴。

方药：党参60克，麦冬30克，天冬30克，五味子15克，黄精30克，川贝粉6克（冲服），白芍30克，当归30克，枸杞15克，桑白皮30克，青蒿30克（后下），白术15克，茯苓15克，阿胶15克（冲服），杏仁15克。水煎服，每日1剂，连服20～40剂。

(三) 痰瘀互结型：咳嗽频作，咯铁锈色痰，胸痛，痛如针刺。舌紫暗，苔薄，脉弦涩。治宜活血化瘀，清痰散结。

方药：柴胡15克，当归30克，熟地30克，炮甲珠15克，三七粉6克（冲服），枸杞15克，麦冬30克，赤芍30克，丹皮12克，夏枯草30克，法半夏10克，胆南星10克，瓜蒌15克，生牡蛎30克。水煎服，每日1剂，连服20～40剂。

专方治疗

(一) 内治方药：鱼腥草30克，生石膏30克，黄芪30克，蚤休30克，桑白皮30克，麦冬30克，贯众10克，白术10克，麻黄10克，瓜蒌皮15克，苏子10克，赤芍30克，当归

30克，苡仁30克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

（二）外治方药：白芥子60克，苏子60克，青皮50克，共入铁锅中炒热，用布袋装好，乘热外熨（敷）背部，每晚熨20分钟（注：须待体温降至正常时方可用中药外熨背部炎症病灶投影区）。

4. 不稳定型心绞痛

冠心病心绞痛的临床分型有利于判断病情轻重，选择适当治疗手段。目前，学者们将心绞痛分为劳力型心绞痛和自发型心绞痛两大类型，其中自发型心绞痛又分为稳定型心绞痛和不稳定型心绞痛。

不稳定型心绞痛介于稳定型心绞痛与急性心肌梗塞之间，表现为心绞痛病情不稳定，在近期2~4周内，可发展为急性心肌梗塞，甚至猝死，或转为稳定型心绞痛。疼痛发作频度增加，疼痛持续时间延长，甚至休息时也发作或夜间痛醒，原有的缓解方法（治疗药物）失效，呈进行性恶化的心绞痛症候群。这都表明临床情况的不稳定性及严重性。

中医认为不稳定型心绞痛属寒实结胸，痰瘀壅结。治宜温肺泻实。涤痰破结。

内治法

方药：黄芪90克，地龙10克，当归15克，赤芍30克，桔梗15克，丹参30克，葶苈子30克，玄胡10克，乳香10克，没药10克，三七粉6克（冲服），桂枝10克，葛根60克。水煎服，每日1剂，连服15~30剂。

外治法

方药：桔梗3份，浙贝3份，巴豆1份，共研细末，装旱烟锅内，点火吸其烟，每次1~3锅儿。每日3次。

5. 失血性休克

失血性休克是由于失血过多（外伤、呕血、咯血、便血等失血）引起的休克。

临床表现

休克早期：患者烦躁不安，面色及皮肤苍白，口唇略呈青紫，出冷汗，肢体湿冷，恶心呕吐，心跳加快，尿量减少。

休克中期：除上述表现外，患者神志尚清楚，但软弱无力，表情淡漠，反应迟钝，意识模糊，脉搏细数，按压稍重脉搏即消失。血压下降，口渴。严重时呼吸急促，昏迷，血压测不出，无尿。

失血性休克属于祖国医学的“厥脱证”范畴。中医认为，气不摄血，血逆妄行，失血过多，势必导致气血逆乱，正气耗脱。治宜救阴回阳，益气固脱。随之证因同治（治疗原发病）。

中药治疗

方一：参脉注射液20毫升加25%葡萄糖液20毫升静脉缓慢推注，每15分钟1次，连续3~6次。

方二：人参15克，麦冬15克，五味子10克，急煎频服，直至休克纠正。

方三：人参15克，制附子15克，炮姜10克，炙甘草10

克，川军炭6克，生龙骨30克，生牡蛎30克。急煎频服，直至休克纠正。

方四：人参15克，制附片10克，葱白5根，人尿1小杯（冲服），猪胆汁1小盅（冲服），炙甘草10克。急煎频服，直至休克纠正。

针灸治疗

（一）取穴内关，强刺激，留针30分钟，每隔5分钟行针1次，直至血压上升。

（二）艾灸关元穴15分钟。艾火与皮肤表面的距离以病人能耐受为度。

6. 幽门弯曲菌相关性胃炎

幽门弯曲菌相关性胃炎是近年来新发现的病种。医者通过对一些慢性胃炎、消化性溃疡患者的胃镜检查及胃粘膜活体组织检查，均发现这些慢性胃炎和溃疡病患者的胃粘膜中存在着一种致病菌，这就是幽门弯曲杆菌，又称幽门螺旋菌。这种胃炎就被命名为幽门弯曲菌相关性胃炎，或称胃炎合并幽门弯曲菌感染、幽门弯曲菌感染性胃病、幽门弯曲菌感染性慢性胃炎、慢性胃病幽门弯曲菌感染。

幽门弯曲菌相关性胃炎的临床症状：上腹痛，胃中有烧灼感，腹胀，嗝气，恶心，呕吐，嘈杂，吞酸，纳差等。

中医认为，慢性胃炎多属虚证、瘀证，或虚实夹杂证。随着幽门弯曲菌这一检查方法的问世，提示了慢性胃炎病人有一个显著的共同点，即大多数有幽门弯曲菌生长。对于幽

门弯曲菌相关性胃炎，传统中医辨证治法，疗效不满意，故须针对幽门弯曲菌这一病原菌进行治疗（针对性治疗）。

辨证分型加基本方治疗

（一）肝胃不和型：脘腹胀满不适，餐后及情志不畅时加剧，嘈杂，嗳气，泛酸，苔薄脉细弦。治宜疏肝和胃。

方药：基本方（龙胆草15克，白花蛇舌草30克，蒲公英30克，乌梅15克，当归20克，白芍30克，甘草10克）加香附10克，郁金15克，佛手10克，绿萼梅10克。水煎服，每日1剂，连服20～40剂。

（二）脾胃虚寒型：胃脘隐痛，喜按喜热饮，面色无华，便溏，舌淡苔白脉弱。治宜温补健脾。

方药：基本方（同上）加黄芪30克，桂枝15克，干姜10克。水煎服，每日1剂，连服20～40剂。

（三）湿热蕴结型：胃脘胀满，嘈杂泛酸，口苦，舌红苔黄腻，脉弦数。治宜清热祛湿。

方药：基本方（同上）加黄连10克，吴萸6克，蚕沙10克，瓦楞子30克。水煎服，每日1剂。连服20～40剂。

（四）脾胃阴虚型：胃脘部隐痛，有烧灼感，口干舌燥，大便干，舌红绛无苔，脉细数。治宜养阴润燥。

方药：基本方（同上）加生地30克，沙参30克，麦冬30克，石斛15克。水煎服，每日1剂，连服20～40剂。

以上基本方中的龙胆草、白花蛇舌草、蒲公英对幽门弯曲菌相关性胃炎有较好疗效。

专方验方治疗

方一：蒲公英30克，丹参30克，地锦草15克，徐长卿10克，莪术10克，木香10克，吴萸6克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服30～60剂。

方二：黄芪30克，白芍30克，白术15克，蒲公英30克，藿香12克，白花蛇舌草30克，山药30克，甘草10克。水煎服。每日1剂，连服两个月。

加减：气虚气滞加党参30克，法半夏10克。肝胃不和加佛手10克，枳壳10克。胃阴不足加沙参30克，麦冬30克，乌梅15克。

方中黄芪可增强网状内皮系统的吞噬功能，诱生干扰素，提高淋巴细胞的转化率，促进抗体生成。白术、山药可增强网状内皮系统的功能。蒲公英可提高白细胞的吞噬功能。白花蛇舌草可刺激网状内皮系统增生，提高杀菌作用。

方三：石榴皮15克，玫瑰花15克，地榆15克，黄芪30克，白芍30克，丹参30克，徐长卿15克，木香10克。水煎服，每日1剂，连服30~60剂。

方中石榴皮、玫瑰花、地榆为幽门弯曲菌之高度敏感药物，故治疗幽门弯曲菌相关性胃炎有较好疗效。

中西药物配合治疗

方一：乌梅15克，黄连10克，大黄10克，山药30克，丹参30克，三七粉10克（冲服），甘草6克。水煎服，每日1剂，连服30剂。同时配合服用抗生素、痢特灵。

方中黄连、大黄、乌梅、丹参、三七粉对幽门弯曲菌有较强的抑制作用。

方二：水菖蒲30克，丹参30克，没药15克，玄胡10克，砂仁10克，木香10克，鸡内金15克，麦冬15克。水煎服，每日1剂，连服30剂。同时服用痢特灵30毫克，维生素B₆30毫克（1天量）。

7. 胃酸过多

胃酸过多是一种病理表现，可呈单一症候出现，但多数是综合症候群中的一个症状。现代医学认为迷走神经张力是调节胃酸分泌的主要机理。也有学者认为，吞酸的发生不在于胃酸分泌的多少，而是与胃体的逆蠕动有关。胃酸高者可以不出现吞酸，低酸者又可以出现吞酸，这种功能失调相当于中医所谓的“肝脾失调”。

胃酸过多属于祖国医学的“吞酸”、“咽酸”、“吐酸”、“泛酸”等范畴。中医认为胃酸过多的成因复杂，大致与肝胆、脾胃、肺与大肠诸脏腑的功能失调，气机升降失常以及火、热、痰、饮、宿食、体虚、外邪、七情等多种因素有关。

《内经》认为吐酸之因，为火或热，《诸病源候论》说：“由上焦停痰，脾胃有宿冷。”朱丹溪则认为，“吞酸者，湿热布积于肝，而出于肺胃之间”。中医还认为，寒则阳气不舒，气不舒则郁而为热，热则酸矣。饮食太过，脾气不运致酸；佛郁、湿热蒸酸；升降失职，胃气上逆而吞酸。故吞酸是气机失调的表现。调理肝脾是治疗吞酸的关键。

方一：柴胡10克，白芍10克，枳实10克，甘草10克，佛手10克，吴萸10克，黄连10克，麦芽30克，神曲20克，莱菔子10克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

方二：栀子10克，大黄10克，龙胆草10克，当归10克，防风10克，黄连10克，生地30克，丹皮10克，生牡蛎30克，

代赭石30克，瓦楞子30克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

方三：木香10克，砂仁10克，党参30克，白术10克，茯苓10克，甘草6克，苡仁30克，山药15克，神曲30克，乌贼骨15克，瓦楞子30克，鸡内金15克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

方四：吴萸10克，党参30克，生姜10克，大枣20克，茯苓10克，白术10克，紫苏10克，槟榔10克，瓦楞子30克，乌贼骨15克，沉香6克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

方五：橘红10克，法半夏10克，茯苓10克，竹茹10克，黄连10克，枳实10克，瓜蒌15克，乌贼骨15克，代赭石30克，大黄10克。水煎服。

方六：大黄10克，黄芩10克，黄连10克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

方七：狗胃1只，白胡椒5克，糯米150克，老姜3片。先将胡椒研末，糯米浸泡，将生姜、糯米、胡椒粉纳狗胃内，用针线缝合，蒸煮2小时，分3~4次食用。

8. 倾倒综合征（餐后早发综合征）

在胃切除与胃肠吻合术后，由于失去幽门或其正常生理功能，胃内食糜骤然倾倒至十二指肠或空肠而引起一系列症状，称为倾倒综合征，又称餐后早发综合征。

倾倒综合征的病因尚未阐明。有学者认为缺乏幽门的正常控制时，大量高渗性食糜骤然倾入十二指肠或空肠，肠粘

膜立即渗出大量液体，以稀释为等渗性食糜，使之易于同化，为此认为倾倒综合征的发生，与血管弛缓素—缓激肽系统的活动有关。血管弛缓素能增加周围血流量和毛细血管的通透性，并可增强消化道平滑肌收缩，因而出现血管舒张和胃肠道症状。

临床表现

患者常在食后，尤其是进食大量碳水化合物后20~30分钟，可感上腹温热和饱胀不适、恶心，有时伴呕吐、暖气、肠鸣胀气，有时有排便急迫感及腹泻。

与上述胃肠道症状发生的同时，可出现血管舒张症状，如头昏、眩晕，甚至晕厥，极度软弱，颤抖，大量出汗，面色发红或苍白，心动过速，严重者血压降低。

倾倒综合征的临床症状多发生于术后1~3周开始饮食时或在进餐中发生，以致在不得不立即停止进食。一般在1小时内症状全部消失。病人往往在餐后躺卧片刻，可迅速解除症状或避免发作。

中医认为倾倒综合征系手术后脾胃虚弱，脾胃升降失常。人体患病，常可引起气机升降失调；反之，升降失调又可导致病变丛生。治宜健脾益气，温阳益胃。

方一：党参30克，白术15克，茯苓15克，黄芪30克，扁豆15克，砂仁10克，陈皮12克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

本方适用于脾胃气虚（腹部饱胀，头昏，乏力，颤抖，出汗，心悸）的倾倒综合征患者服用。

方二：太子参30克，乌梅15克，木瓜30克，白芍30克，玉竹15克，莲米15克，苡仁30克，山药30克，石斛15克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

本方适用于津伤湿滞（面色萎黄，舌红苔黄腻，尿少，脉细数）的倾倒综合征患者服用。

注意事项：倾倒综合征患者宜少量多餐，少进汤类，适当增加脂肪类食物。进食后宜躺卧半小时左右，养成在餐间或空腹时饮水的习惯。配合服药治疗，多数患者能在数月或数年内减轻症状或获得痊愈。

9. 短肠综合征

短肠综合征是指因手术切除大段小肠而引起的一种吸收不良综合征。

健康成人的小肠粘膜的吸收表面大大超过维持适当营养所必需的面积，有很大的功能储备，因而患者常能耐受部分小肠切除，而不发生临床症状。但切除小肠如果达50%以上则可引起严重的吸收不良。切除某些部位，尽管切除得不多，但也会发生吸收不良。

临床表现

（一）急性期：体重减轻，乏力，倦怠，衰弱，手足抽搐（钙、镁吸收不良），骨质软化，骨质疏松，骨骼疼痛，易发生骨折，紫癜，全身有出血倾向（维生素K吸收不良）。

（二）慢性期：如果患者能安全地渡过急性期（数周），进入慢性期，则小肠吸收功能有所改善。但由于脂肪吸收不良，可产生水样腹泻，皮肤弹性减退，手足抽搐，贫血，紫癜，皮肤色素沉着，骨软化，浮肿。

短肠综合征属于祖国医学的“脾虚”范畴。由于手术损

伤，脾失健运，不能很好地吸收水谷精微，因而出现乏力、倦怠等虚劳证候，治宜健脾补虚，以改善小肠吸收，使小肠功能得到代偿。

方药：党参30克，白术15克，茯苓15克，甘草10克，山药30克，苡仁30克，黄芪30克，大枣30克，五味子15克，阿胶（烔服）10克。水煎服，每日或隔日1剂，连服30～60剂。

方中党参、白术、茯苓、甘草为四君子汤，具有健脾益气之功能，为治脾胃气虚、运化力弱之名方。山药健脾止泻，补肺益肾。苡仁健脾利湿，治泄泻、水肿等症。黄芪补中益气，利水，生肌，善治脾胃虚弱。大枣亦为治脾胃虚弱、倦怠乏力之要药。五味子能增强机体对非特异性刺激的防御能力，促进基础代谢，调节胃液和胆汁分泌。阿胶补血止血，系针对紫癜和出血倾向而用。全方具有健脾补虚，促进小肠吸收功能代偿的作用。

10. 吸收不良综合征

吸收不良综合征主要由于各种营养物质吸收障碍引起的一系列病理生理改变，也可以说是各种营养不良的综合表现。

有人将吸收不良综合征分为：1.特发性吸收不良综合征（包括全营养素吸收障碍，即乳糜泻综合征及仅一种营养素选择性吸收障碍）；2.消化障碍性吸收不良综合征（包括食物与消化液分泌时间不协调，乳化障碍，胰消化液分泌缺乏，胆盐分泌减少，胆汁减少等）；3.症状性吸收不良综合

征（包括肠道实际吸收面积减少，肠蠕动亢进，小肠内细菌丛异常增生，内分泌异常）三种类型。也有人分为：1. 幼儿乳糜泻；2. 成人乳糜泻（麦胶性肠病、原发性脂肪泻）；3. 热带口炎性腹泻三种类型。也有人分为原发性和继发性两大类，未找到原因者为原发，由各种疾病引起者为继发。

吸收不良综合征发病原因虽多，但病理改变大致相同，即小肠运动障碍，小肠粘膜缺陷，影响食糜消化与吸收；各种消化液分泌不足或紊乱，造成肠腔内消化吸收不良。

临床表现：腹泻腹痛，典型脂肪泻的粪便为色淡、量多、油脂状或泡沫样，常漂浮于水面，且多具恶臭，每日腹泻数次到十余次。患者体重减轻，倦怠乏力，手足抽搐，感觉异常，骨质疏松，骨软化，骨痛。患者有出血倾向，口炎，口角炎，脚气病，毛囊角化，角膜干燥，夜盲，贫血，凹甲，浮肿，发热，夜尿等。

血液检查，血总蛋白低于6克%，血胆固醇低于120毫克%，血清钾、钙、钠、镁均降低。并可通过粪脂测定、小肠吸收功能试验等检查而确诊。

吸收不良综合征属于祖国医学的“脾虚”范畴。中医认为，脾虚以小儿及老人为多见。特别是老年人，饮食失调，劳逸不当，易伤脾胃。人届老年，五脏俱虚，脾气衰退，调摄失宜，易致脾气虚损难复。脾虚运化失常，水谷不化精微反为湿浊，郁久化生湿热，久之导致气机升降失常。治宜健脾和胃，散结消痞。

方一：黄芩15克，黄连10克，法半夏10克，干姜10克，党参30克，大枣15克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服30～60剂。

方二：山药30克，苡仁30克，白术15克，茯苓15克，党

参30克，干姜10克，苍术15克，扁豆10克，鱼腥草30克。水煎服，每日1剂，连服30～60剂。

方三：柴胡15克，白芍30克，枳实10克，甘草10克，神曲30克，鱼腥草30克，党参30克，白豆蔻10克，砂仁10克。水煎服，每日1剂，连服30～60剂。

11. 高胆红素血症

高胆红素血症多见于慢性肝炎、乙型肝炎、重症肝炎，可导致肝细胞水肿、坏死、肝小叶反应性炎症，甚至发展为胆汁性肝硬化、肝功能衰竭而死亡。患者血清胆红素持续 >10 毫克%，可见肉眼黄疸，伴消化道症状甚至腹水。症状表现为1. 热重于湿型：发热、口干苦、心烦、尿短赤、大便干燥。2. 湿热并重型：恶心、呕吐、纳少、心烦胸闷、乏力、腹胀、尿少而赤、大便粘滞。3. 急黄型：身热困倦、胸闷腹胀。

高胆红素血症属于祖国医学的“黄疸”范畴。中医认为系湿热蕴蒸，邪毒蕴结肝胆，胆液被迫外泄而侵袭肌肤所致。《血证论》说：“眼珠黄者，胃经属湿热，甚则通身皆黄……在肝经是瘀热……”当代名医关幼波认为“治黄必治血，血行黄易却”。高胆红素血症治疗的关键是力求在短时期内迅速控制黄疸上升，以缩短高胆红素血症的时间及改善预后，阻止血氨升高，防止肝昏迷发生。

方一：赤芍60～100克，虎杖30克，大黄10克，水煎服，每日1剂，连服7～15剂。

方二：益母草60克，赤芍50克，生地50克，丹参20克，虎杖20克，黄芩20克，白术20克，柴胡10克，茯苓10克，枳壳10克，金钱草30克，大黄15克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂。

方中益母草活血、祛痰、利尿、消肿、解毒。赤芍、生地活血凉血，滋阴降火。丹参活血祛瘀，凉血消肿。黄芩、虎杖清热解毒。柴胡解郁疏肝。白术、茯苓、枳壳健脾和中，消痰利湿。金钱草利胆退黄。大黄泻热毒，攻瘀滞。

服药后大便溏泻，可促进胆汁代谢，加速黄疸消退，减少肠中氨的重吸收，控制血氨升高，防止肝昏迷发生。

方三：郁金30克，赤芍90克，黄连10克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂。

加减：气虚加党参、黄芪。血虚加当归、何首乌。阳虚加仙茅、仙灵脾。阴虚加女贞子、旱莲草。热盛加板蓝根、虎杖。湿盛加佩兰、苍术。

方四：青黛30克，明矾15克，泽兰15克，共研细末，每次服2克，每日服3次，饭后用开水送服，连服7~15日。

12. 无症状HBsAg携带者

无症状HBsAg携带者，是指HBsAg阳性但患者无自觉症状。然而，有学者认为，HBsAg不但是乙型肝炎的病因，而且与慢性肝炎、肝硬化、肝癌的发生有密切关系，应积极治疗，争取HBsAg转阴。

HBsAg（乙型肝炎表面抗原）阳性，祖国医学认为是

湿热病邪侵入经络，造成经络（奇经）瘀滞所致。HBsAg久不转阴，可造成因瘀致虚，虚而复瘀的恶性循环，故须积极治疗。中医治疗HBsAg阳性的原则是清热解毒，活血化瘀，益气补血。

方一：苍术30克，乌梅30克，虎杖30克，板蓝根30克，黄芪60克，贯众15克，茵灵芝30克，白花蛇舌草30克，赤芍30克。水煎服，每日1剂，连服3个月。

方二：制首乌30克，当归15克，黄芪60克，白术15克，白芍15克，板蓝根30克，土茯苓30克，贯众20克，山楂30克，水煎兑服“增硒绞股兰颗粒剂”50克。每日1剂，连服3个月。

加减：湿热盛者加茵陈、栀子、黄芩。脾虚加太子参、陈皮、苡仁。气滞加枳壳、木香。血瘀加三棱、莪术、桃仁、红花、鳖甲。失眠加酸枣仁、柏子仁。

现代医学认为，HBsAg阳性患者，多由于机体免疫功能低下，以致体内病毒不能及时被清除。或由于机体免疫功能失调，造成自身免疫反应所致。方中黄芪、白术具有强壮免疫作用。当归、首乌、白芍有保肝、补充营养物质、调节神经等作用。山楂、神曲、麦芽有促进消化之作用。板蓝根、贯众、土茯苓有抑制HBsAg、提高细胞免疫水平等作用，诸药合用，能增强机体免疫功能，中止或清除HBsAg在机体内存留。

方三：黄芪60克，垂盆草30克，虎杖30克，板蓝根30克，陈皮10克，法夏10克，茯苓10克，白术10克。水煎服，每日1剂，连服3个月。

方中黄芪益气健脾，能增强免疫功能，陈皮、法夏、茯苓、白术燥湿健脾，有扶正之功。垂盆草、虎杖、板蓝

根清热解毒，有抗病毒作用。全方能促进HBsAg转阴。

方四：白花蛇舌草60克，板蓝根30克，贯众30克，枸杞15克，菌灵芝30克。水煎服，每日1剂，连服3个月。

本方能较好地调节人体阴阳的平衡，使人体内环境得到稳定，促使正气恢复，扶正与祛邪并举，增强免疫功能，是治疗HBsAg阳性的良方。配合服用增硒绞剂兰颗粒剂（每日50克）则疗效更好。

13. 肝脾肿大

肝脾肿大是慢性肝炎、肝硬化等慢性肝病的体征之一，常使患者感到不适，造成心理上的极大负担。有的患者自觉症状不明显，仅感轻度乏力，有的患者则感腹胀、胁痛、乏力、纳差，可有血小板减少，鼻衄，齿衄，血清白蛋白降低，肝功能损害。肝脾肿大可通过扪诊及“B超”检查确诊。

肝脾肿大属于祖国医学的“症积”范畴。中医认为多因正气虚亏，脏腑失和，气滞血瘀，肝郁日久，疏泄失职，痰浊瘀积腹内所致。《诸病源候论》说：“积聚者，由阴阳不和，脏腑虚弱，受于风邪，搏于脏腑之气所为也。”《圣济总录》说：“脏腑不和，则气血留滞而成积聚，其积聚蕴结，气不宣通，与脏气相搏，故令人心腹胀满……。”肝脾肿大的治疗，宜活血化瘀。

方一：桃仁12克，红花12克，当归30克，赤芍30克，三棱10克，莪术10克，炙鳖甲15克，香附15克，枳壳10克，玄胡10克，制首乌30克，阿胶10克。水煎服，每日或隔日1剂，连服30～60剂。

方二：黄芪60克，党参30克，白术15克，茯苓15克，当归30克，熟地30克，莪术10克，炙鳖甲15克，丹参30克，枸杞15克，香附10克，阿胶10克，炒麦芽30克，神曲15克。水煎服。

方三：鳖甲、山甲等份，研末，蜂蜜调服，每次服6克，每日服3次，两个月为1疗程。

方四：大黄廔虫丸（成药），每次服6克，日服2次，用黄芪30克、党参30克、佛手10克、郁金10克，煎汤送服大黄廔虫丸。每日1剂，连服30~60剂。

方五：当归30克，川芎15克，丹参30克，柴胡12克，青皮10克，三棱15克，莪术15克。水煎服，每日1剂，连服30~60剂。

加减：气滞加川楝子、香附、枳壳。瘀血内阻加桃仁、红花、五灵脂、土鳖虫。出血加小蓟、生地、栀子。

方六：五灵脂30克，三棱60克，莪术60克，山甲90克，柴胡45克，共研细末，每次服6克，每日2次，开水送服。连服两个月。

14. 老年性贫血

老年性贫血多发生于食欲低下、消化吸收功能较差、性功能低下的老年人。老年性贫血包括缺铁性贫血及营养性巨幼红细胞性贫血。原发病可有胃十二指肠炎症及溃疡（呕血、黑便），感染，钩虫病（失血引起贫血）等。男性血红蛋白低于110g/L，女性血红蛋白低于100g/L（其中低于60g/L

者为重度贫血，80~100g/L者为轻度贫血）。

患者面色萎黄或苍白，指甲苍白，睑结膜苍白，消瘦乏力，四肢欠温，纳差便溏，畏寒，头晕，记忆力减退，注意力不能集中，心悸。现代医学认为老年性贫血不仅与消化吸收功能减弱有关，而且与患者衰老的造血组织的再生能力减低有密切关系。

老年性贫血有其自身的发病特点，治疗上也须特别注意，故专文阐述。

老年性贫血属于祖国医学的“血虚”范畴。中医认为，脾胃为后天之本，气血化生之源。卫气来源于中焦，胃气强则卫气始固。“四季脾旺不受邪”，即是指食欲强盛，脾胃消化吸收功能良好，疾病就少生。胃气壮，五脏六腑皆壮。相反，胃气受损，脾胃功能紊乱，则可以导致其他病变，也包括老年性贫血在内。脾胃功能减弱，血无以生，不能统血，则可出现血虚。此即“土为万物之母，诸脏腑百骸，受气于脾胃而后强。若脾胃一亏，则众体皆无以受气，故见羸弱矣”。老年人精血不足，常与其脾胃之气虚弱，消化吸收功能差有很大关系。

中医还认为老年性贫血与肾虚有关。肾为先天之本，肾藏精，肾主骨生髓，肾虚可导致血虚（贫血）。中医认为，髓有脊髓、骨髓之分。根据中医理论，临床上将一些脑、脊髓等中枢神经系统的疾患，归之于脊髓，用“补肾荣脑法”治疗，疗效有所提高；而一些造血系统的疾患（包括老年性贫血），则归之于骨髓，用“补肾生髓法”治疗，疗效也较好。老年性贫血病人，年老体弱，肾精亏损，骨髓不充，髓虚则精血不能复生。肾精虚损，肾阳不振，不能温养他脏，使他脏亦虚，特别是不能温运脾土，脾气虚则化生气血的功能

衰退，从而出现气血不足的证候，形成贫血。老年性贫血的治疗，宜补肾健脾，益气补血，从调理脾胃着手，开气血生化之源，从而改善老年人脾胃功能，促进营养及造血物质的吸收利用，而不应首先着重补铁或单纯补血。

方一：党参30克，白术15克，茯苓15克，甘草10克，大枣30克，黄芪30克，当归20克，木香10克。水煎服，每日1剂，连服30~60剂。

方二：扁豆15克，苡仁30克，苍术15克，党参30克，白术15克，熟地20克，制首乌30克，阿胶15克（烔服），当归20克。水煎服，每日1剂，连服30~60剂。

方三：仙灵脾30克，仙茅10克，黄精30克，枸杞15克，熟地30克，山药30克，覆盆子10克，菟丝子15克，当归30克，黄芪60克。水煎兑服“增硒绞股兰颗粒剂”50克。连服两个月。

方四：鹿茸粉0.5克，红参粉3克，开水送服，每日1次，临睡前服。连服两个月。

方五：胎盘粉5克冲服，牛骨髓20克，当归30克，黄芪60克。水煎服，每日1剂，连服两个月。

方六：龟龄集（成药），每次服6克，每日2次，开水送服，连服两个月。

龟龄集为补肾抗衰老之成药，方中29味药有19味属补肾之品，其中鹿茸占全方总量近15%。中医认为鹿茸系血肉有情之品，峻补肾阳，益精养血。用于治疗老年性贫血，有较好疗效。

现代药理研究认为鹿茸有增加造血组织机能的作用，与祖国医学的肾主骨生髓的理论有不谋而合之处。动物实验证实，给家兔喂鹿茸粉后，红细胞、血红蛋白均增加。这一实

验结果，为中医的“肾主骨生髓”及“补肾生髓”的理论提供了科学依据。

15. 反 甲

反甲又称匙状甲。甲板变薄，中央凹陷而周边翘起。反甲常见于缺铁性贫血、甲状腺机能亢进或低下。长期接触硫性物质及矿物油类的人亦可产生反甲。少数患者为先天性反甲。

中医认为爪甲与肝有关，肝血的盛衰常反映于爪甲。肝的阴血充足，筋膜得养，筋力强壮，则爪甲坚韧，光泽红润，富有华色。肝有病变时，爪甲失其滋润，则变形、脆裂、变薄或枯而色夭。反甲的治疗，宜柔肝补血，益气养血。

中药治疗

方药：当归30克，熟地30克，黄芪60克，制首乌30克，阿胶15克（烔服），川芎10克，赤芍30克。水煎服，每日1剂，连服两个月。

方中当归活血补血，黄芪益气，助当归补血活血。熟地养阴补血，制首乌益肝肾，补阴血，阿胶滋阴补血，川芎活血，赤芍养阴清热，活血化瘀。全方具有补血养肝，濡养爪甲的作用。

针灸治疗

取穴：太冲、血海。

方法：用30号毫针，直刺太冲穴，深0.5寸，针感传导

至趾。刺血海穴，应向上斜刺1~2寸，得气后留针30分钟。每日针1次，10次为1疗程。

太冲穴属足厥阴肝经之原穴。肝有藏血及生发、条达之特性。血海穴属足太阴脾经，脾主运化，又有长养、化育之特性。取以上两穴，可起调和气血、滋养爪甲之作用。

16. 化学疗法所致造血功能障碍

化学疗法（简称化疗）所致造血功能障碍在临床上并不罕见。

化学疗法或放射疗法是当前治疗恶性肿瘤的手段之一。在化疗或放疗的过程中，由于化疗或放疗的毒性作用，出现造血功能障碍，使患者不得不中止治疗，给患者造成很大痛苦。

化疗所致造血功能障碍表现为白细胞减少、中性粒细胞减少、贫血、血小板减少。患者自觉症状有心悸，乏力，气短，烦躁，失眠，胸闷，恶心等。

化疗所致造血功能障碍属于祖国医学的“血虚”、“虚劳”范畴。由于化疗或放疗的毒性作用，损伤人体的气血津液，导致虚症丛生。《医统正脉全书》说：“阴血有亏，虚火冲逆，心不藏神，肝不藏魂，怔忡惊悸，烦躁不寐，虚症毕至……。”化疗所致造血功能障碍的治疗，宜益气补血，补肾填髓。

方一：龟龄集（成药）每次服6克，开水送服，每日服2次，连服两个月。

方二：田七花粉口服液，每次服2支，每日服2次，连服两个月。

方三：鹿茸粉2克，红参粉6克，胎盘粉6克，开水送服，每日服1次，临睡时服。连服两个月。

方四：牛骨髓50克，鸽子一只，共炖熟烂，喝汤吃鸽。

方五：增硒绞股兰颗粒剂50克，开水冲服，每日1剂，连服两个月。

17. 低蛋白血症

低蛋白血症是一种临床症状。慢性肾炎、营养不良、严重烧伤、慢性胃炎、慢性肠炎、上消化道出血、慢性肝炎、慢性支气管炎等均可引起低蛋白血症。而低蛋白血症由于机体抵抗力减低，又易并发各种感染（如呼吸道感染、泌尿道感染、皮肤感染及腹膜炎等），形成恶性循环。

低蛋白血症的病因大致如下：①由于胃肠道疾病引起的蛋白质消化吸收障碍。②由于大手术、创伤、骨折、烧伤、甲状腺机能亢进、急性肾功能衰竭而致的蛋白质消耗增加。③由于肝脏疾患导致组织蛋白质的利用、合成失调。④慢性疾病和急性传染病造成营养不良。

低蛋白血症患者血浆蛋白含量显著下降，白蛋白下降尤为明显，常低于3克%，甚至低于1克%。患者可有浮肿，面色苍白，乏力，毛发稀疏，腹部凹陷如舟状，肝肿大，易反复感冒，食欲不振，腹胀，腹泻。患者由营养不良引起胃肠功能紊乱，又因消化吸收障碍而加重营养不良，在这方面也形成恶性循环。

低蛋白血症属于祖国医学的“虚劳”、“脾肾阳虚”范畴。中医认为脾胃为后天之本，气血生化之源。脾失健运，水谷精微不能化生，营养物质不能很好地吸收和利用。若脾虚久泻，脾病及肾，命门火衰，不能温运脾阳、腐熟水谷而致久泻不愈。治宜补中益气，温补脾肾。

方一：黄芪30克，党参30克，升麻10克，柴胡10克，甘草10克，白术15克，陈皮10克，当归15克，茯苓15克。水煎服，每日1剂，连服两个月。

方二：山药30克，石莲子10克，白术15克，茯苓15克，党参30克，甘草10克，补骨脂10克，菟丝子10克，法半夏10克，诃子10克，肉桂6克，车前草10克，麦芽30克，谷芽30克，吴茱萸10克。水煎服，每日1剂，连服两个月。

18. 狼疮性肾炎

狼疮性肾炎，又称系统性红斑狼疮的肾损害。

狼疮性肾炎是一种以累及多器官、多系统为特征，有显著免疫学异常引起组织损害的结缔组织病，其中有肾脏病变的约占50~70%。目前，系统性红斑狼疮的主要致死原因在于肾脏的损害。

狼疮性肾炎肾损害的临床表现主要包括蛋白尿、血尿、高血压、浮肿以及肾机能障碍。

(一)轻度损害型：除系统性红斑狼疮脏外症状外，肾脏症状不明显。尿常规检查有蛋白尿(十~廿)，可有镜下血尿，有红细胞管型，部分病人有轻度高血压。

(二) 肾病综合征型：明显浮肿，大量蛋白尿，血浆总蛋白及白蛋白下降。尿常规检查可发现较多的红细胞、白细胞及管型。

(三) 肾功能减退型：除蛋白尿、血尿外，有明显的肾功能减退，病情进展快，可出现尿毒症。

有以上肾脏损害表现结合全身其他系统性症状如发热、皮损、关节炎以及心、肺、造血、神经系统症状，不难作出诊断。

狼疮性肾炎的肾损害属于祖国医学的“水肿”、“虚劳”等范畴。中医认为本病病因多为内外合邪，先天禀赋不足，肝肾亏损，加之外受风寒湿邪或风热之邪，气血受阻而致瘀血内停，或脾肾阳虚，水湿泛滥。治宜行气活血，清热解毒，消瘀逐水。

方一：银花30克，土茯苓30克，黄芩30克，大青叶30克，青蒿30克（后下），白红蛇舌草30克，乌梅15克，玄参15克，生地30克，威灵仙20克。水煎服，每日1剂，连服两个月。本方适用于发热明显、红斑、关节肌肉酸痛、浮肿之狼疮性肾炎患者服用。

方二：知母15克，丹皮15克，麦冬30克，黄柏15克，青蒿30克（后下），生地30克，沙参30克，玄参30克，白花蛇舌草30克，山萸30克，枸杞15克，秦艽15克。水煎服，每日1剂，连服两个月。本方适用于午后低热、斑疹暗红、盗汗、耳鸣、听力减退之狼疮性肾炎患者服用。

方三：赤芍30克，丹参30克，柴胡15克，川芎12克，青蒿30克（后下），白花蛇舌草30克，土鳖虫12克，乌梅15克，玄参30克，益母草30克，玉米须30克，麦冬30克。水煎

服，每日1剂，连服两个月。本方适用于红斑色褐，浮肿久久不退，舌紫且有瘀斑之狼疮性肾炎患者服用。

19. 乳 糜 尿

乳糜尿是班氏丝虫病的晚期症状之一。腹腔结核、肿瘤、胸腹部创伤或手术、先天性淋巴系统疾病、肾盂肾炎、妊娠、包虫和疟疾也可出现乳糜尿。不过仍以丝虫病为常见。

乳糜尿多呈间歇性反复发作，间歇期自数周至数年不等，每次发作历时数日。严重病人可有持续性乳糜尿。乳糜尿常骤然出现，发作前有时可先有腰酸、骨盆及腹股沟部疼痛、发热等症状。发作时小便呈乳白色，混有血液时可呈粉红色，多数患者有肉眼血尿，也可出现淋巴血尿而无明显乳糜尿。

乳糜尿或乳糜血尿在膀胱内长期停留后易凝结成块，阻塞尿道，引起排尿困难。

乳糜尿含大量脂肪及大量蛋白，置于玻璃瓶内可见分为三层：上层为白色乳糜液（脂肪），中层为混悬有小凝结核的较清的液体，下层为红色或粉红色沉淀。沉淀内有淋巴细胞和红细胞，在约半数病例的乳糜尿沉淀中可发现微丝蚴。

乳糜尿属于祖国医学的“膏淋”范畴。中医认为系中气不足，气虚所致。张景岳说：“膏淋溺如膏出……此惟中气下陷及命门不固之证也”。乳糜血尿也由于内虚所致。《清

代名医医案精华》说：“膏淋血淋同病，……独责乎虚。”膏淋多系脾气虚弱，运化失职，水谷之气不化为精微而反为湿浊下注膀胱，脾肾两虚，肾关不固，统摄无权，导致膏淋血淋同病。《诸病源候论》说：“膏淋者，淋而有肥，状似膏，故谓之膏淋，亦曰肉淋，此肾虚不能制于肥液，故与小便俱出也。”《医方类聚》说：“膏淋者，小便肥而似膏，亦谓之肉淋，本肾虚不能制肥液也。”《明医指掌》说：“气血凝如膏糊，为膏淋。”膏淋的治疗，宜清热健脾，补肾化瘀。

辨证分型治疗

（一）湿热下注型：乳糜尿持续出现，腰酸，发热，伴有血尿，尿涩，舌红，苔黄腻，脉涩。治宜清热祛湿。

方药：萆薢30克，茯苓15克，知母12克，黄柏12克，丹皮15克，苡仁30克，山栀12克，泽泻30克，石苇30克，茅根30克，益母草30克。水煎服，每日1剂，连服30～60剂。

（二）气虚下陷型：小便乳白色，体倦乏力，气短懒言，面色晄白，舌淡苔白脉细弱。治宜补中益气。

方药：黄芪30克，党参30克，陈皮10克，升麻10克，柴胡10克，萆薢30克，龙胆草10克，扁蓄10克，当归30克，赤芍30克。水煎服，每日1剂，连服30～60剂。

（三）脾肾两虚：溺如脂膏，纳差，体倦，腰膝酸软，失眠，尿中混有血液。舌淡，苔薄，脉弱。治宜健脾益肾。

方药：山药30克，山萸15克，黄芪60克，苡仁30克，党参30克，茯苓15克，菟丝子15克，熟地15克，莲米15克，肉苁蓉15克，萆薢30克，苦参15克。水煎服，每日1剂，连服30～60剂。

专方治疗

方一：萆薢30克，益智仁12克，芡实15克，莲须10克，龙胆草10克，木通10克，石菖蒲12克，菟丝子15克，桑寄生30克，续断30克，栀子12克。水煎服，每日1剂，连服30～60剂。

方二：猪苓30克，泽泻30克，阿胶25克（烔服），五味子15克，滑石30克，仙鹤草30克，黄芪30克，当归20克，金樱子30克。水煎服，每日1剂，连服30～60剂。

方三：韭菜籽15克，萆薢30克，益智仁15克，菖蒲15克，知母12克，黄柏12克，乌药10克，灯草3克，莲米30克。水煎服，每日1剂，连服30～60剂。

方四：玉米须30克，益母草30克，小茴香15克，莲米30克，五味子15克。水煎服，每日1剂，连服30～60剂。

针灸治疗

取穴：足三里，阳陵泉，阴陵泉，三阴交，脾俞，三焦俞，血海，复溜，中极，关元。

每次任选4～5穴，留针30分钟，中间行针3次，每日针刺1次，针刺7天间歇3天再作针刺。

综合治疗

中药、耳针、体针联合治疗。中药成药知柏地黄丸每次服10克，每日服3次，每次均用萆薢10克煎水送服。耳针取穴：肾，膀胱，皮质下，神门，每日针1次，强刺激，不留针。体针取穴足三里、三阴交、中极，每次留针30分钟，每日针1次。亦可针后加灸。

食物治疗

苡仁30克，芡实30克，莲米30克，猪皮30克，大米50克，共煮成粥，随意食用，吃时可加盐或酱油或白糖，每日1剂。

20. 多发性硬化症

多发性硬化症是神经系统的一种病变（脱髓鞘疾病），病因尚未阐明，多数学者认为与感染、外伤、过度劳累、情绪改变及免疫功能异常有关。其病理特点在神经系统任何部位（神经、脊髓和脑内）可留下散在性的多处脱髓鞘硬化斑块，故命名为多发性硬化症。临床上可出现多种多样的神经症状。在疾病早期，患者的症状可以完全缓解，但间歇不久又可复发，反复发作终至病情恶化。这种缓解、复发、再缓解、再复发的过程，就是多发性硬化症的特征。

多发性硬化症好发于10~50岁，在中枢神经系统中至少有2个以上的部位病变存在，病程较长，不能用其他病因解释其神经障碍。

本病始发症以视力障碍（球后视神经炎）、眼球震颤、肢体疼痛为最多见，依次出现肌力减退，下肢易拌跌，肢体瘫痪，不能行走，下肢感觉消失或有蚁行感，患肢痉挛强直，日久多伴肌萎缩，腰部束带状疼痛麻木。

精神症状以欣快感较为多见，情绪易于冲动，语言障碍，发音不清，眩晕，眼球震颤，吞咽困难，呼吸困难，尿频尿急，尿失禁或尿潴留。检查患者脑脊液压力和外观正常，20~80%脑脊液中淋巴细胞轻度或中度升高，蛋白正常或轻度增多。有的多发性硬化症患者进行热水浴后则症状加重，冷水浴后则症状减轻。

多发性硬化症属于祖国医学的“痿证”、“风痹”等范

畴。中医认为多由于精气匮乏，肝肾不足，阴精亏损，肝失所养，精气不能上荣于脑，脑髓失养所致。精藏于肾，肾主骨生髓，通于脑，肾乃精、髓、脑三者生成的源泉。张锡纯说：“肾为髓海，……究其本源，实为肾真阴真阳之气酝酿化合而成……，缘督脉上升而灌注于脑。”《万病回春》说：“痿者，上盛下虚，能食不能行也。痿主内伤，血气虚损，……不可误作风治，且风为外感，痿为内伤。”《三因极一病证方论》说：“夫人身之有皮毛、血脉、筋膜、肌肉、骨髓，以成形。内则有肝、心、脾、肺、肾，以主之。若随情妄用，喜怒不节，劳佚兼并，致内脏精血虚耗，荣卫失度，……使皮血、筋骨、肌肉萎弱无力以运动，故致痿躄。……脏气不足之所为也。”

多发性硬化症的治疗，宜益气养血，滋补肾精，化瘀通络。

中药治疗

（一）辨证分型治疗

1. 肝肾阴虚型：视物不清，头晕目眩，眼球震颤，走路不稳，构音不清，肢体疼痛麻木，舌红无苔，脉细数。治宜滋肾柔肝。

方药：黄精30克，当归20克，白芍30克，枸杞15克，山萸30克，熟地20克，山药30克，鹿角胶10克（烊服），淮牛膝30克，菌灵芝30克（先煎），桑椹15克，制首乌30克，杜仲15克。水煎服，每日或隔日1剂，连服40~60剂。

2. 肾阳虚衰型：下肢瘫痪，肢体麻木不仁，手部动作笨拙，畏寒肢冷，尿频尿急尿失禁。治宜温补肾阳。

方药：仙灵脾30克，仙茅10克，鹿角胶15克（烊服），肉苁蓉15克，菟丝子15克，菌灵芝30克，补骨脂15克，龟板

30克，制附片15克（先熬），肉桂6克，桑螵蛸30克。水煎服，每日或隔日1剂，连服40～60剂。

3. 气滞血瘀型：肢体疼痛麻木，走路不稳，不能站立，面肌痉挛，排尿困难，唇舌青紫，脉弦涩。治宜活血化瘀。

方药：黄芪90克，地龙30克，赤芍15克，当归30克，川芎10克，桃仁12克，红花12克，桔梗12克，枳壳10克，川牛膝30克，丹参30克。水煎，放冷服。每日或隔日1剂，连服40～60剂。

（二）专方治疗

方一：河车大造丸（成药），每次服1丸，每日服3次。连服3个月。

方二：人参鹿茸丸（成药），每次服1丸，每日服2次。连服3个月。

方三：熟地30克，麦冬15克，山萸30克，黄精30克，肉苁蓉15克，枸杞15克，巴戟天15克，菟丝子15克，茯苓15克，五味子10克，石菖蒲10克，远志10克，制附片10克，肉桂6克，炙甘草6克。水煎，放冷服。每日或隔日1剂，连服40～60剂。

方四：当归30～90克，（开始用30克，后逐渐增至90克），黄芪30克，熟地30克，山萸30克，苡仁30克，丹参30克，杜仲15克，补骨脂15克，甘草10克，水蛭6克。水煎服，每日或隔日1剂，连服40～60剂。

方五：黄芪90克，巴戟天25克，狗脊30克，寄生30克，续断30克，枸杞15克，木瓜30克，覆盆子15克，生地20克，龟板胶15克（烊服），桂枝15克，白芍60克。水煎，放冷服，每日或隔日1剂，连服40～60剂。

方六：僵蚕10克，全蝎10克，地龙30克，威灵仙30克，

猪苓30克，制首乌30克，黄芪60克，当归30克，白芍60克，川芎15克，枸杞30克，生地30克。水煎，冷服。每日或隔日1剂，连服40~60剂。

针灸治疗

取穴：睛明，攒竹，印堂，肩髃，曲池，合谷，内关，肾俞，命门，足三里，阳陵泉，阴陵泉，关元，中极。

每次任选5~6穴针刺，留针30分钟，每5分钟行针1次，每日针刺1次。

推拿治疗

（一）推攒竹法：患者仰卧，医者以两手拇指甲置眼内眦上方攒竹穴处施行掐法后，再以两拇指掌侧分置两目内眦沿眉弓向外方摩动至太阳穴止，反复操作5~10分钟。

（二）揉风池法：患者直坐，医者以一手扶定其前额部，另一手拇、食指分置颈项两侧之风池穴处，指揉3~5分钟，再以手四指掌侧自枕部左或右侧之脑空穴起，自上向下经风池至肩部之肩井穴处止，两侧反复摩动3~5分钟。

（三）背部分推法：患者俯卧，医者站其头部前方，医者以两手拇指分置脊柱两侧大杼穴平高处，其余四指置其两侧，自内向外下方沿背部肋间隙分推至腋中线止，自上向下至胃俞穴平高处止，反复操作5~6分钟。分推时，患者应自由呼吸，操作者手法宜轻柔、均匀而着力。

（四）腰横摩法：患者俯卧，腹部可稍垫高，医者以手掌部置于腰部一侧之肾俞、气海及大肠俞穴处，先向内摩动至带脉穴处，然后再向前摩动至对侧带脉穴止，反复横摩5~6分钟。摩腰时，手掌应密切接触腰部皮肤，随腰部形态而改变着力点，即向内摩动时手指宜用力，向前摩动时手掌宜用力。

(五)推上臂三阴法:患者仰卧,左或右上肢平放于床上,手掌向上,医者坐其侧,操作分以下三个步骤进行:

①医者以两手拇指掌侧对置于腋前天泉穴处,两手其余四指扶定上肢,自上向下推动至曲泽穴止,反复操作5~6分钟。②以两拇指对置于天府穴处,自上向下经侠白至尺泽穴止5~6分钟。③以两拇指对置于极泉穴下,自上向下经青灵至少海穴止,反复操作5~6分钟。

(六)股上下刨推法:患者侧卧,左或右下肢屈起,另一下肢伸直,医者以一手拇指置股上方后侧,其余四指置前侧,自髀关穴平高处向下刨推;另一手拇指置股骨下方前侧,余四指置其后方,自梁丘穴平高处向上刨推,待两手刨推接近时,再以两手并置,两手拇指置股后侧,两手四指置股前侧,将大腿肌向上拿提,操作5~10分钟。刨推时,主要为拇、食指关节合成之“虎口”处掌侧用力,拿提时以各指端之掌侧着力。上下刨推可适用于股前、后、内、外侧,视病情需要而定。用力大小以患者能耐受为度。如患者皮肤干燥,可蘸酒或使用滑石粉,以防止擦伤皮肤。

21. 咳嗽晕厥综合征

咳嗽晕厥综合征是临床上较为少见的症候群,是紧接咳嗽而发生的短暂晕厥,预后良好。但亦有因晕厥而致伤致残者。其诱因有:①服药呛咳后引起晕厥。②灌肠呛咳后引起晕厥。③气管炎咳嗽后引起晕厥。患者首先是剧咳,然后晕倒,醒后无任何不适。剧咳时坐下或蹲下可避免摔伤。

现代医学认为咳嗽晕厥综合征是由于长期剧咳引起胸腔内压力增高，妨碍静脉回流，使心脏输出量减少，导致脑暂时缺血而发生痉挛。也有学者认为剧咳使脑脊液压力增高，脑细胞突然去极化，以致产生脑震荡而晕厥。或由食道胃反流引起喉头痉挛所致窒息而引起晕厥。

咳嗽晕厥综合征属于祖国医学“痰厥”范畴。中医认为系气机逆乱，升降失常，气血阻滞，以致清窍暂闭，发为晕厥。也可由于气虚血瘀所致。气虚则清阳不升，气陷于下，血不上达，以致精明失养而致晕厥；血瘀则脉络不畅，痰瘀内蕴，相互搏结，致气机乖逆，上蒙神明，清窍不利而为厥。治宜活血化瘀，豁痰通窍。

方药：桃仁12克，红花12克，川芎12克，赤芍30克，陈皮10克，法半夏10克，胆南星10克，麝香0.2克（冲服），钩藤30克，葱白3枚，僵蚕10克，黄酒20毫升，加水适量同煎，饭前服。每日1剂，连服20~30剂。

22. 椎管狭窄症

椎管狭窄症是神经外科疾病之一，临床以脊神经根或脊髓压迫症状为主要表现，尤以马尾神经受累症状最为多见。症状为腰骶疼痛剧烈，入夜尤甚，下肢麻木酸胀，屈伸不利，脊柱后伸受限，喜热恶凉。患者可出现间歇性跛行。

椎管狭窄症分为先天性腰椎管狭窄、退行性改变所引起的椎管狭窄和局限性椎管狭窄三种类型。临床常见的是因腰椎的退行性改变，致椎板、黄韧带增厚，关节突增生肥大并

突入椎管内：椎管后缘唇样骨赘以及椎间盘后突改变，致使椎管前后径、侧方隐窝或椎间孔缩小，造成相应的神经根受压、缺血，产生了一系列临床症状。

椎管狭窄症可通过X线检查确诊（腰椎管变窄，腰椎骨质具有不同程度的增生）。

椎管狭窄症属于祖国医学的“痛痹”、“腰痛”范畴。中医认为系肾气不足、风寒入侵所致。《诸病源候论》说：“肾气不足受风邪之所为也，劳伤则肾虚，虚则受于风冷，风冷与真气交争，故腰脚痛。”属正虚邪实之候。治宜扶正祛邪，温经散寒，除湿止痛。

中药治疗

（一）分期治疗

1. 急性发作期：腰部剧痛，不能转侧，行走困难，遇寒痛剧，得热则缓。治宜散寒止痛。

方药：当归30克，赤芍30克，独活12克，麻黄6克，秦艽15克，川芎10克，制川乌10克（先熬），乳香10克，没药10克，地龙15克，威灵仙15克，川牛膝30克，木瓜30克，三七粉6克（冲服），甘草6克。水煎服，每日1剂，连服30～50剂。

2. 缓解期：腰腿酸软，绵绵隐痛，疲劳较甚，不耐久立运行，治宜补肾壮腰。

方药：黄芪30克，党参30克，杜仲15克，川芎10克，苡仁30克，当归30克，续断30克，狗脊30克，淮牛膝30克，千年健30克，独活10克，骨碎补15克，补骨脂15克。水煎服，每日1剂，连服30～50剂。

（二）基本方治疗

方药：制川乌10克（先熬），制草乌10克（先熬），黄

芪30克，麻黄6克，木瓜30克，续断30克，狗脊30克，白芍30克，桃仁15克，土鳖虫15克，蜈蚣2条，甘草10克。水煎服，每日1剂，1个月为1疗程。

针刺治疗

取穴：大肠俞、关元俞。

用10厘米长针垂直深刺，抵达横突表面，然后自横突表面退针少许，作 25° 角向上或向下刺，再偏向内约 20° 角，自横突表面深1.5厘米可达椎间孔，获得触电感后留针5分钟，隔天针刺1次。

按摩治疗

（一）按揉环跳法：患者侧卧，左或右下肢屈曲。医者坐其侧，以两手拇指掌侧对置于臀部环跳穴处，用力按揉，根据患者耐受情况徐徐增加压力，其余四指分置臀部的两侧处。两拇指按揉3~5分钟。

操作时应先嘱患者臀部肌肉放松，两拇指按揉用力应均匀一致，用力大小以患者能耐受为度。

按揉时有酸、胀、麻及电流样热感自臀部放射至小腿及足趾。治疗后下肢有温热的感觉。

（二）揉骶髂法：患者取低头弯腰姿势，两上肢下垂。医者以手握拳自骶部胞育穴起，微斜向内下方至白环俞穴止，拳揉3~5分钟。

拳揉动作应自上而下，用力大小以局部微红为度。操作时有局部微胀及微痛感，治疗后局部有温热感及腰腿舒适的感觉。

（三）横摩骶法：患者俯卧，医者坐其侧，以手四指及掌置左或右侧臀部胞育穴处，自一侧经八髎穴至对侧胞育穴处止，反复摩动5~10分钟。

操作时手掌应紧紧接触皮肤。掌摩时应随臀部外形而改变力量，如向前推动时，指端应稍放松，掌部着力，向后摩动时则相反。摩动用力以局部皮肤微红为度。

（四）推臀法：患者侧卧，左或右下肢屈起。医者坐或站其侧，以手指掌侧自左或右侧臀部上方脊柱旁之小肠俞开始向下经胞育穴斜推至环跳穴，并按压停留在环跳穴处，用一手拇指掌侧再置小肠俞，经胞育斜推至臀下外侧，待推至环跳穴并进行按压时，原按该穴之拇指即行离开。如此反复推动3~5分钟。

每次指推均须着力，交叉推动经过臀部时，以皮肤微红为度。操作时患者有局部酸胀及沉重感。治疗后局部有温热及轻快的感觉。

（五）股外侧刨推法：患者侧卧，左或右下肢屈起，另一下肢伸直。医者坐其侧，以拇指置股上方前侧，余四指置股后方，自臀部环跳穴平高处向下经风市、阳关、阳陵泉至悬钟穴止，刨推3~5分钟。

刨推时指掌侧及掌根均需着力，体弱者可用掌心着力。大腿部用力应较小腿为重。

23. 面部单侧味觉神经性多汗症

面部单侧味觉神经性多汗症，多因头部及颈部附近交感神经受损，受损交感神经恢复时和副交感神经错综连接，刺激味觉反射弧，使受损的交感神经所支配的部位多汗。

临床表现：患者每当进食2~4分钟开始出汗，5~6分钟

开始有汗珠滴下，出汗部位多局限于左侧。无论干食、冷食、热食同样出汗，甚至只要有咀嚼动作就出汗。发作与季节无关，严寒季节同样出汗，身体其他部位无汗，且不觉热。患者面部外观无异常，触觉、温觉、痛觉均正常。

祖国医学认为本病多系阴阳失调、营卫不和所致。先天不足，阳气虚损，腠理不固，皮毛疏泄失常，致津液外泄。治宜调和营卫，固表止汗。

方一：白芍60克，桂枝15克，生龙骨30克，生牡蛎30克，五味子15克，炙甘草10克。水煎服，每日1剂，连服30~50剂。

方二：黄芪30克，防风10克，细辛3克，甘草10克，白芍60克，桂枝15克，干姜10克。水煎服，每日1剂，连服30~50剂。

24. 焦虑性神经症

焦虑性神经症又称焦虑症。人们在预期到要发生某种不利情况而又难于应付时，就要发生焦虑，因此大部分的焦虑都属于正常范围。只有当没有明显的原因发生焦虑或原因很轻而焦虑很重时，才可诊断为焦虑症。

焦虑性神经症的许多症状主要通过交感神经的兴奋表现出来。急性焦虑性神经症发作时血中肾上腺素含量增高。

焦虑性神经症可以缓慢发病，也可突然急性发病。

临床表现：1. 急性焦虑性神经症：表现为急性惊恐的发作。这种发作常突然而来突然而去，病人自己也搞不清它怎样发起来怎样好的。有时会在睡梦中突然发作。发作

时病人有一种说不出的恐惧感，好象濒临一种十分危险的情景，马上就要死亡一样。此时心脏剧烈跳动，“心脏撞击胸壁”，心前区疼痛（心电图无异常）。伴有胸闷，感到“透不过气来”。发作时常要突然开窗或到室外去作深呼吸以解除此症状。有时因深呼吸呼出过多的二氧化碳，引起呼吸性碱中毒，产生手指（有时延及脚趾、口周围）刺、麻感，并有头胀，这些感觉又可加重原先的焦虑。除上述症状外，急性焦虑症发作时常有头晕、晕厥、出冷汗、手抖等症状。有的病人还有胃肠道症状。焦虑症发作时病人处于极度惊恐状态，无暇他顾，可产生继发的精神症状，严重时意识模糊，发作时一般持续数分钟或数十分钟，发作过后症状完全消失。由于发作时十分痛苦，病人常担心下一次的发作，有时出现继发性的焦虑。

2. 慢性焦虑性神经症：症状表现多种多样，如心烦意乱，心惊肉跳，失眠，有的病人虽呼呼大睡，但醒来却说没睡着而诉说长期“失眠”，但周围人却觉得他睡得很好而不予同情，因而病人更加痛苦。病人还可有上腹不适，胃胀，便秘，消化不良等症状，或尿频，阳痿，或闭经，头痛，项背痛，手脚心出汗，口干，自感双手颤抖（实际并不颤抖）。注意力不集中。

慢性焦虑性神经症虽有很多躯体症状，但查不出阳性体征，有的病人可能有一过性的心电图轻度异常。

所以，焦虑性神经症的诊断应根据以下三点：①以焦虑为中心症状；②查不出相应的其他疾病的体征；③仔细询问可找出一些有关的精神因素。

焦虑性神经症属于祖国医学的“郁证”范畴。《明医指掌》说：“夫人之气血冲和，百病不生，一有抑郁，诸病生

焉。故人之诸病，多生于六郁。盖郁者，结聚而不得发越之谓。”《张氏医通》说：“郁症多缘于志虑不伸，而气先受病。”中医认为，肝气最喜条达，一遇忧郁之事，则涩滞而不可解。《临证指南医案》说：“七情之郁居多，如思伤脾，怒伤肝之类是也。其原总由于心。因情志不遂，则郁而成病矣。”大凡焦虑过度，即中医所指之思虑伤脾，而成郁证。治宜理气开郁，疏肝健脾，宁心安神。

（一）辨证分型治疗

1. 痰瘀互结型：目光呆滞，反应迟钝，注意力不集中，喉头似有物堵塞，焦虑愁悴，目眶青暗，胸闷痛。舌暗，苔薄，脉弦涩。治宜涤痰解郁，活血化瘀。

方药：菖蒲15克，郁金30克，远志10克，香附15克，丹参30克，桃仁12克，陈皮10克，姜半夏12克，茯苓15克，胆南星10克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服两个月。

2. 心阴虚型：心悸，健忘，失眠，焦虑，自感大难将临头，惶惶不可终日，五心烦热，舌红无苔，脉细数。治宜养心安神，解郁。

方药：郁金30克，茯神15克，菖蒲10克，远志10克，龙齿30克，珍珠母30克，磁石45克，刺五加30克，五味子15克，合欢皮15克，麦冬15克，太子参30克，菌灵芝30克。水煎服，每日1剂，连服两个月。

3. 肝郁气滞型：胁肋胀痛，焦虑时作，烦躁，失眠，善太息，舌淡红，苔薄，脉弦。治宜疏肝解郁。

方药：柴胡15克，白芍30克，当归15克，白术15克，茯苓15克，郁金30克，香附15克，玫瑰花10克，绿萼梅10克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服两个月。

（二）专方治疗

方药 龙齿30克，磁石60克，酸枣仁30克，刺五加30克，菌灵芝30克，炙远志15克，菖蒲15克，郁金30克，甘松15克，合欢皮15克，甘草10克，琥珀末10克（冲服），柴胡15克。水煎服，每日1剂，连服两个月。

针灸治疗

（一）体针取穴：风池、风府、百会、神门、内关、三阴交、合谷、膻中、血海、心俞。得气后留针30分钟，中间行针2次，每日针刺1次。每次任选4~5穴。

（二）耳穴：皮质下，神门，脑点。

娱乐疗法

有意识安排患者参加一些娱乐活动，如看喜剧，到风景区旅游，跳舞，听轻音乐等，以分散患者的注意力。

心理治疗

耐心向患者解释，焦虑性神经症不是器质性病变，而且可以治好。最好找已经治好的病人作现身说法，更能帮助患者树立信心，使疾病向痊愈的方向转化。

25. 良性性交时头痛

良性性交时头痛在临床上并非罕见，但由于患者讳疾忌医，不愿向医生诉说真实病情，或只是诉说平时有头痛症状，故易造成漏诊。

当性交达到性高潮时，因出现头痛而不得不中止性交，但又查不出任何器质性病变因素，称之为“良性性交时头痛”。

本病可由于中枢神经高度兴奋引起。当安静时症状可消失。疼痛剧烈时可伴有恶心。诱发因素有肥胖、高血压、精神刺激，缺乏运动等。男女均可罹患此病，但以男性为多见。头痛只在性高潮时出现。发病年龄多在30~60岁之间。由于本病对患者造成恶性刺激，使患者焦虑不安，故须积极治疗。

中医认为，头为诸阳之会，精明之府，五脏精华之血，六腑清阳之气，皆上会于此。脑海清灵则神清志爽，若情志刺激，过度兴奋，颅内外血管舒缩障碍，神经调控失常，气机阻滞，脑络痹阻，气血运行不畅，清浊相干，发为头痛。治宜止痛解痉，活血通络。

中药治疗

方药：白芍60克，甘草10克，当归30克，细辛6克，川芎15克，白芷10克，牛蒡子20克，柴胡15克，苍术15克，羌活10克，蔓荆子10克。水煎服，每日1剂，连服20~30剂。

针灸治疗

取穴：印堂，太阳，风池，列缺，合谷。得气后留针30分钟。每日针刺1次。

26. 末梢神经炎

末梢神经炎的发病机理尚不明了。目前认为系由多种疾病（包括糖尿病、口服轻粉中毒、超量服用痢特灵等）所致的末梢神经退行性改变。

临床表现：四肢或手指、脚趾麻木（手套式感觉障碍）、肿痛，皮色紫暗。严重者双侧手足肌肉萎缩和指、趾屈曲畸形。

末梢神经炎属于祖国医学的“血痹”、“痹证”范畴。中医认为多因感受风寒，邪气壅阻脉络，气血运行不畅，导致四肢麻木疼痛，活动受限。治宜益气养血，活血通络。

内治法

（一）辨证分型治疗

1. 痰滞经络型：四肢麻木刺痛，体胖，痰多色白。舌淡苔厚，脉滑数。治宜祛痰通络。

方药：陈皮10克，法夏10克，茯苓30克，姜黄15克，白芥子10克，桑枝30克，路路通30克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服20~30剂。

2. 血不养筋型：高热后即感四肢如戴手套、袜子样麻木，瘙痒如蚁行，上肢较甚，右手更明显。冬天接触冷水后即麻痒疼痛，面色萎黄，指甲色白，舌淡苔薄脉虚弱。治宜补血养筋。

方药：黄芪50克，当归30克，熟地30克，川芎12克，赤芍30克，桑枝30克，姜黄10克，络石藤30克，鸡血藤30克。水煎服，每日1剂，连服20~30剂。

3. 脾胃虚寒型：双手麻木无力，拿物无力易掉，语声低微，腹胀，便溏，四肢不温，舌淡苔白脉细弱。治宜温中健脾。

方药：党参30克，干姜10克，白术15克，炙甘草10克，姜黄10克，桑枝30克，络石藤30克。水煎服，每日1剂，连服20~30剂。

（二）验方治疗

方一：白芍60克，制附片15克，甘草15克，鸡血藤30克，全蝎10克，当归30克，桂枝10克，防风10克，羌活10克，伸筋草30克，黄芪60克。水煎服，每日1剂，连服20～30剂。

方二：白芥子10克，黄芪50克，鹿角胶20克，熟地20克，当归20克，肉桂6克，炮姜10克，麻黄10克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服20～30剂。

加减：兼湿加苍术。血瘀加鸡血藤，风痰阻络加全蝎。

方三：苏木10克，僵蚕10克，茯苓30克，厚朴10克，陈皮10克，蝉蜕6克，防风10克，藿香10克，羌活10克，党参30克，黄芪30克，川芎10克，赤芍30克。水煎服，每日1剂，连服20～30剂。

外治法

方药：蛇床子30克，地肤子30克，黄柏30克，没药15克，苦参30克。加水3000毫升，煮沸10分钟，待温度适中时，泡洗患处15分钟，每日1剂。

本方外洗患处能消肿止痛，尤其对糖尿病所致的末梢神经炎疗效较好。

27. 股外侧皮神经炎

股外侧皮神经为感觉神经，从腹股沟韧带深面穿出后，即浅行至大腿前外侧区皮下。

股外侧皮神经炎又称感觉异常性股痛，是一种多方面原因引起的股外侧皮神经损害而产生的大腿前外侧皮肤感觉异常与疼痛综合征。患者单侧大腿前外侧皮肤麻木、疼痛或有

蚁行感，或有烧灼感，痛觉、温觉减退。患者大腿外侧有一感觉迟钝区。肌肉无萎缩，无病理反射引出。

股外侧皮神经炎属于祖国医学的“皮痹”、“肌痹”范畴。中医认为系营卫气虚，风寒湿邪乘虚而入，瘀血阻滞经络所致。《张氏医通》说：“皮痹者即寒痹也，邪在皮毛。”中医还认为，风寒湿三气杂至，合而为痹。治宜祛风除湿，散寒通络。

中药治疗

方药：黄芪90克，制首乌60克，白芍60克，桂枝15克，络石藤30克，海风藤30克，苡仁30克，桃仁15克，茯苓30克。水煎服，每日1剂，连服30～50剂。

针灸治疗

（一）体针：取穴血海、阿是穴。得气后留针30分钟，中间行针2次。每日针刺1次。

（二）梅花针：先确定感觉迟钝区面积大小，常规消毒后，使用梅花针扣刺，以轻度出血为度。

（三）双极磁镊针：在感觉迟钝区域内反复来回用磁镊针进行按压。双极磁镊针具有针灸、推拿、磁疗的综合效能，可用双极磁镊针在阿是穴周围多次按压。用力大小以患者能耐受为度。

走罐治疗

确定感觉迟钝区域后，用医用凡士林均匀涂敷局部体表，取中号玻璃火罐一只，用闪火法吸住患处后，双手握住罐底，着力于后方，缓缓向前推动。一般先从膝盖上方梁丘穴开始，将罐推至腹股沟下沿，再相反使力，往下走罐至膝盖上方梁丘穴处，来回约5～10次，使患处皮肤潮红，间有紫黑色瘀点为度。隔3天治疗1次，4次为1疗程。需作

2~4个疗程。

走罐疗法对改善末梢神经的血液供应及间接促进神经细胞机能恢复有一定作用。这种治疗方法简便验廉，值得推广使用。

28. 桡神经麻痹

桡神经麻痹是上肢周围神经损伤中的常见病之一。主要由于炎症、骨折、神经纤维瘤、铅中毒、外伤、腋窝拐杖压迫、睡眠姿势不当（上臂压于体下）等所致。

临床表现：腕下垂，上肢各伸肌瘫痪，肘、腕、掌、指关节均不能伸直，握力减退，前臂伸直时不能旋后。

桡神经麻痹属于祖国医学的“痿证”范畴。中医认为多由外伤造成气滞血瘀，气血运行不畅，经络阻遏，筋脉失养所致。《七松岩集·常见病证辨治》说：“痿之与痹，二证天渊不同。痿本虚证，有补无泻，……并无痛楚也。若痹证者，因风寒暑湿之气，合而为痹，有泻无补，……痹病在表，……痿症在里，属精神气血之不足，……由气血不得充周之故。”

桡神经麻痹的治疗，宜益气养血，活血通络。

中药治疗

（一）辨证分型治疗

1. 气血两虚型：除桡神经麻痹症状外，面色不华，乏力，气短懒言，睑结膜苍白，舌淡苔白，脉细弱无力。治宜益气补血。

方药：制首乌60克，熟地30克，当归30克，赤芍30克，川芎10克，党参30克，白术15克，茯苓15克，炙甘草10克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

2. 气滞血瘀型：除桡神经麻痹症状外，兼见舌质紫暗有瘀斑或瘀点，脉弦涩。治宜活血化瘀。

方药：桃仁12克，红花12克，当归30克，熟地30克，赤芍15克，川芎10克，三棱10克，莪术10克，白芍60克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

(二) 专方治疗：

方一：黄芪90克，桂枝15克，桃仁12克，茯苓15克，仙灵脾30克，寄生30克，白芍30克，钩藤30克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

方二：制首乌60克，白芍60克，黄芪60克，当归30克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

针灸治疗

(一) 体针：

1. 取穴：曲池，手三里，外关，中等刺激，留针30分钟。

2. 取穴：太渊，合谷，肩髃，通里，神门，内关。留针30分钟。

(二) 耳针：

取穴：神门，肘，腕，指。

29. 氟骨症

氟骨症是由于摄入过量的氟累积造成的中毒，是氟对骨

及骨旁组织损害后，导致骨与骨旁组织形态、结构及功能异常，继而引起一系列继发性改变的疾病。过量的氟进入机体后，与血钙结合成氟化钙，沉积在骨组织中，使骨质硬化，骨皮质增厚，脊柱椎间孔和椎管变窄而压迫神经，引起一系列症状。

临床表现：疼痛，手足抽搐，麻木，乏力，肢体紧硬感，关节变形，甚至瘫痪。患者多有氟斑牙，软组织僵硬，关节活动受限，四肢脊柱畸形，展臂试验阳性，下蹲困难。检查血氟、尿氟含量均增高。氟骨症通过X线检查可确诊。

氟骨症属于祖国医学的“痿证”范畴。中医认为本病系氟毒损害肝肾所致。肝主筋，肾主骨，肝肾受损，筋骨失其濡养，关节变形乃至瘫痪痿废不用。治宜滋补肝肾，强筋壮骨。

方一：骨碎补30克，补骨脂30克，肉苁蓉30克，熟地30克，鸡血藤60克，乳香15克，没药15克，全蝎15克，蜈蚣6条，炙马钱子粉10克，甘草20克，续断60克，当归30克，枸杞30克，共研细末，混合均匀，每次口服1~3克，每日1次。由小剂量开始服用，始则每日服1克，逐渐加量至每日3克，连服3个月。

方二：硼砂，每次口服1.5克，每日服3次，开水送服。连服3个月。

硼砂有去垢解毒的作用，硼在体内可与氟形成牢固的络化物，这种络化物可以从尿液中排出，从而达到解除氟毒之目的。

30. 化脓性关节炎

化脓性关节炎是关节内受化脓性细菌感染所致的一种骨科病。儿童多见，急性发病。

本病的感染途径多为细菌由身体其他部位的化脓性病灶，经血液循环传播所致。少数可由外伤创口直接感染，或由附近的骨髓炎直接蔓延所引起。以膝、髋、肘、肩、踝关节发病为多，常单个关节受累。

临床表现：高热，全身不适，病变关节红肿热痛，活动明显受限，呈屈曲畸形。病变关节可抽出混浊性、脓性液体。周围血化验检查，白细胞总数及中性白细胞均可升高，血沉增快。本病可通过X线检查等确诊。

化脓性关节炎属于祖国医学的“关节流注”和“骨痹疽”等范畴。《外科理例》说：“大抵流注之症，多因郁结或暴怒，或脾虚湿气逆于肉理，或腠理不密，寒邪容于经络，或闪扑，或产后，瘀血流注关节，或伤寒余邪未尽为患，皆因真气不足，邪得乘之。”中医认为化脓性关节炎多由正气不足，邪毒壅滞关节所致。邪之所凑，其气必虚。若机体抗病能力旺盛，则邪毒不易为患，一旦正气虚弱，感受暑湿邪毒，则邪毒容于营卫之间，阻于经脉肌肉之内，与气血相搏，流注于关节。或因痈疔疮疖之邪毒直接侵犯筋脉肌肉，或因挤压、碰撞，邪毒走散，流注于关节。或跌扑闪挫，瘀血停滞，郁久化热成毒，邪毒凝于关节。其治疗，宜清热解毒。利湿化瘀。

分期治疗

(一) 初期: 全身不适, 恶寒发热, 食欲减退, 乏力, 病变关节红肿热痛, 舌红苔薄黄, 脉数。治宜清热解毒。

内治方药: 青蒿30克(后下), 黄芩30克, 黄连10克, 栀子10克, 银花30克, 当归30克, 夏枯草30克, 赤芍30克, 丹皮15克, 桃仁12克, 桂枝10克。水煎服, 每日1剂, 连服20~30剂。

外治方药: 大黄30克, 黄柏30克, 姜黄30克, 白芷30克, 生南星20克, 陈皮20克, 苍术20克, 天花粉90克, 共研细末, 用葱汁调敷患处, 每日换药1次。

(二) 酿脓期: 上述症状进一步加重, 寒颤, 高热, 体温可达40~41°C, 病变关节红肿剧痛, 彻夜难以入睡, 病变关节畸形, 不能活动。关节穿刺出的脓液有脓球。治宜清热解毒, 凉血利湿。

内治方药: 银花60克, 连翘30克, 蒲公英30克, 紫花地丁30克, 野菊花15克, 黄连10克, 黄芩30克, 栀子10克, 生地30克, 丹皮15克, 水牛角屑30克。水煎服。每日1剂, 连服20~30剂。病情严重者加服安宫牛黄丸。

外治方药: 同初期。

(三) 脓溃期: 全身症状如同酿脓期, 局部红肿热痛更加明显。最后, 脓肿穿破皮肤而外溃, 形成窦道, 经久不愈, 全身急剧症状减退, 但更加乏力和虚弱, 面白无华, 脉细数, 舌淡苔白。治宜托里透脓。

方药: 黄芪60克, 党参30克, 蒲公英30克, 败酱草30克, 苡仁30克, 白术15克, 茯苓15克, 当归30克, 熟地30克, 川芎10克, 赤芍15克。水煎服, 每日或隔日1剂, 连服20~30剂。

31. 肩关节结核

肩关节结核是一种比较少见的骨关节结核。发生于20~30岁的成年人。初发病灶多数在肱骨头。发生在肱骨头的结核病灶，以肉芽组织增生为主，渗液很少，常无脓肿形成，所以又称“干性结核”。发生在滑膜的结核病灶，渗液较多，可产生脓肿。初发病灶如未能控制，进一步发展即形成全关节结核。

临床表现：肩关节疼痛，功能障碍，低热，盗汗，肢体困倦。可经X线检查确诊。

肩关节结核属于祖国医学的“骨痹”、“虚劳”范畴。感染结核杆菌的患者，骨或关节扭伤、挫伤、气血瘀滞，或风寒湿邪侵袭、经络阻塞等造成局部抵抗力降低，结核杆菌由原感染灶经血液循环流注于肩结聚为患，腐筋蚀骨而成本病。中医还认为，肾主骨，脾主肌肉四肢。骨痹盖由先天肾亏，精血不足，或后天脾虚，水谷运化不利，气血精微生化无源，骨失所养，痰浊凝聚，或跌扑损伤，气血失和，痹邪乘虚而入，留于骨骼，侵蚀骨质，致骨损络阻而成疾。治宜清热解毒，杀虫化湿。

分期治疗

(一) 初期：骨关节内虽有病变，但外形和症状并不明显，局部不红不热，亦无肿胀，仅感患处隐隐酸痛，劳累后加重，休息后减轻。继而关节运动受限，不能上举和外旋，穿衣不便，肩部肌肉呈进行性萎缩。治宜清热解毒。

方药：地骨皮30克，鳖甲15克，白芷10克，银花30克，连翘30克，蒲公英30克，紫花地丁30克，皂刺15克，炮山甲15克，苡仁30克，乳香10克，没药10克。水煎服，每日1剂，连服30～40剂。

（二）中期：疼痛加剧，功能障碍明显。脓腐穿破关节囊，流注于腋窝下或肩后方、三角肌前缘或肩胛下缘，形成不易破溃的寒性脓肿。肩关节各方向活动均有不同程度的受限。治宜祛湿解毒，托里透脓。

方药：败酱草30克，黄芪60克，苡仁30克，白芥子12克，肉桂6克，熟地30克，银花30克，连翘30克，炮姜10克，蒲公英30克，夏枯草30克，百部15克。水煎服，每日1剂，连服30～40剂。

（三）后期：寒性脓肿穿破皮肤而外溃，形成窦道，时流清稀脓水或腐物，久不收口。治宜解毒生肌。

方药：黄芪60克，当归30克，苡仁30克，银花30克，乳香10克，没药10克，连翘30克，黄柏15克，骨碎补10克，煅龙骨30克，鹿角霜10克（冲服），蜈蚣2条。水煎服，每日1剂，连服30～40剂。

验方治疗

方一：红参粉5克（冲服），白术15克，黄精30克，百部15克，枸杞15克，菟丝子15克，黄芪60克，银花30克，紫花地丁30克，龟板30克，制首乌30克，龙眼肉10克，皂刺15克，炮山甲15克，黄柏15克。水煎服。每日1剂，连服30～40剂。

方二：干燥乌梢蛇，去头皮，研成细末，黄酒冲服，每次服3克。每日服3次。连服6周为1疗程。久不收口加煅龙骨粉3克，鹿角霜3克，每日服3次，与乌梢蛇粉同服。

32. 创伤性关节炎

创伤性关节炎是因创伤而引起的关节面不平整，负重失衡，关节软骨发生退行性改变，关节疼痛，功能障碍。本病多发生于青壮年，患者均有明显外伤史。

临床表现：病变关节疼痛，功能活动受限，过度活动则关节疼痛加重，休息后则减轻。严重者肢体肌肉萎缩，关节肿大，或关节腔积液。创伤性关节炎与退行性骨关节病颇为相似，但退行性骨关节病多发生于中老年人，且无外伤史，可资鉴别。

创伤性关节炎属于祖国医学的“骨痹”范畴。《金匱要略》说：“千般灾难，不越三条，一者，经络受邪，二者，……血脉……壅塞不通，三者，……金刃……所伤……。”

《三因极一病证方论》认为跌打损伤为致病的“不内外因”（六淫侵袭为外因，情志所伤为内因，跌打损伤则为致病的不内外因）。外伤引起的创伤性关节炎属于跌打损伤引起的“骨痹”。其治疗，宜补虚续损，通络止痛。

辨证分型治疗

（一）损骨血凝型：患处肿痛，运动加剧，功能受限，乏力，气短懒言，自汗，舌暗红，有瘀斑，脉虚。治宜通络止痛。

方药：川芎12克，赤芍30克，当归30克，续断30克，桃仁12克，红花12克，淮牛膝30克，土鳖虫15克，炮山甲15克，乌梢蛇15克，乳香10克，没药10克，党参60克。水煎

服，每日1剂，连服30～50剂。

（二）体虚劳损型：关节畸形，隐痛酸重，面色苍白，头晕目眩，乏力，自汗，舌淡，苔白，脉虚。治宜补虚通脉止痛。

方药：鹿衔草30克，淮牛膝30克，补骨脂15克，仙灵脾30克，党参30克，白术15克，茯苓15克，甘草10克，当归30克，白芍30克，熟地20克，川芎10克。水煎服，每日1剂，连服30～50剂。

（三）阳虚寒凝型：久病伤肾，面色苍白，形寒肢冷，关节剧痛，遇寒痛增，腰膝酸冷，舌淡苔白脉沉迟无力。治宜补肾温阳止痛。

方药：黄芪60克，当归30克，桂枝12克，茯苓15克，川芎12克，制川乌10克（先熬），干姜10克，细辛6克，仙灵脾30克。水煎服。每日1剂，连服30～50剂。

针灸治疗

取穴：足三里，阳陵泉，阴陵泉，昆仑，悬钟，三阴交，肩髃，曲池，外关，合谷。

方法：进针得气后留针30分钟，中间行针2次。每次任选以上穴位3～4穴。每日针刺1次。亦可在以上穴位施用灸法。

推拿治疗

（一）拿股内肌法：患者仰卧或直立，两下肢伸直，医者以左或右手拇指及四指分别置于股内侧上方之阴廉、五里穴之前后，另一手扶定患肢，将股内肌肉捏紧并向上反复拿提3～5分钟。再以手扶定足踝部，另一手食指背屈按揉三阴交穴2～4分钟。操作中，拿提动作应有节律，用力由轻逐渐加重，以患者能耐受为度。

（二）揉膝上法：患者仰卧，两下肢伸直，医者一手拇

指及四指分置股部上方伏兔穴平高处，自上向下至膝关节上方作钳形揉捏1~2分钟，再以手握拳置膝上阴市、梁丘穴处，反复拳揉3~5分钟。

（三）膝周揉法：患者直坐，两下肢屈曲，医者以拇指掌侧指揉血海、阴陵泉、阳陵泉及内外膝眼穴处2~3分钟后，再以掌心置膝关节上，手指分置膝关节周围揉捏5~6分钟。揉动时，手指应一齐用力，频率应均匀一致。

（四）推前臂三阴法：患者直坐或仰卧，左或右上臂平放于床上或桌上，手法操作分以下三个步骤进行。

1. 医者以两手拇指掌侧对置于肘内曲泽穴处，其余四指扶定前臂，自上向下沿经前臂屈侧正中线经内关至大陵穴推动2~3分钟。

2. 使患者前臂微向桡侧倾斜，以两拇指掌侧对置自肘内尺泽穴处，由上向下推动沿桡侧外缘经孔最至太渊穴止2~3分钟。

3. 使患者前臂微向尺侧倾斜，以两拇指掌侧对置自肘尺侧出海穴处，由上向下推动沿尺侧缘至神门穴止2~3分钟。

以上操作时，患者上臂与前臂均应平放成一直线，推动时，两拇指用力应均匀，用力大小以皮肤微红为度。如患者皮肤干燥，可蘸酒进行推动。

33. 减压病

减压病是指机体在高气压环境下工作一定时间后，在转

向正常气压时，因减压速度过快，幅度太大，使机体组织和血液中原来溶解的气体释出，形成气泡，导致血液循环障碍和组织损害。减压病常发生于潜水作业或高压（沉箱、隧道、高压氧治疗舱）作业的人员。

临床表现：皮肤发痒，并有灼热感、蚁行感和出汗。皮肤贫血部分苍白，静脉瘀血部分呈蓝褐色，相互交错，形成地图样或大理石样斑块。气体在皮下组织积聚时，可形成皮下气肿。

四肢肌肉、韧带、骨骼、关节酸痛，重者呈针刺样、跳动样、撕裂样、刀割样，钻凿样剧痛，多为持续性。肢体活动明显受限。但局部无红肿和压痛。

X线检查可发现骨的典型变化。

患者常引起截瘫、运动功能障碍，排尿困难，排便困难，或大小便失禁。如脑部被气泡栓塞，可有眩晕、头痛、偏头痛、恶心、呕吐、抽搐、单瘫、偏瘫、甚至休克、昏迷伴眼球震颤、斜视、复视、视神经炎、失明、耳聋耳鸣、平衡失调。

患者脉搏细速，血压下降，心前区紧压感，皮肤及粘膜发绀，四肢发凉，浮肿。

呼吸系统症状有剧烈阵咳，咳血，呼吸困难，发绀，胸部压迫感，胸骨后疼痛或灼热感。

急性减压病可在减压过程中或减压后数小时内发病。如急性减压病未及时治疗，病程迁延日久，则成为慢性减压病。部分慢性减压病发生不可逆的器质性病变，则称为减压病后遗症。

中医认为减压病系风、寒、湿阻络和气滞血瘀所致，治宜理气，活血，祛瘀。

中药治疗

方一：防风15克，川牛膝30克，土鳖虫15克，当归30克，蜈蚣3条，炙马钱子1克，水煎服，每日1剂，连服10～50剂。

方二：草豆蔻10克，枳壳10克，槟榔10克，桔梗10克，当归30克，桃仁10克，沉香3克，黄芪30克，赤芍30克，党参30克，麦冬15克，五味子15克，丹参30克。水煎服，每日1剂，连服10～50剂。

针灸治疗

取穴：合谷，内关，曲池，列缺，足三里，阳陵泉，阴陵泉，三阴交，悬钟。

方法：进针得气后留针30分钟，中间行针2次。每次任选3～6个穴位，每日针刺1次。

34. 癌性疼痛

癌性疼痛是指各种癌症特别是晚期癌症引起的疼痛。

晚期癌症伴有疼痛的比例很高。疼痛主要是由于肿瘤局部浸润或沿血液循环、淋巴系统扩散转移引起区域神经受累或骨转移所致。其疼痛顽固持续而逐渐加剧，病人痛苦非常。对癌症镇痛剂的研究，是广大医务人员迫切关心的问题。

中医认为，肿瘤的形成，系邪毒内蓄，导致气滞血瘀，痰湿胶结而成症积。症积的增大和邪毒的浸淫，又可导致气机不畅，血行瘀滞，经络壅阻。癌灶浸润周围组织，或累及血管神经而引起癌性疼痛，即“不通则痛”。

肿块是癌症的主要表现，它的形成主要是气滞血瘀，痰火互结，湿毒积聚等原因所致。在正常情况下，人体脏腑、经络、肌肉之间的气血运行通畅，如果六淫七情之邪久留，气血积聚壅滞不通，迁延日久，即会形成痞块、积聚等症。随着癌肿的迅速生长，压迫或侵犯神经末梢或神经干，或并发梗阻、继发感染等原因，到了中晚期常出现进行性疼痛，甚至产生顽固、持续性剧痛。祖国医学对此解释为“不通则痛，通则不痛”。

癌性疼痛除了“不通则痛”（实痛）外，临床上还常可见到“不荣则痛”的虚性疼痛。

内治法

1. 颅内肿瘤疼痛（剧烈头痛）：

方一：僵蚕12克，莪术12克，三七粉10克（冲服），鸡内金15克，全蝎10克，石决明30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克，夏枯花30克，法半夏12克，天麻12克，白术15克，枸杞15克，蚤休30克，谷精草30克。水煎服，每日1剂，连服30~50剂。

方二：蜈蚣3条，土鳖虫12克，当归30克，川芎15克，赤芍30克，桃仁12克，红花12克，三棱15克，莪术15克，猪苓30克，白术15克，生地30克，菖蒲15克，泽泻30克，茯苓30克。水煎服，每日1剂，连服30~50剂。

方三：白花蛇舌草60克，野葡萄藤30克，半枝莲30克，蚤休30克，僵蚕15克，地龙15克，蝉蜕10克，海藻30克，夏枯草30克，麝香1克（冲服），牡蛎60克，白术15克，茯苓15克，陈皮12克，车前子10克。水煎服，每日1剂，连服30~50剂。

2. 肺癌疼痛：

方一：百合60克，生地30克，熟地30克，玄参15克，川贝15克，桔梗15克，麦冬30克，赤芍30克，鱼腥草30克，半枝莲30克，白花蛇舌草60克，当归30克，三棱12克，莪术12克。水煎服，每日1剂，连服30～50剂。

方二：山慈姑30克，败酱草30克，冬瓜仁30克，茜草12克，人参10克（嚼服），当归30克，赤小豆30克，白芨30克，蜈蚣3条，露蜂房18克，白花蛇15克。水煎服，每日1剂，连服30～50剂。

方三：天然牛黄1克（冲服），麝香1克（冲服），蜈蚣2条，山甲15克，琥珀10克，冰片1克，血竭6克，大黄15克，乳香10克，没药10克，川贝10克，乌梅15克，当归30克，苡仁60克，沉香3克（研末冲服），人参10克，黄芪60克，水煎服，每日1剂，连服30～50剂。

3. 食道癌疼痛：

方一：茯苓30克，猪苓30克，生半夏10克，生南星10克，三棱12克，莪术12克，姜黄12克，浙贝15克，砂仁10克，白花蛇舌草60克，半枝莲30克，土鳖虫20克，全蝎10克。水煎服，每日1剂，连服30～50剂。

方二：鲜半夏块茎适量，去外皮，捣成糊状为丸，每次服2克，置于舌根徐徐咽下。

方三：硃砂6克，黄芪30克，甘草10克。将硃砂捣碎，放入砂锅内加水浸泡10分钟，用武火煮沸20分钟，放入黄芪、甘草，文火煮沸30分钟，沉淀过滤，取汁服用。

4. 胃癌疼痛：

方一：鳖甲30克，瓦楞子30克，急性子10克，桃仁10克，红花10克，枳实12克，青皮12克，白花蛇舌草30克，卫

茅10克。水煎服，每日1剂，连服30~50剂。

方二：斑蝥一个，去翅，装入生鸡蛋内，封口，蒸熟，每日早晚各服斑蝥蛋一个。并配合服补中益气汤，每日1剂，连服30~50剂。

方三：白术15克，法半夏12克，木香15克，血竭6克，瓦楞子30克，水煎服，每日1剂，连服30~50剂。同时每日服用斑蝥鸡蛋2个（早晚各服一个）。

5. 肝癌疼痛：

方一：鼠妇虫60克，黄芪60克，党参30克，茯苓15克，白术15克，山甲15克，桃仁12克，丹参30克，苏木10克，蚤休30克，生牡蛎30克。水煎服，每日1剂，连服30~50剂。

方二：人参鳖甲煎丸（成药）每次服3克，每日服2次，同时服用斑蝥素片0.5毫克/日。连服30~50日。

方三：半枝莲30克，白花蛇舌草60克，石打穿30克，败酱草30克，乳香10克，没药10克，土鳖虫12克，郁金30克，蜈蚣2条，桃仁12克，当归30克，红藤30克，人参10克，甘草12克。水煎服，每日1剂，连服30~50剂。

6. 其他癌症疼痛：

（1）上颌窦癌疼痛。

方药：半枝莲30克，白花蛇舌草60克，石见穿30克，黄芩30克，黄连10克，生牡蛎30克。水煎服。并服斑蝥片（每片含斑蝥粉10毫克，三七粉100毫克，百合200毫克），每次1片，每日服3次。连服30~50日。

（2）胰腺癌疼痛。

方药：茵陈30克，赤小豆30克，茯苓15克，苡仁30克，干蟾皮30克，水蛭6克，山慈菇30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克，夏枯草30克，大黄10克。水煎服，每日1剂，

连服30~50剂。

(3) 白血病腹部疼痛。

方药：云南白药，每次服1.5克，每日服3次，开水送服。连服30~50日。

(4) 骨髓瘤疼痛。

方药：龟粉，每次服3克，早晚各服1次。连服30~50日。龟粉制法：乌龟若干个，每个用黄泥团包好，外面用铁丝加固，放木柴火上煨烤，烤至龟壳用手能折断为度，研细末，每次服3克。并配合针刺治疗。

(5) 脊髓肿瘤疼痛。

方药：黄芪90克，地龙15克，当归15克，赤芍30克，川芎10克，桃仁12克，红花12克，元胡15克，苡仁30克，山药30克，川牛膝30克，鸡血藤30克，乳香10克，没药10克。水煎服，每日1剂，连服30~50剂。

(6) 乳腺癌疼痛。

方药：王不留行15克，郁金30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克，桃仁12克，红花12克，青皮12克，柴胡15克，香附15克，麝香1克，（冲服）玄胡10克，乳香12克，没药12克。水煎服，每日1剂，连服30~50剂。

此外，钱伯文教授提出的治癌性疼痛的法则，颇有临床实用价值。①癌肿以毒邪蕴结为主，肿块坚硬，多见于腹腔，持续性锐痛，有灼热感，伴发热便秘，宜用蒲公英、白毛藤、肿节风、芙蓉叶、银花、连翘、土茯苓、野葡萄藤、莨菪等止痛消肿。②癌肿以血瘀为主的，患处刺痛，痛有定处，按之亦痛，舌紫有瘀点瘀斑，宜用三七、乳香、没药、莪术、丹参、赤芍、桃仁、红花、土鳖虫止痛消肿。③癌肿以气滞气郁为主的，患处胀痛，肿块柔软，疼痛时缓时急，

伴胸腹胀满，暖气，宜用香附、木香、青皮、玄胡、川楝子、八月札等理气止痛。④癌肿以痰湿凝滞为主，肿块光滑，多见于体表、钝痛，伴身重足肿，便艰纳呆，痰粘稠，宜用山慈菇、昆布、海藻、牡蛎、天南星、陈皮、姜半夏、夏枯草等止痛消肿软坚。⑤癌肿以正虚不荣为主，隐痛，绵绵作痛，得温则缓，得按痛减、伴虚弱症候。宜用白术、黄芪、党参、白芍、当归、大枣、甘草缓急止痛。

外治法

1. 体表原发癌或转移癌肿疼痛

方一：麝香0.5克，冰片6克，大黄10克，蟾酥1克，雄黄4克，乳香10克，没药10克，血竭6克，白芥子8克，共研细末，用白酒调成糊状，外敷患处，厚2毫米，再用麝香虎骨膏覆盖固定。

方二：胆石30克，磁石30克，丹砂30克，白矾30克，雄黄30克，共研细末，用白酒调成糊状，外敷患处。

2. 内脏肿瘤疼痛

(1) 肝癌疼痛。

方一：活蟾蜍1只（去内脏），雄黄30克，制成糊状，敷在肝区疼痛最明显处。

方二：大黄50克，姜黄50克，黄柏50克，皮硝50克，芙蓉叶50克，冰片20克，生南星20克，乳香20克，没药20克，雄黄30克，天花粉100克，制成糊状，外敷肝区疼痛处。

方三：雄黄60克，明矾60克，青黛60克，皮硝60克，乳香60克，没药60克，冰片10克，血竭30克，共研细末，和匀，每次取60克，用米醋和猪胆汁各半调成糊状，外敷肝区疼痛处，并保持湿润。

方四：活杀鳖头2个，灰苋菜90克，水红花籽90克，共

捣烂成泥状，外敷肝区疼痛处。

（2）肺癌疼痛。

方一：新鲜蒲公英1000克，捣烂外敷胸部疼痛处。

方二：松香15克，乳香15克，没药15克，血竭5克，冰片3克，共研末，泡酒，外涂四肢，治肺癌因臂丛神经受侵而引起的上肢剧烈灼痛。

针灸和其他疗法

晚期癌症患者最大的痛苦是疼痛，严重疼痛患者，一切止痛药物往往不能达到完全镇痛的效果，而针灸止痛却能收到良效。

1. 取穴百会、内关、风门、肺俞、定喘、丰隆、阳陵泉、阴陵泉、进针得气后留针半小时，并用20%胎盘注射液14毫升分别注射于足三里（双）、大椎。

2. 取穴肝炎点（新穴位）、足三里、阳陵泉、期门、章门、三阴交，缓慢进针，留针半小时，忌提插。一般进针后，肝癌患者疼痛渐止，止痛维持时间可达10余小时，且无注射杜冷丁后易成瘾的副作用。

3. 用大号玻璃罐4~8个，在食管癌胸背痛患者胸背部疼痛处（阿是穴）拔火罐，留罐时间10~15分钟。

附录 具有抗癌作用的常用中药：

蜈蚣、五灵脂、水蛭、土鳖虫、全蝎、山甲、蝉蜕、僵蚕、斑蝥、壁虎、蜂房、威灵仙、郁金、乌梅、黄芪、王不留行、黄药子、夏枯草、莪术、瓜蒌仁、旱莲草、银花、鱼腥草、红花、昆布、川牛膝、山慈菇、山豆根、三棱、石上柏、仙鹤草、草河车、桑白皮、侧柏叶、大黄、泽漆、肿节风、天南星、乳香、没药、败酱草、半枝莲、贝母、马齿苋、马兜铃、白芍、白花蛇舌草、槟榔、茯苓、丹皮、苡仁、茵灵芝、木通。

35. 糖尿病周围神经病变

糖尿病周围神经病变是糖尿病常见的一种慢性并发症。临床主要表现为肢体疼痛、麻木、感觉障碍、肌肉萎缩等。如对称性小腿或下肢疼痛、灼痛或钻凿痛，有时剧痛如截肢，夜间更明显，有的患者手脚腕踝部等感觉异常，有麻木、灼热、针刺或如踏棉垫感，或如虫爬蚁走，或如触电，有时伴以痛觉过敏，连盖被褥受压都不能忍受而需用被架支撑。患者肌张力减低，下肢软弱无力，起立行走困难，上肢不能高举后旋。严重者有足垂症甚至完全瘫痪，肌肉萎缩，踝部浮肿。

中医认为糖尿病周围神经病变系肾虚肝郁，气滞血瘀为患。中医认为肾为一身元阴元阳之根本，肝肾同源，脾肾相生。若肝脾肾三脏俱虚，则四肢失于濡养而导致疼痛、麻木、萎缩。治宜补肾活血，理气疏肝。

方一：枸杞15克，黄精30克，柴胡15克，赤芍30克，当归30克，茯苓15克，白术15克，川楝子10克，全蝎10克，姜黄10克，元胡15克，荔枝核30克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

方二：山药30克，补骨脂15克，仙灵脾30克，黄精30克，枸杞15克，丹参30克，桃仁10克，红花10克，黄芪30克，当归15克，全蝎10克，桂枝15克，茯苓15克，苏木10克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

方三：人参叶30克，黄芪60克，黄精30克，赤小豆30

克，地骨皮30克，天花粉30克，苡仁30克，枸杞15克，白芍60克，制首乌30克，玄胡15克，川楝子10克，生蒲黄12克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

方四：复方丹参片，每次服4片，每日服三次，开水送服。连服两个月。或用丹参注射液2毫升，肌肉注射，每日1次。

方五：玄参30克，苍术30克，地龙30克，白芍30克，黄芪30克，泽兰10克，麦冬15克，丹参30克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

36. 糙皮病

糙皮病又称烟酸缺乏病，是一种复合的代谢障碍性疾病，典型的临床表现有皮炎、痴呆、腹泻。

烟酸是一种营养素，广泛存在于新鲜绿色蔬菜、水果、豆类、蕈类、肝、肾、肉类食品中，一般人不易引起烟酸缺乏。但在一些绿色蔬菜、水果和动物蛋白不易得到的地区，或一些以玉米、高粱为主食的地区，本病仍可发生。某些嗜酒者、偏食者，也可引起本病的发生。

临床表现：躯干和肢体暴露部位发生对称性皮炎。最初皮肤潮红，继而红肿或出现水疱、水疱擦破后结痂。日久红斑逐渐消退，颜色变暗，呈灰黑色，并出现角化和粘着性黑色鳞屑，粗糙，皮肤缺乏弹性，关节处容易发生皲裂。

舌尖及舌边早期红肿，蕈状乳头突起，随后舌苔剥脱，乳头萎缩变干，舌质猩红光滑。

患者智能衰退，精神障碍，记忆力减退，注意力不集中，思维迟钝，淡漠，对周围事物不感兴趣，易疲乏，幻听，幻视惶恐不安，失眠，多梦，性欲减退，阳萎或闭经。有的患者痛觉减退，肢体震颤。

口角糜烂，腹泻，腹痛，恶心，呕吐，食欲减退，胃酸缺乏。

糙皮病属于祖国医学的“虚劳”、“泄泻”等范畴。《内经》称肌肤干枯粗糙而不润泽为“索泽”；《金匱要略》称之为“肌肤甲错”，并认为多系瘀血内阻、新血不生、肌肤失于濡养所致。糙皮病的治疗，宜活血化瘀，养血润燥。

中药疗法

方药：当归30克，黄芪60克，桃仁10克，红花10克，制首乌3克，熟地30克，赤芍30克，川芎10克，丹皮10克，党参30克，乌药10克，山药30克，香附10克。水煎服，每日1剂，连服20~30剂。

食物疗法

患者平时应多吃肉类、豆类、新鲜蔬菜、水果、动物肝、肾，以补充烟酸。养成不偏食的习惯。并须戒酒。

37. 低钙血症

低钙血症由于甲状旁腺损伤或特发性萎缩引起，当甲状旁腺功能减退(手术后可引起)，维持正常血钙的作用减弱或丧失而发病。甲状旁腺功能减退常可呈隐伏状态，而不发生

临床症状，仅在对甲状旁腺功能需要增加时（如妊娠或哺乳时）才出现临床症状。

临床表现：皮肤干燥、粗糙、脱屑，常呈广泛的干皮病。头发稀疏，或头发全部脱落，眉毛、睫毛稀疏，腋毛、阴毛也有脱落。指甲破坏碎裂、起沟，甚至变色。甲沟皱襞常可有念珠菌感染，甚至有泛发性皮肤念珠菌感染。极少数病例可发生脓疱病皮疹，在红斑基础上发生群集的表浅性脓疱，并可融合成剥脱性皮炎。

低钙血症的全身症状有癫痫、感觉异常、肌肉痉挛、四肢抽搐；精神症状有焦虑、激动、抑郁、忧愁、恐惧等。

检查血钙可低于正常值。

低钙血症属于祖国医学的“痉症”范畴。中医认为系素体脾胃虚弱，气血化源不足，筋脉失其濡养所致。《张氏医通》说：“阴虚血少之辈，不能荣养筋脉，以致搐挛僵仆者，皆是此证。……产妇之有此者，必以去血过多，冲任竭也。……”治宜益气养血，熄风止痉。

方一：党参30克，白术15克，茯苓15克，炙甘草10克，当归20克，川芎10克，白芍15克，熟地20克，龟板30克，生牡蛎50克，天麻10克，全蝎10克，鸡血藤30克。水煎服，每日1剂，连服30～50剂。

本方前八味药为八珍汤。八珍汤有益气补血之功。龟板、生牡蛎育阴潜阳，配用天麻、全蝎熄风解痉，鸡血藤补血通络。诸药合用，共奏益气养血、熄风解痉之功效。

方二：白芍90克，炙甘草10克，阿胶15克（烔服），生龟板30克，熟地20克，麻仁10克，五味子10克，生牡蛎30克，生鳖甲30克，鸡子黄一枚，麦冬12克。水煎服，每日1剂，连服30～50剂。

方中白芍、甘草能止搐解痉，阿胶补血止血养阴，鳖甲、龟板滋阴潜阳，牡蛎平肝潜阳，熟地补血滋阴，麻仁润肠止渴，五味子滋肾生津，麦冬养阴生津，鸡子黄养阴宁心。全方具有滋阴潜阳，止搐解痉之功效，治疗低钙血症之痉挛抽搐及皮肤症状，具有较好疗效。

38. 疟疾

疟疾是疟原虫所引起的传染病。临床上以间歇性寒颤、高热、出汗和脾肿大、贫血等为特征。恶性疟并有侵犯内脏引起凶险发作的倾向。

临床表现：典型发作可分三个阶段：①发冷期：寒颤，脸色发绀，肢体厥冷，皮肤呈鸡皮样，持续10分钟至1小时之久，体温迅速上升。②发热期：寒颤停止后，出现高热，脸色潮红，体温可达 $39\sim 41^{\circ}\text{C}$ ，头痛，口渴，脉搏快，一般持续4~8小时。③出汗期：高热后病人突发全身大汗，体温骤然下降，当时除感疲劳外，顿感舒服轻松，常安然入睡。出汗期约持续2~3小时。

血内查到疟原虫即可确诊。

中医认为疟疾是由于感染疟邪所致，有1天一发，2天一发或3天一发的。其热多寒少者称为温疟，但热不寒者称为瘧疟，若寒多或但寒不热，称为牡疟，若因障毒所伤，则称瘧疟，久疟不愈、形体消瘦、遇劳即发、则称劳疟。其延久不愈，反复发作，胁下结块者，名曰疟母。治疗宜截疟达邪。

中药治疗

方一：常山（酒炒）15克，草果10克，法半夏15克，柴胡15克，槟榔12克，黄芩15克，青皮10克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服7~14剂。在疟疾发作前2小时服药1次，隔3小时后服第2次。常山易引起呕吐。因此，宜在饭后服药，药液宜放冷后服，不宜乘热饮用，分次频服可减轻呕吐。也可在服药后立即用手指掐住自身的内关穴，反复掐按，可预防呕吐。

方二：乌梅15克，常山（酒炒）15克，高良姜15克，法半夏12克，草果10克，槟榔10克，甘草10克。水煎，放冷后分多次服用，每日1剂，连服7~14剂。

方三：青蒿素水混悬注射液（每毫升含青蒿素150毫克），充分摇匀后肌肉注射，首剂600毫克（分两侧臀部注射），第二、三天各注射300毫克。3天总量1200毫克。

方四：青蒿素栓（每粒含青蒿素100毫克或600毫克不等），首剂用600毫克青蒿素栓塞入肛门内，隔4小时再塞入600毫克。第二天、第三天上、下午各塞药400毫克，3天总量2800毫克。先解大便后塞药。如塞药后3小时内解大便者，应以同量青蒿素栓再给药（塞肛）一次。

针灸治疗

取穴：大椎、陶道、内关、间使、后溪、足三里、肝俞。

方法：于疟疾发作前1~2小时针刺，强刺激，留针半小时，连针3~4天。以上穴位每次可任选3~4穴，每天针刺1次。

针刺疗法治疗疟疾，主要是提高患者的免疫力。如果用于首次患疟疾者便无效，用于间日疟、恶性疟有一定疗效。针

刺治疗后疟疾停止发作同患者的免疫力有密切关系。有多次疟疾病史的患者针刺治疗停止发作的百分率较高。有的疟疾患者（恶性疟的有性体）经针灸治疗后，虽然症状消失，原虫无性体转阴，但却成为疟疾的传染源。

39. 急性砒霜（砷）中毒

砒霜为砷类化合物，即三氧化二砷，毒性剧毒。口服砒霜中毒多系意欲自杀所致。急性砒霜中毒主要表现为胃肠炎症状，有恶心，呕吐，腹痛，腹泻，大便水样有血，严重者酷似霍乱，上吐下泻，迅速出现脱水而出现休克。随后有尿量减少，以至发生尿闭和循环衰竭等。当大量的砷进入体内时，可出现中枢神经系统症状，如兴奋、躁动不安、谵妄、四肢疼痛性痉挛、意识模糊甚至昏迷等。患者可因呼吸中枢麻痹而死亡。胃肠道症状好转后，可发生多发性神经炎、中毒性肝炎，中毒性心肌炎以及皮肤瘙痒和皮疹等。

三氧化二砷（砒霜）的成人中毒量为5~50毫克，致死量为60~200毫克。

从呕吐物中检出砷，即可确诊。

祖国医学认为“人有服砒霜之毒，疼痛欲死，首石及救，必至腐肠烂胃，呕吐紫血而死”。

中药救治急性砷中毒有一定疗效。

方药：元参60克，生甘草60克，地榆15克，竹茹12克，枳实10克，生大黄15克。加水急煎与服，每日1剂，直至中毒症状缓解。

由于急性砒霜中毒病情危急，必须争分夺秒进行抢救，为了争取时间（熬中药慢），尤须采取中西医结合抢救手段。

40. 鱼胆中毒

鱼胆中毒并不罕见。有的人误认为吃鱼胆可清热解毒，因此服食鱼胆中毒者不乏其人。临床表现为腹痛，腹泻，头痛，呕吐，低血压，脱水，烦躁不安，出汗，发热，浮肿，小便癃闭，全身发黄，神志不清，抽搐。尿常规检查可见尿蛋白、红细胞及管型，血肌酐、尿素氮均增高，伴不同程度的电解质紊乱。

鱼胆中毒，多由鱼胆胆盐、胆酸毒素引起急性胃肠炎，毒素直接损害肾脏，引起肾小管变性、阻塞、破裂、坏死，肾内压增高，肾缺血缺氧，终致肾小球滤过率极度下降。临床典型表现为恶心、呕吐、少尿或无尿的尿毒症症状。

鱼胆中毒引起的尿毒症症状类似于祖国医学的“关格”。《证治汇补》说：“既关且格，必小便不通，旦夕之间，陡增呕恶，……一日即死，最为危候。”《景岳全书》说：“关则不得小便，格则吐逆。”中医认为“关格”是因浊邪壅塞三焦，正气不得升降，所以关应下而小便闭，格应上而生呕吐。

鱼胆中毒的治疗，宜通腑泄浊，清热解毒，活血化瘀。

方一：玉枢丹（紫金锭）1支磨服。并口服郁金40克，丹参30克，菖蒲15克，绿豆60克，银花30克，茵陈30克，茯

苓30克的水煎液。连服3天。

玉枢丹为中医传统急救良药，具有解毒开窍，清热利尿等综合作用。既可内服，又可外用，用途较广。

方二：丹参30克，黄芪30克，当归30克，大黄30克，加水250毫升，煎至100毫升。保留灌肠，每4小时1次，连用3天。

方三：干紫苏（连梗）500克，煎水，可加适量的盐和糖，频服。适用于鱼胆中毒呈无汗、呕吐的患者。

《本草纲目》谓紫苏能“解鱼蟹毒”。《中国药学大辞典》载紫苏为“杀一切鱼蟹毒之要药”。

方四：制附片15克（先熬），白术15克，茯苓30克，泽泻30克，白芍30克，桂枝10克，黄芪30克，大黄10克，生姜10克。水煎服。每日1剂，连服3剂。

本方有温阳泄浊之功。使毒邪从大小便分利。

方五：生大黄50克，人参叶30克，黄芪50克，泽泻50克，木通20克，川芎20克，红花10克，丹参30克，煎水1500毫升，口服每次30毫升，每日服3次。高位保留灌肠每次500~700毫升，水温25~35℃，保留时间1~3小时。如有肠胀气，先作胃肠减压后再灌肠，使尿素氮、肌酐降至正常方可停用中药。注意量出为入，尽早应用中药灌肠。

本方口服并灌肠有显著的胃肠透析效果，能使鱼胆中毒所致的急性肾功能衰竭完全纠正。

妇 产 科

41. 女性尿道综合征

女性尿道综合征又称无菌性尿频，是妇女泌尿系的常见病。临床表现为尿频、尿急、尿痛，而多次尿培养却没有发现致病菌（阴性），更无全身感染症状。患者多为青年女性，病因尚未阐明，可能与精神因素、穿尼龙内裤引起过敏、使用避孕器具或避孕外用药引起过敏、性生活过度、妇科慢性炎症、尿道外括约肌痉挛等有关。

中医认为本病系湿热下注，膀胱气化不利所致。治宜清热利湿，疏肝补肾。

方一：车前草30克，木通10克，大黄6克，扁蓄10克，滑石30克，瞿麦10克，栀子10克，灯草6克，黄芪15克。水煎服，每日1剂，连服5~7剂。

方二：泽泻30克，龙胆草10克，当归15克，生地15克，柴胡15克，黄芩15克，萆薢15克，知母10克，黄柏10克，白芍30克。水煎服，每日1剂，连服5~7剂。

方三：黄芪60克，桂枝15克，白芍30克，生龙骨30克，生牡蛎30克，夜交藤30克，甘草10克，柴胡30克，石苇30克。水煎服，每日1剂，连服5~7剂。

42. 阿米巴性阴道炎

阿米巴性阴道炎由阿米巴原虫所引起，为继发性感染，

原发病灶多在肠道。滋养体随粪便排出，侵入阴道，当阴道有损伤时，引起炎症。

临床表现：阴道有黄色粘液脓性或血性浆液性分泌物，外阴瘙痒及疼痛，阴道疼痛，性交痛。

检查外阴、阴道及宫颈上可见到典型的溃疡，其边缘不整齐，显著突起。溃疡的表面有污秽的黄棕色坏死物，易出血，触之有痛感。个别病例呈不规则肿瘤样增生，可误认为肿瘤或结核。子宫颈可增大及充血，并有慢性炎症的表现，组织脆，易出血。

阴道分泌物或溃疡刮片检查中找到阿米巴原虫的滋养体，可确诊。

阿米巴性阴道炎属于祖国医学的“阴痒”范畴。中医认为系感受湿热邪毒之气，或虫蚀感染，以致阴痒且痛，治宜祛湿杀虫、

内治法

方一：鸦胆子10~15粒，打碎，装入胶囊，或用糯米纸包裹，开水送服，每日服3次，1周为1疗程。

方二：白头翁60克，秦皮10克。水煎服，每日1剂，连服10天。

方三：大蒜，每日口服1枚，连服10天。

外治法

方一：大蒜30克，捣烂取汁，兑温开水200毫升，冲洗阴道。每日1~2次。连用7天。

方二：鸦胆子45粒，研成细末，炼蜜制成栓剂，临睡前塞入阴道，每日1次连用7天，忌房事。

方三：白头翁60克，苦参30克，水煎成汤剂，放冷后灌洗阴道。每日1次，连用7天。

方四：黄连15克，黄柏15克，黄芩15克，白头翁30克，石榴皮30克，加水浓煎，放冷后灌洗阴道。每日1次，连用7天。

方五：乌梅30克，樗白皮30克，槟榔30克，秦皮30克，加水浓煎，过滤，放冷后灌洗阴道，每日1次，连用7天。

43. 痛性脂肪过多综合征

痛性脂肪过多综合征，又称德肯尔氏综合征，是妇科综合征之一。多发生于40~60岁的妇女，其特点为躯干或四肢末梢在肥胖的基础上出现多数对称性痛性脂肪隆起（即脂肪结节），皮肤干燥，常伴有乏力、神经衰弱、性功能早衰等症状。有人又称本综合征为“痛性肥胖”。

本征病因尚未明了，可能和更年期内分泌障碍有关，因为患者往往见于过早绝经的妇女，更年期妇女常可有痛阈降低，对疼痛较为敏感。也有学者认为，本综合征可能和变态反应或风湿有关。

临床表现：患者颈部、腋部、上身或四肢末端可发生对称性、块状、有触痛的脂肪结节。这种疼痛性脂肪隆起很少发生于颜面部。这种痛性脂肪结节可保持多年而无改变。

患者不一定都肥胖，也可以发生于消瘦者。不论肥胖者或消瘦者，都呈现局部有块状、带触痛的脂肪堆积，皮肤干燥，呈淡红色或淡青色，皮肤敏感性降低，麻木，伴有精神抑郁，头痛，乏力，肌力减退，出汗减少，神经衰弱，或伴皮肤瘙痒，性功能衰退较早，提前绝经。

病理切片检查可见多发性、结节性皮下脂肪堆积和变性。

中医认为：痛性脂肪过多综合征多系脾肾两虚所致。脾虚则运化失职，痰湿内生（胖人多痰湿），阻遏脉络，形成痛性脂肪结节，或痰湿流聚，肌肤失于濡养，局部出现块状脂肪堆积。肾虚则性欲低下，冲任脉虚，月事早闭。脾肾两虚，日久导致气血不足，或气虚血瘀。治宜健脾化痰，益肾填精，补益气血。

方一：黄芪30克，党参60克，白术15克，茯苓15克，法夏10克，陈皮10克，浙贝15克，海藻30克，赤芍30克，白芥子10克，山药30克，山甲15克。水煎服。每日1剂，连服30～50剂。本方适用于乏力，肌力减退，脾虚症状明显的痛性脂肪过多综合征患者服用。

方二：寄生30克，续断30克，枸杞15克，黄精30克，杜仲15克，鳖甲15克，海藻30克，土贝母15克，巴戟12克，菟丝子15克，苡仁30克，生牡蛎30克。水煎服，每日1剂，连服30～50剂。本方适用于闭经较早，性欲减退，肾虚症状明显的痛性脂肪过多综合征患者服用。

方三：三棱10克，莪术10克，当归30克，赤芍30克，川芎10克，黄芪60克，党参30克，鸡血藤30克，鳖甲15克，海藻30克，丹参30克，浙贝15克，白芷10克。水煎服，每日1剂，连服30～50剂。本方适用于痛性脂肪结节较多，舌有瘀斑之气虚血瘀患者服用。

痛性脂肪过多综合征的治疗，疗程较长，应说服患者坚持服药，耐心治疗，一般需服药几十剂，才能使痛性脂肪结节消失。

44. 阴道痉挛

阴道痉挛是一种妇科疾病，此病并不少见。表现为阴道肌肉不自主性痉挛或缩窄，影响正常的性生活。患者阴阜、阴道紧缩，妇科检查可见发育完好，无器质性病变，外生殖器正常，但阴道口紧缩、痉挛，检查时手指无法插入，若强力内插则高声呼痛，拒绝检查。患者诉每次同房则阴道疼痛甚至剧痛。

临床上将阴道痉挛分为轻度痉挛和重度痉挛两种。轻度阴道痉挛者可勉强完成性交，重度阴道痉挛者（持续性阴道强烈痉挛抽搐）则无法进行性交，患者无性欲，腰骶部多有冷感。

中医认为阴道痉挛乃肾阳不足，命门火衰，阳虚阴乘，寒滞肝脉所致，或情志不畅，畏惧房事，致同房发痉而疼痛。治宜温肾助阳，缓急解痉，

中药治疗

方一：白芍100克，甘草15克，柴胡10克，香附10克，僵蚕10克。水煎服。

加减：肾阴虚损加生地、女贞子、枸杞。湿热下注（白带多）加龙胆草、土茯苓、泽泻、黄柏。

注：此方宜每天1剂，连服20～60天。

方二：仙灵脾30克，仙茅10克，肉苁蓉15克，巴戟10克，紫石英15克，白芍60克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服20～60剂。

心理治疗

除药物治疗外，还须配合心理治疗，向患者暗示，性生活乃人类繁衍后代的环节，乃生物之天性，人类之本能，夫妻性生活是生育科学的一部分，鼓励患者消除顾虑，实现夫妻正常的性生活。

45. 盆腔脓肿

盆腔脓肿是腹腔内炎性渗出物或脓液积聚于盆腔内的膀胱直肠窝或子宫直肠窝而形成的脓肿。以急性阑尾炎穿孔及盆腔炎引起的最为多见。由于盆腔腹膜面积小，吸收毒素能力较低，因此全身中毒症状较轻。

临床表现：持续性高热或热退后又再次发烧。每日腹泻5~10次以上，里急后重，泻粘液便或带脓血。乏力，肢冷，尿频，尿急，尿痛，尿涩（排尿困难）。直肠指检可触及包块，触痛，脓已成则有波动感。白细胞总数及中性粒细胞可升高。

盆腔脓肿经X线检查可确诊。

盆腔脓肿属于祖国医学的“内痈”范畴。多由肠痈内溃，脓液外溢，湿热毒邪流注于膀胱、肛肠、胞宫之间，气血凝滞，经络阻遏，热毒炽盛，湿热下注大肠或膀胱。治宜清热解毒，利湿排脓。

内治法

方一：大黄15克（后下），红藤30克，败酱草30克，苡仁30克，冬瓜子30克。丹皮15克，赤芍30克，蒲公英30克，

车前草30克，扁蓄15克，桔梗15克，炮山甲15克，黄芪30克。水煎服，每日1剂，连服20~30剂。

方二：白头翁50克，黄柏15克，知母15克，丹皮15克，赤芍30克，大黄10克，秦皮15克，黄连15克，桃仁10克，苡仁30克，冬瓜子30克。水煎服，每日1剂，连服20~30剂。

灌肠疗法

方药：蒲公英30克，桂枝12克，桃仁12克，红花12克，茯苓30克，苡仁30克，红藤30克，败酱草30克，丹皮15克，大黄10克。加水浓煎，得药液200毫升，放冷至37℃至40℃时，作保留灌肠。每日1次，连用10~20日。

46. 女性外伤性外阴血肿

女性伤外性外阴血肿多发生于青壮年劳动妇女，多数为骑跨式跌下或外阴被外力撞击所致。

女性外阴部血管丰富，尤其是阴蒂及前庭部分，因外伤致皮下组织小血管破裂，渗出的血液在疏松的结缔组织中扩散而易形成血肿，血肿可以发展很大，使大小阴唇肿胀，有时可沿阴道壁向上扩展。又因外阴神经分布较丰富而感觉敏锐，一旦遭受外伤，局部肿胀，疼痛异常剧烈，甚至影响排尿而发生尿潴留，常给患者造成较大痛苦。血肿常有鸡蛋大或拳头大，位于大小阴唇，也可累及阴阜，个别可累及阴道。

女性外伤性外阴血肿属于祖国医学的“跌打损伤”范

疔。外伤后瘀血阻络，不通则痛。治宜活血化瘀，消肿止痛。

内治法

方一：柴胡15克，当归30克，炮山甲15克，水蛭3克，熟地15克，桃仁12克，乳香10克，没药10克，甘草1克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂。

方二：红花10克，血竭6克，桃仁12克，儿茶6克，冰片1克，当归30克，赤芍30克，桂枝10克，丹参30克。水煎服，每日1剂，连服7~10剂。

外治法

方药：七厘散（成药）调水外敷血肿处。

患者受伤后一定要及时诊治，切不可因害羞而耽误治疗，延误了治疗时机可导致血肿扩大，增加治疗困难，也给患者自己带来更多的痛苦。

47. 子宫内膜增生不孕症

子宫内膜增生引起的不孕症又称子宫内膜增生过长、子宫内膜增生过度。近年来有增多的趋势。子宫内膜增生过度，会影响受精卵着床，从而导致不孕。

子宫内膜增生过度，是因为子宫内膜上长出了象一块块被剪碎的形态不规则的海绵状碎块，这种海绵状的增殖型子宫，内膜血管丰富，并互相牵连，很难象正常子宫内膜那样周期性的完全脱落，致使创面上的血管断端不能收缩，因而月经不断，血崩不止。

临床表现：先闭经或月经过期不行，接着出现阴道少量流血，如滴如漏。然后开始子宫大出血，出血量超过正常月经量的几倍，并排出猪肺样的瘀块，少腹胀痛，瘀块排出后痛减。月经前或行经时乳房胀痛。有的患者由于月经过多、面色晄白，眼睑浮肿，疲乏无力，气短懒言。

子宫内膜增生过长可通过B型超声波检查或病理切片检查确诊。

子宫内膜增生过度属于祖国医学的“崩中”、“崩漏”范畴。中医认为妇女月经淋漓不断，谓之漏下，忽然暴下，谓之崩中。漏者崩之渐，崩者漏之甚。主要由于气虚血瘀所致。《傅青主女科》说：“妇人经水过多，行后复行，面色萎黄，身体倦怠而困乏愈甚者，……是血虚而不归经乎。……”《医宗金鉴》说：“女子不孕之故，……或因宿血积于胞中，新血不能成孕，或因胞寒，胞热，不能摄精成孕……”《千金要方》说：“瘀血占据血室，而致血不归经。”说明血虚血瘀是崩漏的主要病因。

子宫内膜不孕症的治疗，宜活血化瘀，益肾补血（促使海绵样子宫内膜迅速剥落，达到止血的目的）。

辨证分型治疗

（一）肾虚血瘀型：经行腰腹冷痛，经期错后，经色先淡后紫，经量少，舌淡苔白脉沉缓。治宜补肾化瘀。

方药：当归30克，胡芦巴10克，菟丝子15克，巴戟15克，肉桂6克，干姜10克，川芎15克，覆盆子12克，赤芍30克，熟地30克，橘核15克，丹参30克，生蒲黄12克，五灵脂12克。水煎服，每日1剂，连服30~60剂。

（二）血虚挟瘀型：经来如漏，半月方止，继则经来如崩，月经中挟有瘀块，面色苍白，全身乏力，气短懒言，舌

淡苔白脉细。治宜补血活血。

方药：当归30克，川芎15克，赤芍30克，山萸30克，川断30克，白术15克，艾叶12克，荆芥穗12克，桃仁10克，红花10克，丹参30克，黄芪60克，益母草30克。水煎服，每日1剂，连服30~60剂。

专方治疗

方一：生蒲黄25克，五灵脂25克，三七12克，生大黄15克，郁金15克，吴萸10克，肉桂10克，共研细末，每次服6克，每日服3次，开水送服。连服30~60日。

方二：甲方：桃仁10克，红花10克，川芎15克，赤芍30克，当归30克，黄芪60克，丹参30克，淮牛膝10克，益母草30克，三棱10克，莪术10克。水煎服，每日1剂，连服30剂。乙方：山萸30克，熟地30克，仙灵脾30克，仙茅10克，仙鹤草30克，三七粉6克（冲服），枸杞15克，菟丝子15克，肉苁蓉15克。水煎服，每日1剂，连服30剂。

先服甲方，继服乙方。

48. 葡 萄 胎

葡萄胎是由于滋养层细胞增生和绒毛间质水肿，使绒毛变成了大小不等的水泡，相互间有细蒂相连，形如成串葡萄，故称葡萄胎或水泡状胎块。此种病变的绒毛失去吸收营养的功能，致使胚胎早期死亡，经自溶而被吸收，胎盘绒毛常常全部受累，整个子宫腔内充满水泡；有的也可部分绒毛受累，还保存一部分胎盘，称部分性葡萄胎。

葡萄胎可发生于生育期的任何年龄。但以20~30岁和40岁~绝经期前发病较多。经产妇女多于初产妇女。

葡萄胎的发病原因至今尚无一致的看法，可能与营养、感染、遗传、免疫机制的障碍等因素有关。叶酸的缺乏与葡萄胎的发生也有关。

临床表现

1. 停经及阴道出血：大多数病人在停经2~4个月后，由于葡萄状物与宫壁剥离而有阴道出血，最初出血量少，呈棕红色或暗红色，间歇性反复发生，失血多时出现贫血，甚至休克。排出的血块中有时可见水泡状物（葡萄状物）。

2. 子宫异常增大：由于绒毛过度增生、水肿及宫腔内积血，使子宫体异常增大，与停经月份不符。子宫软而下段饱满，摸不到宫体，听不到胎心音，病人也无胎动感。但少数病人子宫并不过于增大反而缩小，这是由于葡萄胎发生坏死退化或部分已排出之故。

3. 妊娠中毒症的症状：约半数病人在停经后恶心、呕吐等症状较一般为重。较早出现水肿、高血压、蛋白尿等妊娠中毒症症状，少数病例还可发展为先兆子痫或子痫。

4. 卵巢黄素囊肿：葡萄胎常合并双侧性黄素囊肿。多因子宫过大，影响妇科检查而不易触及，往往在胎块排出后才被发现。

根据上述症状和体征，即可得出初步诊断，如在阴道排出物中找到水泡状物，则可确诊。如证据不足，难以确诊时，可通过尿妊娠试验、超声波探查、胎心测定仪检查、X线检查等辅助诊断方法确诊。

葡萄胎属于祖国医学的“癥瘕”、“癥积”、“虾蟆胎”、“鬼胎”等范畴。《金匱要略》说：“妇人宿有癥

病，经断未及三月，而得漏下不止，……为癥瘕害。”《证治准绳》说：“初下清水，次下虫如马尾状无数，病剧者下蛇虫，或如虾蟆卵、鸡子，或如白膏，或如豆汁，其病即愈。”关于葡萄胎的病因，《张氏医通》说：“皆由其人阳气不足，或肝气郁结，不能生发，致阴血不化而为患也。有因经行时饮冷，停经而成者；有郁痰、惊痰、温热凝滞而成者；有因悲怒食气淤积互结而成者”。中医认为，因葡萄胎患者所下之物奇异，故曰“鬼胎”、“虾蟆胎”。治宜逐瘀消癥，辅以扶正。

方一：大黄30克，雷丸30克，红花20克，桃仁20克，冬葵子20克，麝香0.3克（冲服），龙眼肉20克，红参粉10克（冲服），桂枝10克。水煎服，每日1剂，直至葡萄胎排出。

当葡萄胎排出后，当以八珍汤、十全大补汤等调理善后。

方二：桂枝15克，茯苓30克，丹皮15克，桃仁15克，赤芍30克，大黄20克，土鳖虫15克。水煎服。每日1剂，直至葡萄胎排出。本方有破血下瘀、缓消癥块之功，能促使葡萄胎排出，推陈致新，症去漏止。

49. 妊娠合并疟疾

在疟疾流行区，妊娠合并疟疾较为常见，疟疾可引起流产和早产，妊娠可使疟疾发作次数增多或症状加重，故妊娠合并疟疾应引起重视。一旦患有脑型疟疾可致抽搐、昏迷和死亡。疟疾发作时，高热可以刺激子宫收缩引起流产、早产，发病率较高。疟原虫除直接破坏红细胞外，受疟原虫感染的红细胞还可以作为抗原，使孕妇产生抗体，而发生血管

内溶血。大量红细胞破坏以后，可以继发叶酸缺乏性贫血和缺铁性贫血，少数严重病例甚至可以发生贫血性心脏病。疟原虫还可能通过胎盘被损伤的绒毛而感染胎儿，新生儿可发生先天性疟疾。

疟疾发作的症状如果不典型时，诊断比较困难，可以和急性肾盂肾炎、败血症、子痫等混淆。对原因不明的发热，如果现住流行区或过去曾在流行区长期居住，或在有蚊季节曾旅居过流行区，或输血后1~2周发热者，都应考虑到有疟疾的可能。

近1~2年内曾患疟疾，现有不明原因发热时，也应考虑疟疾。

怀疑有疟疾时，检查血液找到疟原虫即可确诊。

祖国医学认为，疟疾是感受疟邪及风、寒、暑、湿之气，邪毒侵入人体，伏于半表半里，出入营卫之间，入与阴争则寒，出与阳争则热，正邪交争而发病。中医还认为，疟疾虽由疟邪所致，但正气的强弱起着重要的作用。若正气充沛，足以抵抗病邪，即使感邪，也未必发病。若正气不足，尤其是妊娠期，孕妇抗病能力低下，极易遭受病邪的侵袭而发病。正如赵献可所说：“夏伤于暑，秋必病疟，……然而有病有不病者，盖邪之所凑，其气必虚，故其人元气不固者，暑邪得以乘之。”妇女怀孕期间，阴血聚于冲任以养胞胎，机体常处于阴血不足，阳气亢盛之象，脏腑气血虚弱，疟邪易于入侵，在疟疾高发区，孕妇可谓易感人群。

妊娠合并疟疾的治疗，宜和解清热，截疟安胎。

方药：柴胡10克，黄芩15克，青蒿（后下）30克，知母12克，白术15克，炒常山10克，煨草果10克，法夏10克，党参30克，茯苓10克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服15—30剂。

另用白蜜30克，加白酒适量，于疟疾发作前2小时顿服。

方中所用青蒿，其截疟作用已被现代医学研究证明，其提取物青蒿素能作用于疟原虫滋养体的膜系结构，干扰表膜、线粒体的功能，从而杀死疟原虫。

50. 过期妊娠

月经周期正常的孕妇，超过预产期两周以上尚未分娩，称为过期妊娠。发生原因不明，有人认为与胎儿肾上腺皮质功能有关，或与异常内分泌有关。妊娠过期胎盘功能尚属正常时，过期儿体重较重，骨质较硬，有可能造成难产。当胎盘功能不良时，胎儿缺氧和营养不足，可危及胎儿生命。

过期妊娠须通过妇产科有关检查及“B超”检查等确诊。

过期妊娠属于祖国医学的“难产”范畴。中医重视产妇体质与疾病的关系。中医认为，胎孕非气不生，非血不萌。过期妊娠患者在妊娠过程中不断消耗气血津液，加重了原已不足的脏腑虚损程度，脾气虚弱，肝肾虚损，肝脾肾皆虚，影响胎胞的营养发育。中医认为消瘦型妇女易患过期妊娠。过期妊娠的治疗，宜益气补血，行气化瘀，催胎下行。

方药：黄芪30克，党参30克，白术15克，当归30克，川芎15克，川牛膝15克，丹参15克，寄生30克，续断15克，桃仁6克，红花6克，香附10克。水煎服。3剂为1疗程。

加减：畏寒肢冷加吴茱萸、肉桂。面赤畏热加枸杞、白芍。体肥多痰湿加茯苓、陈皮。

51. 产后血栓性静脉炎

产妇分娩后，子宫胎盘剥离处，有许多栓塞性血管，是细菌滋长的良好基地，此处受感染后，子宫静脉受到侵犯，感染可扩展到髂总静脉及下肢静脉。如子宫底部的静脉受感染，则可迅速扩展至卵巢静脉，在左侧可蔓延上升至肾静脉，在右侧可直接蔓延至下腔静脉，亦可延及髂总脉静。若炎症继续进展，血栓亦渐渐伸展上升，严重时静脉壁肿胀坏死，感染的血栓化脓，形成化脓性栓子脱落，散布于血液中，成脓毒血症。化脓性栓子随血流散布全身各处，成迁移性脓肿，最常见的是肺脓肿，其次为肾周围脓肿，常可引起死亡。

产后血栓性静脉炎可分为盆腔内血栓性静脉炎和下肢血栓性静脉炎两大类。

第一类为盆腔内血栓性静脉炎：多发生于子宫内膜炎之后，常于产后1~2周出现。产妇有寒颤、高热，可持续数周，但也有断续间歇。持续性下腹痛，疼痛可放射到腹股沟、胁腹或肋脊角，下腹软但有深压痛，常局限于盆腔一侧，子宫活动受限。移动子宫时可引起感染侧的疼痛。深压时偶可摸到受累的静脉丛如长形肿块，压痛明显。受累的静脉在较高或较深的部位时，盆腔检查可无特殊体征发现。

第二类为下肢血栓性静脉炎：当病变累及下肢静脉时，因血液回流受阻，下肢可出现水肿、疼痛、皮肤紧张及发白，引起所谓“股白肿”。下肢血栓性静脉炎的症状，常在

产后2~3周出现，可有寒颤、发热，发炎的静脉摸之如条索状，有压痛，患肢的温度略高于对侧。病程可持续很久，栓子迁移不多见，很少引起死亡。

盆腔血栓性静脉炎的诊断比较困难，因阳性体征不易为临床发现。当产后有持续性原因不明的发热，伴有盆腔疼痛及深压痛时，就应考虑有盆腔血栓性静脉炎的可能。

产后血栓性静脉炎属于祖国医学的“气滞血瘀”。《医林改错》说：“血受寒则凝结成块，血受热则煎熬成块。”

《临证指南医案》说：“初病胀痛无形，久则形坚似梗，是初为气结在经，久则血伤入络。”《读医随笔》说：“叶天士谓久病必治络。其说谓病久气血推行不利，血络之中必有淤凝，故致病气缠绵不去，必疏其络而病气可尽也。”中医认为，产后血栓性静脉炎，气滞血瘀，淤血与好血决不相合，随气血之运行而留滞于经络，犹如江河之淤砂阻滞，淤血不除，新血不生，且淤积化热，则诸病丛生矣。因此，产后血栓性静脉炎的治疗，宜活血祛瘀。

方药：当归30克，熟地30克，桃仁12克，红花10克，川芎15克，赤芍30克，黄芪60克，三棱10克，莪术10克，水蛭6克。水煎服，每日1剂，连服10~30剂。

此方由桃红四物汤、当归补血汤合方加三棱、莪术、水蛭组成之复方。当归补血汤（黄芪、当归）功能补气生血，气行则血行，治大失血后、产后所致的血虚证。桃红四物汤功能活血调经。治痛经，经行不畅，以及气滞血瘀所致的瘀血症候。三棱、莪术为活血化瘀之要药，破瘀通经，行气消积，除癥瘕积聚。水蛭破血祛瘀，通经消症，治瘀血内阻、癥瘕积聚。新鲜水蛭唾液中含抗凝血物质水蛭素，能阻碍血液凝固。综观全方，显有活血祛瘀、通经活络之功效，为治

疗产后血栓性静脉炎的有效良方。

产后血栓性静脉炎患者，要抬高患肢，产后尽早下床活动，不要长期卧床不起。在床上多作踝、膝关节伸屈运动。

52. 产褥中暑

产褥中暑是在产褥期因高温、高湿、通风不良及体质虚弱的条件下，引起中枢性体温调节功能障碍的急性热病。

由于受旧的风俗习惯的影响，有的产妇分娩后恐怕“受风”，为了避风，即使在盛夏季节，也穿厚衣，扎紧袖口、裤脚，紧闭门窗，影响散热，从而发生产褥中暑。

临床表现

1. 先兆中暑：发病急骤，常有口渴、多汗、恶心、头晕、头痛、胸闷、心慌、无力。如能及时移至通风处休息，补充水分及盐分，症状即可消失。

2. 轻度中暑：除以上症状外，可有体温上升，脉搏、呼吸增快，面色潮红，不出汗，皮肤干燥，痱子布满全身，或虽出汗而体温不降。

3. 重度中暑：体温继续上升，肛温可达 42°C 甚至更高，昏迷，谵妄，抽搐，呕吐，腹泻，呼吸短促，脉细数，血压下降，面色苍白，瞳孔缩小，瞳孔对光反射及膝反射减弱或消失。如不及时抢救，可危及生命，

中暑属于祖国医学的“中热”、“中喝”、“阳暑”等范畴。《时病论》说：“是病忽然闷倒，昏不知人，躯热汗微，牙关微紧，亦或口开，状若中风，但无口眼喎斜之别，

其脉洪濡，或滑而数。”《增订寿世保元》说：“又有暑风者，神昏，身体拘急，类若中风……盖必其人元气素弱，真阴不足……。”产褥中暑正是在体质虚弱及高温环境的影响下产生的。其治疗宜养阴清热。

中药治疗

方一：生石膏60克，知母15克，山楂15克，甘草10克，山药15克，人参叶30克。水煎服，每日1剂，连服3~7剂。

方二：西洋参10克，西瓜翠衣30克，石斛15克，竹叶12克，麦冬15克，知母15克，黄连6克，甘草3克，粳米10克。水煎服，每日1剂，连服3~7剂。

针灸治疗

轻症针大椎、风池、足三里。重症（高烧昏迷）刺十宣放血，刺人中、涌泉。配穴：百会、大椎、曲池。

53. 产后子宫复旧不良

产后子宫复旧不良，又称产后子宫复旧不全，是产后常见多发病。患者多因使用催产素及麦角新碱治疗而导致子宫复旧不全。表现为：恶露不绝，阴道有血块排出，阵发性腹痛，宫底耻骨上三指有质软，压痛。

产后子宫复原主要表现在子宫体肌纤维缩复和子宫内膜的再生。一般而言，血性恶露于产后15~30天完全停止，产后6周子宫恢复正常，子宫内膜完成再生修复。如产妇素体虚弱，或产程过长，产后宫腔内胎膜组织留残或产子感染等，均影响子宫复旧，导致恶露不尽而持续时间较长。

产后子宫复旧不良，属于国医学“产后恶露不尽”范畴。中医认为，产后恶露不尽，主要责之肝、肾和冲任二脉，冲为血海，任主胞胎，二脉隶属于肝肾。肝藏血，肾藏精，因产时多耗血伤精。导致冲任虚损。肝肾不足，冲任虚损，又影响子宫的收缩，致污血瘀留腹中，随化随行。恶露又为血所化，若长期淋漓不尽，又往往造成失血性贫血。中医还认为，产后恶露不尽，多因产后气虚失摄，冲任不固，或余血未尽，或感寒凉，败血瘀阻冲任。或营阴耗损，虚热内生，热扰冲任，迫血下行所致。

辨证分型治疗

（一）气虚型：产后恶露不尽，恶露色淡，质清稀，量多，阵发性腹痛，兼见面色苍白，懒言，小腹空坠。治宜补气摄血。

方药：黄芪60克，陈皮10克，炙甘草12克，升麻10克，白术15克，当归30克。水煎兑服增硒绞股兰颗粒剂50克。每日1剂，连服20剂。

（二）余血未尽型：恶露量少，淋漓涩滞不爽，色紫暗有块，伴有小腹疼痛。治宜化瘀止血。

方药：当归30克，川芎15克，坤草15克，炮姜12克，元胡12克，红花12克，三七粉6克（冲服），丹参30克。水煎服。每日1剂，连服10~20剂。

（三）血热型：恶露不尽，量多，色红，粘臭，面色潮红，脉细数。治宜清热止血。

方药：生地60克，熟地30克，白芍30克，山药30克，续断30克，黄芩30克，黄柏12克，知母12克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

专方验方治疗

方一：当归15克，川芎12克，桃仁12克，炮姜6克，甘草6克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

加减：宫缩痛加生蒲黄10克、五灵脂10克。恶露量多，持续时间长，加益母草30克。贫血明显者加黄芪60克、党参30克。

方中当归补血活血，川芎行血活血。现代医学研究，当归川芎均有兴奋子宫，促进子宫收缩之功。桃仁破血散瘀，炮姜、甘草温化和中。全方通滞和营，补血清瘀。益母草活血，蒲黄、五灵脂行瘀止痛。全方可增强产后机体抵抗力，促进子宫复旧，止痛，止血，且不影响乳汁分泌。

方二：益母草30克，当归15克，川芎10克，白芍30克，熟地15克，艾叶炭10克，仙鹤草15克，旱莲草15克，荆芥炭15克，阿胶（烔化）10克，炒杜仲12克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

加减：出血量多，加党参30克，黄芪60克，炮姜炭10克。血瘀征象明显（腹痛如刺，痛时恶露增多，舌紫暗，有瘀点，脉涩），加蒲黄炭15克，五灵脂15克，三七粉6克。湿热征象明显（恶露鲜红，夹有黄色粘液，气味腥臭，伴发热，口渴，腹痛，便秘，心烦，舌红脉数），熟地改为生地，加蒲公英30克，地榆炭15克，炒栀子10克。

本方中川芎、阿胶、艾叶、当归、熟地、白芍组成“芎归胶艾汤”，功能补血调经，治少腹疼痛，恶露不绝，淋漓不断。加用益母草，以增强子宫肌肉的收缩力，并具活血化瘀之作用，又能促进子宫内膜再生修复。加用仙鹤草、旱莲草、荆芥炭，以增强止血之功，用杜仲意在补肝肾，扶正固本。本方治疗子宫复旧不良，疗效可靠。

儿 科

54. 新生儿肝炎综合征

新生儿肝炎综合征是发生于新生儿期或满月后，以黄疸持续不退、肝脾肿大及肝功能损害为主的一组症候群。由多种病因引起，如肝内胆道梗阻，肝外胆道梗阻等。症状有：黄疸、大便色白、发烧、抽搐、呕吐、恶心、腹泻、尿黄、豆油样尿、体重不增、纳差。患儿多合并有感染如肺炎、中耳炎、脓疱疮、脐带感染、疳肿、上感、肠炎以及生后窒息或硬肿症等。

实验室检查，尿胆红质阳性，白细胞总数升高，肝功能不正常。

新生儿肝炎综合征属祖国医学“黄疸”范畴。中医认为，新生儿黄疸多与妊母体质、胎热及生后感染湿热毒邪等因素有关。古代医家称“胎黄”、“胎疸”。黄疸可分为阳黄、阴黄两大类。由于母体内蕴湿热邪毒传于胎儿，小儿脏腑娇嫩，形气未充，脾运不健，湿热内蕴，影响胆的疏泄，浸淫肌肤而出现身目发黄，此即阳黄。若因素体阳虚，或因阳黄失治，迁延日久，正气受伤，脾阳不运，湿从寒化，寒湿阻滞，胆液被阻，溢于肌肤而发黄，即为阴黄。临床上以阳黄为多见。

新生儿肝炎综合征的治疗，宜疏肝利胆，祛湿退黄。

方一：茵陈20克，栀子6克，大黄3克，郁金6克。金钱草6克，甘草6克，板蓝根10克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

加减：热重加黄芩、大青叶。湿重加茯苓、白术、泽泻、车前草。恶心呕吐加法夏、陈皮、竹茹。

方二：金钱草12克，篇蓄6克，茵陈12克，车前草12克，虎杖12克，生大黄3克，山栀6克，郁金10克，生甘草6克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

加减：气虚加太子参，肝脾肿大加丹参、川芎。

方三：精制大黄片(上海中药一厂生产)，每片为0.25克，相当于生药(10克)，每次服半片，一日服3~4次，最大用量每日3片。连服10~15日。

本方由于服用方便(溶于少量水中服用)，药价低廉，疗效可靠，无副作用，颇受欢迎。

方四：茯苓10克，党参10克，白术10克，白芍10克，茵陈10克，郁金10克，丹参10克，金钱草10克，山楂6克，平地木10克，青皮3克，陈皮3克。水煎服，每日1剂，连服10~15剂。

注：服以上方药退黄疸后，仍需服用保肝药物，以巩固疗效。

55. 新生儿窒息

新生儿窒息指胎儿娩出后仅有心跳而无呼吸，以致出现一系列的呼吸衰竭症状。新生儿窒息病情紧急，必须积极抢救和正确处理。

新生儿窒息的病因是胎儿宫内窘迫未得到纠正，出生后往往表现为新生儿窒息。

胎儿颅内出血及在宫内脑部长时间缺氧，可使呼吸中枢受到损害。

在分娩过程中母体应用麻醉剂如乙醚、镇静药物如吗啡，均可经胎盘进入胎儿体内抑制呼吸中枢，引起新生儿窒息。

胎儿在子宫内缺氧，可在娩出过程中发生呼吸动作，将羊水、粘液、胎粪、血液吸入气管内，引起呼吸道阻塞，以致无法进行气体交换。此外如原发性肺不张、膈疝及肺囊肿等都可发生新生儿窒息。

临床表现

1. 青紫（轻度）窒息：由于新生儿血氧降低、二氧化碳浓度增高，新生儿面部与全身皮肤呈现青紫色，心跳有规律，且强而有力，对外界刺激有反应，肌肉张力好，喉头反射存在，如不及时治疗，可转变为重度窒息（苍白窒息）。

2. 苍白（重度）窒息：皮肤苍白，口唇暗紫，心跳不规则，缓慢且弱，对外界刺激已无反应，肌肉张力消失，四肢瘫痪，喉头反射消失，如不及时抢救，可致死亡。

针耳疗法

中医认为，新生儿窒息是由于患儿先天不足所致。肾为先天之本，主骨，生髓，通于脑，开窍于耳。刺激“肾点”（耳穴），可以补先天，通肾气。肾气为生命之源，阳气之本，阳气通则呼吸畅。故耳针疗法治疗新生儿窒息有一定疗效。

取穴：肾点（耳甲艇内，对耳轮内侧面上三分之一处），脑干，脑点。

刺激手法：五分毫针强刺激，不留针，刺激时间不超过5分钟，每分钟捻转80次，针刺深度不超过1分，以不穿透耳壳为度，直刺，四肢抽动时用平补平泻的手法慢慢捻转30秒，若无反应，可用提捣法用力提捣30秒。

针灸学认为，刺激耳穴的脑点和脑干，可使大脑细胞的兴

奋性增高,可兴奋延髓的呼吸中枢,增加脑组织的供血供氧,改善脑组织的缺血缺氧状态,使脑组织恢复正常的生理功能。

针(体针)灸疗法

取穴:人中、十宣、涌泉、百会。

方法:针刺人中、十宣、涌泉,灸百会。针刺十宣时采取依次急刺法,刺人中则浅刺留针。刺涌泉则为强刺激,留针并加捻转,至发生呼吸并有哭声后起针。灸百会时距皮肤2~5厘米,直灸至发出哭声后始止,一般针灸时间为5~20分钟。

其他疗法(适用于轻度窒息患儿)

1. 先吸出患儿口腔内粘液,将患儿平放,助产者用两手大拇指用力压迫婴儿两侧劳宫穴,压迫3~4秒,间歇3~4秒,一按一放。
2. 酒精擦胸,刺激患儿呼吸。
3. 作口对口人工呼吸。

56. 新生儿脐炎

新生儿脐炎,多由断脐结扎不良,造成早期脱落而致脐出血;或因脐部洗浴不慎,被水浸渍,又未擦干;或由尿布过湿,久浸脐部;或因小儿脐带粗大,干缩后缚结松脱等而引起感染所致。轻者脐部发红,有少量脓性或血性分泌物。重者可有发烧,哭闹烦躁,脐周红、肿、热、痛,甚而引起腹壁蜂窝组织炎、脐周脓肿、腹膜炎、败血症等。

中药治疗新生儿脐炎,简,便,验,廉。

方一:云南白药1克。

用法:先用生理盐水或新洁尔灭液清除局部分泌物,然

后于患处撒上云南白药，再用消毒纱布覆盖，绷带包扎，隔日换药1次。

方二：五倍子50克，生龙骨25克，冰片0.2克。共研细末，将药末用陈醋调成糊状敷脐中，每日换药1次。

方三：艾叶灰7份，消炎粉3份，共研极细末，将脐部消毒后，撒上述药粉，包扎，每日2次。

57. 小儿反复呼吸道感染

小儿反复呼吸道感染是指体质较弱儿童呼吸道感染反复发作，在一年内反复呼吸道感染达10次，若病程不到一年，在半年内反复感染6次，平均每月就有一次呼吸道感染，这对小儿的生长发育必然带来不良影响，也给家长带来苦恼。

《中华儿科杂志》1988年第1期刊登的小儿反复呼吸道感染的诊断标准如下：

年 龄	上呼吸道感染次/年	下呼吸道感染次/年
0~2岁	7	3
3~5岁	6	2
6~12岁	5	2

注：①上呼吸道感染第2次距第1次至少要7天以上。②若上呼吸道感染次数不够：可加上下呼吸道感染次数。反之则诊断不能成立，需观察一年。

各地临床报道，小儿反复呼吸道感染与小儿免疫功能低下、某些微量元素缺乏有关。

中医认为，小儿为稚阴稚阳之本，抗病能力低下，易患

外感风热或外感风寒。因此，增强抗病能力，实为防治小儿反复呼吸道感染的良策。

中药治疗

方一：黄芪15克，加水煎熬，放冷，加维生素C50毫克，当酸梅汤饮用。

方二：黄芪15克，生姜6克，桂枝6克，白芍10克，煎水，加蜂蜜适量，当饮料饮用。

黄芪有增强免疫功能的作用，儿童常服有益无害。

方三：云芝肝泰冲剂，3岁以下每次服2.5克，每日3次。3岁以上每次服5克，每日服3次。连服3个月。

方四：增硒绞股兰颗粒剂15克，冲服，每日1剂，连服3个月。

按摩治疗

1. 揉太阳穴，每次轻揉50下，每日1次。
2. 推攒竹穴，每次轻推50下，每日1次。
3. 揉大椎穴，每次用中指或拇指揉100下，每日1次。
4. 揉足三里，每次揉50下，每日1次。

食物治疗

市售的花粉口服液，每日服2次，每次1支。

花粉口服液含丰富的氨基酸、微量元素和其他生理活性物质，有促进生长发育、增强耐力、提高免疫功能的作用。

58. 小儿肺部罗音久不吸收

小儿肺部罗音久不吸收多见于小儿肺炎恢复期，患儿的临床症状均有所缓解，但肺部罗音（包括干性罗音和湿性罗

音)久不吸收,影响康复。

中药内治法外治法并用,对消除肺部罗音有较好疗效。

中药疗法

(一)内治法

方药:黄芪30克,苡仁30克,赤芍10克,丹皮6克,冬瓜子10克,桃仁6克,大黄6克,合欢皮10克,白芨10克,山药10克。水煎服,每日1剂,连服10~20剂。

(二)外治法

方药:白芥子30克,苏子30克,香附30克,芜荑30克,食盐30克,食醋少许,细辛10克。共入铁锅中,在炉火上翻炒至芳香灼手,装入布袋内,立即在患儿脊柱及其两旁或罗音密集处来回推熨,开始可隔衣而熨,待药物温度下降,再直接熨于皮肤上,每日2次,6天为1疗程。可作1~3个疗程。

注:肺离背脊很近,该处皮下脂肪少,通过中药热敷,可促进背部血液循环,吸收炎性渗出,使肺部罗音很快消除。

捏脊疗法

患儿俯卧,医者在患儿左侧背后,先以两手食指指侧横压在长强穴,并向上推压,同时以拇指在脊部向下压,把小儿的尻部皮肤捏起,以左右两手交替向上,沿脊柱推压、捏至大椎穴,反复6次。第三、四次时,兼在脊椎上每隔1~3厘米,用隐力把肌肉拉起。捏完第六次后,另以大拇指从命门分向肾俞按摩两次,连续6天为1疗程。可作1~3个疗程。

59. 小儿毛细支气管肺炎

小儿毛细支气管肺炎是婴幼儿常见的一种呼吸道感染。这种病仅发生于2岁以前的小儿(6个月以内最多见)。本病的发生与小儿支气管系统的解剖学特点有关,因微小的管腔易因粘性分泌物、水肿及肌收缩而发生梗阻,并可导致肺气肿或肺不张。

本病由不同的病毒所致,常见的有合胞病毒、副流感病毒、腺病毒、鼻病毒等。

本病多发生于冬季或初春。

临床表现:常在上呼吸道感染以后2~3日出现持续性干咳和发作性呼吸困难。症状轻重不等,重者呼吸困难发展甚快。咳嗽与百日咳相似,出现喘憋。有的发烧,有的仅有低热甚至不发热。患儿可有呕吐或腹泻。由于肺气肿,常易影响吮奶及饮食。

喘憋发作时呼吸快而浅,每分钟呼吸可达60~100次以上。脉快而细,每分钟达160~200次。有明显鼻扇及三凹征。面色苍白、发绀,叩诊每呈鼓音。当毛细支气管接近于完全梗阻时,呼吸音明显减低。部分患儿可发生比较严重的脱水。

白细胞总数及分类大都在正常范围。

本病可通过X线检查及鼻咽分泌物细胞学检查等确诊。

小儿毛细支气管肺炎属于祖国医学的“咳喘”范畴。中医认为小儿脏腑娇嫩,形气未充,卫外不固,感受温热毒

邪，首先犯肺，灼津成痰，痰热瘀热相搏，交阻于气道，致使肺失肃降而发病。治宜宣肺清热，止咳平喘。

方一：生石膏30克，山楂6克，杏仁6克，炙麻绒6克，甘草6克，板蓝根10克，大青叶10克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂。

方中生石膏、板蓝根、大青叶均有抑制病毒的作用。山楂配生石膏更能有效地发挥生石膏的药效。杏仁止咳，炙麻绒平喘，甘草调和诸药。全方有抑制病毒，清热止咳平喘之效。

方二：僵蚕10克，天竺黄5克，沉香2克（研末冲服），车前草10克，鱼腥草10克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂，

加减：热甚者加生石膏，气喘严重者加苏子，紫绀严重者加丹参，正虚体弱者加太子参。

方中僵蚕，有清热化痰，平肝止痉的作用。现代药理学研究表明，僵蚕具有解热消炎、抗菌、抗病毒作用，并能迅速消除支气管充血、水肿；缓解支气管平滑肌痉挛。车前草清热利尿，并能排除支气管分泌物积滞，消除肺部湿罗音。天竺黄清热化痰。鱼腥草清热肃肺。沉香纳气归肾，疏通肠胃之滞。全方有清热豁痰、止咳平喘、止痉等功效。

60. 小儿腺病毒肺炎

小儿腺病毒肺炎是儿科的常见病。本病的潜伏期约3~8天，一般发热急骤，往往在1~2日内即达39°C以上的高热，至第3~4日多呈稽留或不规则的高热，多数病例的最高体温

可超过40°C。并有咳嗽，清涕，咽部充血，呼吸困难，发绀，指甲青紫，并逐渐加重，严重者出现鼻翼扇动，喘憋。发病3~4天以后可出现嗜睡，精神萎靡，有时烦躁与萎靡交替，严重者可出现半昏迷及惊厥，颈部强直，头向后仰，面色苍白，甚至面色发灰，心率增快（每分钟可达160~220次以上），心电图检查可呈现窦性心动过速或有ST波改变等，严重者可导致心力衰竭。半数以上患儿可出现消化系统症状，如腹泻、呕吐、腹胀等。腹泻可能与腺病毒在肠道内繁殖有关，也可能由于病情严重、发热而影响了消化功能。

患儿还可出现卡他性结膜炎、红色丘疹、斑丘疹、猩红热样皮疹以及扁桃体上石灰样小白点（不是所有病例均有此特征），这也是本病早期比较特殊的体征。

小儿腺病毒肺炎早期与一般细菌性肺炎不同之处表现为：①大多数病例起病时或起病后不久即有持续性高热，经抗生素治疗无效。②自第3~6病日出现嗜睡、萎靡等症状，萎靡有时与烦躁交替出现，面色苍白发灰，肝肿大，以后易见心力衰竭、惊厥等合并症。③肺部体征出现较迟，第3~5病日以后才听到湿性罗音，病变面积逐渐增大，叩诊呈浊音，呼吸音减低，喘憋于发发第2周日见严重。④白细胞总数较低。⑤X线检查肺部可有大片阴影。

小儿腺病毒肺炎属于祖国医学的“温病”范畴。小儿为稚阴稚阳之体，易虚易实，抗病能力低下，外邪入侵，首先犯肺，发热咳喘，风热闭肺，变证丛生。治宜宣肺透表，清热解毒。

辨证分型治疗

（一）邪热入里型：高热不退，气急纳差，腹胀，便溏，便中有粘液，舌红苔黑，脉数。治宜清热和胃导滞。

方药：银花15克，连翘15克，茯苓10克，法夏6克，莱菔子6克，大青叶15克，板蓝根15克，生石膏15克，山楂10克，神曲10克，葱白1枚，淡豆豉6克，甘草6克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

（二）风热闭肺型：高烧不退，咳喘，易惊厥，口腔溃烂，唇干裂，腹胀满，便溏，舌红无苔，少津，脉数。治宜清热宣肺，辛凉透表。

方药：桑叶15克，连翘15克，葛根15克，桔梗10克，芦根30克，僵蚕6克，蝉蜕6克，杏仁10克，贯众10克，板蓝根30克，葱白1枚，水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

验方治疗

方药：生地15克，丹参15克，丹皮10克，银花15克，连翘15克，红花6克，芦根30克，茅根15克，地骨皮10克，桃仁6克，杏仁6克，水牛角屑15克，板蓝根15克，大青叶15克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

高烧不退加服安宫牛黄丸3克，每日3次。

61. 小儿迁延性肠炎

小儿迁延性肠炎是儿科的常见病，患儿每日腹泻次数在5次以上，病程在15天以上，甚至长达数月，病情缠绵不愈，伴食欲低下，恶心呕吐，精神萎靡，面色苍黄，皮肤弹性差，严重者可出现脱水。大便多呈粘液状或绿色水样便，镜检可见脂肪球、白细胞，但无细菌生长。

小儿迁延性肠炎属于祖国医学的“泄泻”范畴。中医认

为多系脾胃虚寒所致。张景岳说：“泄泻之本，无不由于脾胃。”胃为水谷之海，脾为生化之源，若饮食失节，寒温不适，脾胃功能低下，纳运失调，精微物质无从吸收转输，则水反为湿，谷反为滞，精华之气不能输化，而使食物和水液混杂而下，则泄泻作矣。小儿迁延性肠炎的治疗，宜健脾导滞，止泻祛湿。

中药治疗

方一：伏龙肝（灶心土）30克（先煎，取澄清药液，再煎其他诸药），白胡椒3粒，全蝎2克，炮姜5克，炙甘草6克。水煎，少量多次服用，以免呕吐。每日1剂，连服20~30剂。

方二：党参15克，白术6~10克，茯苓6~10克，甘草6克，葛根10克，木香6克，藿香6克。水煎服，每日1剂，连服20~30剂。

加减：热甚者加黄芩、黄连。伤阴者去藿香，加麦冬、五味子、山药、沙参。阳虚者加附片、干姜。脾肾阳虚者加吴茱萸、补骨脂。久泻不止者加赤石脂、禹余粮。气虚下陷者加黄芪、升麻。汗多者加龙骨、牡蛎。

方三：红参4~6克，黄芪12~15克，当归5~10克，黄连4~6克。水煎服，每日1剂，连服20~30剂。

推拿治疗

（一）脐周团摩法：患者仰卧，医者以掌心置神阙穴上，以脐为中心，先作顺时针方向旋转5~10分钟，再作逆时针方向旋转团摩5~10分钟。团摩时，手法宜轻柔而缓慢，操作最好在饭后1小时后施行。每日施行2~3次。

（二）揉足三里法：患者仰卧或直坐，医者先用食指背屈按揉足三里穴3~5分钟，再以其余四指置小腿外侧阳

陵泉穴处向下至悬钟穴止，抚摩 2~3 分钟。按揉足三里穴位时，用力不可太大，以患者能耐受为度。抚摩小腿外侧时用力宜轻缓，主要为消除按揉后之不适。

(三) 捏脊法：患儿俯卧，医者将食指、中指作90°度屈曲，从小儿尾骶部长强穴起，将腰椎部的皮肤肌肉往上推，然后往下压捏，再沿着脊椎正中线的督脉不断向上推捏，直至颈部大椎穴止。每次捏 6 遍，每日捏 2~3 次。

62. 小儿神经性尿频

小儿神经性尿频是儿科常见病、多发病。以学龄儿童多发，在寒冷地区尤为常见。其特点是患儿在白昼有尿频尿急，每隔10~30分钟甚至几分钟即小便一次，但无尿痛，尿色白而清。患者夜间并不遗尿。

小儿神经性尿频无明显诱因，不呈进行性加重。尿常规检查无异常，无泌尿系感染之证据。本病数年不愈。如果用高锰酸钾液洗前阴，其症状也不见减轻。

中医认为小儿神经性尿频属肾气不固，膀胱失于约束所致。也有可能与轻微的湿热之邪蕴郁膀胱有关。治宜补中固肾。

中药治疗

方一：桑螵蛸15克，益智仁15克，黄芪10克，山药10克，共研细末，每次服 3 克，每日服 3 次。开水送服，连服10~30天。

方二：柴胡 6 克，炙甘草 6 克，枳实 6 克，山药10克，

乌药 6 克，益智仁 10 克，白芍 6 克，桃仁 6 克，赤芍 6 克。水煎服，每日 1 剂，连服 10~30 剂。

方三：太子参 10 克，桑螵蛸 10 克，黄芪 10 克，当归 6 克，升麻 6 克，柴胡 6 克，白术 6 克，陈皮 6 克，炙甘草 6 克，益智仁 10 克。水煎服。每日 1 剂，连服 10~30 剂。

方四：先服甲方：生地 10 克，通草 6 克，竹叶 6 克，篇蓄 6 克，瞿麦 3 克，车前草 6 克。水煎服，每日 1 剂，连服 3 天。继服乙方：熟地 10 克，益智仁 10 克，菟丝子 10 克，山药 10 克，补骨脂 6 克，芡实 10 克，五味子 6 克，甘草 6 克。水煎服，每日 1 剂，直至病愈。

针灸疗法

针刺穴位：气海、中极、关元、大椎、肾俞。进针得气后留针 20 分钟，中间行针 2 次。

艾灸穴位：气海、关元、中极。艾条灸 20 分钟（用回旋悬灸法）。

食物疗法

芡实 30 克，莲米 30 克，狗肉 100 克，共炖熟烂后食用，酌加盐、麻油、味精等调料。

63. 小儿急性偏瘫

小儿急性偏瘫是一种由许多疾病组成的神经系统综合征，而非独立的疾病。小儿平时比较健康，突然出现程度不同的一侧肢体瘫痪是本病的主要特征。

小儿急性偏瘫应排除遗传病、先天畸形或分娩过程中所

致的偏瘫。

小儿急性偏瘫分为症状性（获得性）偏瘫与特发性偏瘫（原因不明）两大类。原因不明的特发性偏瘫目前约占30%。

症状性偏瘫的病因大致有以下几种：

1. 各种感染。包括细菌感染、病毒感染、霉菌感染、钩端螺旋体病、寄生虫病等。
2. 持续性惊厥和癫痫持续状态引起的脑神经细胞损伤。
3. 外伤。
4. 心血管疾病。
5. 其他病因如红斑狼疮、结节性动脉周围炎、多发性大动脉炎、白血病、血友病、血栓性血小板减少性紫癜、糖尿病、风湿性脑血管病等均可导致小儿急性偏瘫。

临床表现：发病形式大致有三种。①暴发起病，高热，突然惊厥，意识障碍，或首先以癫痫持续状态发病，抽搐停止后即发生偏瘫。②偏瘫发展较慢，1~2天内症状明显，3~5天内达高峰。③反复发生短暂性偏瘫，数小时恢复，但多次发作后则成为永久性偏瘫。

偏瘫多发生于一侧，但有时双侧均发生偏瘫，或左右交替出现。发病2~3周后，偏瘫大多由弛缓性转变为强直性，2~3月后出现肢体挛缩。轻症偏瘫可于发病后1周内痊愈，也可经3~4个月才逐渐消退，约有半数病例偏瘫长久不愈，成为后遗症。

部分患儿可有感觉障碍或语言障碍。

部分患儿有局限性癫痫或癫痫大发作，也有的患儿在急性偏瘫1年后或数年后才出现癫痫。

智力障碍是小儿急性偏瘫的症状之一，患儿注意力不集中，过分激动、任性，学习成绩下降，与他人不合作，甚至出现严重的智力不足。

小儿急性偏瘫是一种综合征，平时健康的小儿突然发烧、惊厥、意识障碍，并出现明显的偏瘫者即可作出诊断。但需要通过腰穿、脑血管造影及CT检查等才能确诊。

小儿急性偏瘫属于祖国医学的“温病”、“痿证”、“痿痹”等范畴。中医认为“五脏使人痿”，不论痿痹、脉痿、筋痿……，其病均由于热。热毒炽盛，瘀阻经络，故肢体瘫痪不用，治宜清热通络。

偏瘫急性期治疗

方药：安宫牛黄丸，每天1粒，分3次服完，意识障碍患儿可用鼻饲。

偏瘫恢复期治疗

1. 中药治疗

方药：黄柏6克，苍术6克，川牛膝10克，苡仁20克，水蛭1克，当归10克，丹参10克，防己6克，萆薢10克，龟板10克。水煎服，每日1剂，连服10～60剂。

2. 针灸治疗

取穴：大椎、肩髃、曲池、合谷、外关、足三里、三阴交、阳陵泉、阴陵泉、膝眼、悬钟。

进针得气后留针30分钟，中间行针2～3次。每次任选以上穴位5～6穴。

3. 按摩治疗

(1) 摇肩法：患者直立或侧卧，医者以一手稳定患者肩部，另一手紧握患者手指，作顺时针或逆时针方向旋转摇动2～3分钟。摇动时，应嘱患者肌肉放松，摇动的幅度应根

据患者情况逐渐增加，忌用暴力，防止肩部肌肉撕裂伤。

(2) 推上臂三阳法：患者侧卧，左或右上肢平放于侧胸部，操作分以下三个步骤进行。

①以两手拇指对置于肩关节上方肩髃穴处，其余两手四指扶定上肢，自上向下沿上肢伸侧经臑会至肘尖上方天井穴止，反复操作2~3分钟。

②使患者肩部微向内收，前臂微向内侧旋转，以两手拇指对置，自腋后由上向下沿上臂侧推至肘尖后方小海穴止2~3分钟。

③使患者肩部微向外展，前臂微向外侧旋动，以两手拇指对置，自肩关节上方肩髃穴起，自上向下经臂臑、五里至曲池穴止，反复推动2~3分钟。推动时，在沿经起止点穴位上可配合按法。

(3) 推上臂三阴法：患者仰卧，左或右上肢平放于床上，手掌向上，医者坐其侧，操作分以下三个步骤进行：

①医者以两手拇指掌侧对置于腋前天泉穴处，两手其余四指扶定上肢，自上向下推动至曲泽穴止2~3分钟。

②以两手拇指对置于天府穴处，自上向下经侠白至尺泽穴止2~3分钟。

③以两拇指对置于极泉穴下，自上向下经青灵至少海穴止2~3分钟。

推动时，如患者皮肤干燥，可蘸酒以润滑。

(4) 梳手背法：患者直坐或仰卧，前臂放于桌上或床上，手掌向下，手指直伸，医者以手四指掌侧置腕关节阳池穴处，摩动时再将四指分置于1~2指、2~3指、3~4指、4~5指之间掌关节间隙，自上向下呈梳状摩动至液门穴平高处止，反复操作2~5分钟。操作时，患者掌心应尽量放平，

梳摩动作应缓慢而着力。

(5) 股内侧揉捏法：患者仰卧，两下肢伸直，医者以两手的四指置于股内侧上方阴廉、五里穴处、自上向下逐步下移，经阴包至膝下阴陵泉穴处止，反复揉捏3~5分钟。自上向下揉捏时，移动应缓慢而着力。在沿经之阴廉、五里、阴包、血海等穴处应配合按法。

(6) 股上、下刨推法：患者侧卧，左或右下肢屈起，另一下肢伸直。医者以一手拇指置股上方后侧，其余四指置前侧，自髀关穴平高处向下刨推；另一手拇指置股骨下方前侧，余四指置其后方，自梁丘穴平高处向上刨推，待两手刨推接近时，再以两手并置，两手拇指置股后侧，两手的四指置股前侧，将大腿肌肉向上拿提，操作3~5分钟。刨推时，主要为拇、食指关节合成之“虎口”处掌侧用力，拿提时以各指端之掌侧着力。上下刨推可适用于股前、后、内、外侧，视病情需要而定。用力大小以患者能耐受为度。如患者皮肤干燥，可蘸酒或使用滑石粉，以防止擦伤皮肤。

(7) 下肢外伸法：患者侧卧，两下肢伸直，医者以左或右手掌置患者左或右下肢髁嵴处按压固定髁关节，另一手置膝关节内侧曲泉穴处，手指扶定膝关节，自内向外上方引伸，反复操作3~5分钟。操作时，髁关节应着力固定，向外上方牵伸时，应缓慢有力。牵伸应逐渐增加角度，以患者能耐受为度。

(8) 单屈膝旋髁法：患者仰卧，左或右下肢屈起，另一下肢伸直，医者以一手握左或右下肢的足内、外踝上方之三阴交、悬钟穴处，另一手掌心置膝上，以手指固定膝关节，然后将其下肢尽量曲屈下压至与腹部相接后，再向左或向右作环形旋转5~15次。屈曲下压至腹时动作宜缓慢，逐渐

增加弯曲度。旋转时应缓慢而有节律，旋转幅度应以患者能耐受为度。

(9) 小腿内侧揉捏法：患者仰卧，两下肢伸直，医者以两手的四指并置于小腿内侧阴陵泉穴处，拇指置股外侧阳陵泉穴处，自上向下逐渐下移，经地机、漏谷、三阴交至踝下照海穴处，再以四指摩动经然谷至隐白穴止，并将足大趾向下按压，反复操作3~10分钟。捏揉向下移动时应缓慢，在阴陵泉、地机、漏谷、三阴交穴位处可配合按法。

为了预防小儿急性偏瘫患肢水肿和挛缩，应将患肢放在功能位置以防止挛缩，各关节每天作被动性活动。小儿急性偏瘫自弛缓性转变为强直性之后，宜多作按摩、针灸及体育疗法等辅助治疗。病情稳定后，要鼓励患儿作自主活动，加强锻炼。

64. 幼儿蛲虫感染性阴道炎

幼儿蛲虫感染性阴道炎是由蛲虫引起的外阴和阴道炎症，多由不注意外阴清洁卫生所致。

患儿外阴及肛门瘙痒，外阴及前庭粘膜红肿，阴道流出脓性分泌物或黄绿色白带，分泌物化验可发现蛲虫卵及大量脓细胞，大便化验也可查见蛲虫卵。

患儿烦躁不安，食欲不振，或伴腹泻，消瘦，毛发枯槁、精神不振，舌红无苔。

中医认为幼儿蛲虫感染性阴道炎系虫栖肠胃，阻碍运化，湿热下注所致。治宜驱虫导滞，清热利湿。

内治法

方药：雷丸6克，鹤虱6克，使君子6克，苦楝皮6克，熟大黄1克，枳实1克。水煎服，每日1剂，连服7日。

外治法

方一：食醋（质量好的瓶装醋）适量。用棉花蘸醋在幼儿入睡后塞肛门，以杀死肠道内爬至肛门产卵的蛲虫。

方二：苦参15克，蛇床子10克，马齿苋15克，大青叶15克，鹤虱6克，苦楝皮10克，煎水放冷后冲洗外阴、阴道及肛门。

方三：百部10克，鹤虱15克，苦楝皮30克，共研细末，装入空心胶囊，于患儿熟睡后塞入肛门内（最好先塞此胶囊，再用蘸食醋棉花塞在肛门处）。

65. 幼女性阴道炎

幼女性阴道炎多与外阴炎并存。因幼女雌激素缺乏，阴道抗病能力低下，故易受感染而引起炎症。病原体可通过患孩的母亲、保育员或幼儿园儿童的衣物、浴盆、手等传播。也可由卫生习惯不良、外阴不洁等因素引起。病原体有葡萄球菌、链球菌及大肠杆菌等，滴虫或霉菌也可引起幼女性阴道炎。

此外，外阴损伤或抓伤，蛲虫感染等均可导致幼女性阴道炎。个别幼女误放异物于阴道也可引起阴道炎。

大量脓性分泌物刺激外阴，可引起外阴痛痒，患儿哭闹

不安，以手抓外阴。外阴红肿，表面可见破溃，小阴唇可有粘连，阴道有脓性分泌物。

幼女性阴道炎属于祖国医学的“阴痒”范畴。小儿为稚阴稚阳之体，抗病能力低下，外阴不洁，湿毒之邪内侵，虫蚀感染。其治疗，宜清热解毒，祛湿杀虫。

内治法

方药：银花15克，连翘10克，蒲公英10克，紫花地丁15克，野菊花10克，赤芍10克，丹皮6克，知母6克，黄柏6克。水煎服，每日1剂，连服7～20剂。

外治法

方一：苦参30克，黄连10克，黄柏10克，白头翁60克。加水浓煎，待冷后冲洗阴道及外阴。

方二：千里光60克，银花30克，土茯苓30克，百部30克。加水浓煎，放冷后冲洗阴道及外阴。

方三：鹤虱10克，芜荑10克，苦参30克，川椒6克，黄连10克，加水浓煎，放冷后加入食醋5～10毫升及大蒜汁5滴，冲洗阴道及外阴。

方四：土槿皮20克，土茯苓30克，车前草30克，黄柏15克，白矾10克，加水浓煎，放冷后冲洗阴道及外阴。

幼女性阴道炎虽不多见，但家长要对女孩的卫生习惯加以重视，一旦发现幼女外阴红肿、哭闹不安，应加以重视，积极治疗，并预防蛲虫感染。对衣物、浴盆等，均要保持清洁，定期消毒，以防止幼女性阴道炎的发生。

66. 小儿过敏性包皮水肿

小儿过敏性包皮水肿，农村小儿夏秋季多见，常因小儿席地玩耍（小儿穿开裆裤），接触过敏物质所致。表现为阴茎水肿，包皮肿大发亮，疼痛刺痒难忍，来势较急。

中医认为小儿过敏性包皮水肿多系湿热之邪或风邪容于肌肤。小儿稚阴稚阳之体，抗病力弱，邪凝毒滞，发为本病。治宜清热解毒，祛湿消肿。

方一：石苇30克，柴胡30克，生地榆30克，黄柏30克，白芨6克，白藓皮30克，地肤子30克。煎汁，放冷后，药汁浸湿纱布，翻起包皮，给以持续湿敷，干后再用药汁滴湿纱布，继续湿敷，直至痊愈。

方二：鹅口对准阴茎呵气。一人抓住鹅腿，另一人将鹅口用手掰开，将小儿阴茎伸入鹅口内，待鹅呵气数口即可。

方三：山栀子30克打碎，浸入普通白酒60毫升中，浸泡30分钟，用煮沸消毒的鹅毛蘸栀酒，反复涂搽患处，一般1天可愈，最慢者3天消肿。用药后无不良反应及副作用。

方四：青木香15克、栀子15克。将上药加水适量煎成浓液，去渣备用。先将患儿外阴部洗净擦干，然后用消毒棉签蘸药液反复轻轻涂抹患处（每次约5分钟），药液涂到阴茎根部效果更好。每天涂2~3次。

方五：将鸭子灌入少许明矾水，或塞入少许生姜，然后将鸭子倒挂候涎液，用消毒棉签蘸鸭涎液涂小儿阴茎。

外科

67. 外伤性截瘫

外伤性截瘫是因脊髓损伤引起受伤平面以下的双侧肢体瘫痪。临床常见双下肢瘫痪。若截瘫平面较高，双上肢亦可受累（称为高位截瘫）。受累部位运动及感觉完全或部分消失，合并大、小便功能障碍。

外伤性截瘫的脊髓损伤分开放性损伤与闭合性损伤两种。开放性脊髓损伤多由战时火器外伤引起，闭合性脊髓损伤多见于高处坠下、重物压砸、翻车撞车、房屋倒塌等意外事故，是脊椎骨折脱位的严重并发症。

临床表现

1. 脊髓震荡：损伤平面以下的运动、感觉、反射和内脏功能不完全障碍，伤后数小时即有恢复表现，一般在数日至数周后，可完全或大部分恢复。

2. 脊髓横断损伤：多发生于第二腰椎以上的脊椎骨折和脱位，其损伤平面以下的躯干和肢体的感觉、运动和反射均完全丧失，大小便失控。脊髓横断损伤的早期，因伴有脊髓震荡，损伤平面以下肌肉呈弛缓性瘫痪，肌张力降低，感觉和深浅反射均消失，发生尿潴留。经过数日或数周，脊髓震荡恢复后，损伤平面以下的肌肉由弛缓变为痉挛性瘫痪，肌张力增强，腱反射亢进，但感觉仍无恢复。

3. 马尾神经损伤（第二腰椎以下没有脊髓神经，只有马尾神经）：严重外伤引起马尾神经断裂或受压，临床呈现不完全性截瘫。如果马尾神经完全断裂，则断面以下肢体的

感觉、运动和反射完全消失，肌张力减弱，呈弛缓性瘫痪，膀胱失去神经支配，不能自主排尿，出现满溢性尿失禁。

外伤性截瘫属于祖国医学的“体惰”、“血瘀痿”等范畴。《灵枢》说：“若有所堕坠，四肢懈惰不收，名曰体惰。”《素问》说：“人有所惰坠，恶血留内，腹中胀满，不得前后。”中医把外伤性截瘫分为软瘫和硬瘫，软瘫多属虚证，硬瘫多属实证。中医还认为，外伤性截瘫属于督脉损伤所致。督脉能督周身之阳，称“阳脉之海”，手足三阳经脉皆与之交会，具有统督全身阳经经气之功。当督脉损伤，经气阻滞，三阳经脉亦受其害，阳明虚弱，肢失濡养，萎软不用，知觉缺失。经病及腑，则见二便失控。治宜活血化瘀，疏调督脉，通经活络，补益精髓。

中药治疗

（一）辨证分型治疗

1. 瘀血阻滞型：外伤引起，腰背部肿胀，压痛，后凸畸形，下肢麻木不仁，活动受限，皮肤紫暗而冷，二便不利，舌青紫，苔白，脉沉涩。治宜活血化瘀，疏经通络。

方药：当归30克，桃仁10克，红花10克，三七粉6克（冲服），土鳖虫10克，煅自然铜20克，骨碎补10克，狗脊30克，乳香10克，没药10克，山甲15克，地龙15克，王不留行10克。水煎服，每日1剂，连服两个月。

2. 血脉瘀阻，脾肾阳虚型：下肢痿软无力，麻木不仁，肢端冰冷，站立困难，面色晄白，食少便溏，遗尿，舌淡苔白，脉沉细。治宜温补脾肾，活血养血。

方药：续断30克，补骨脂10克，骨碎补10克，菟丝子15克，狗脊30克，鹿角胶15克，土鳖虫10克，马钱子末0.3克（冲服），当归30克，豨莶草30克。水煎服，每日1剂，连

服两个月。

3. 血脉瘀阻,肝肾阴虚型:腰酸背痛,肢体麻木不仁,时发痉挛,五心烦热,低热盗汗,头晕目眩,咽干口燥,舌红无苔,脉细数,治宜活血滋阴清热。

方药:当归30克,龟板30克,淮牛膝30克,白芍30克,熟地30克,乌梅15克,伸筋草30克,土鳖虫10克,枸杞15克,黄精30克,地龙30克,山甲15克。水煎服,每日1剂,连服两个月。

(二)分期治疗

1. 早期

方药:狗脊30克,红花10克,血竭6克,当归30克,赤芍30克,骨碎补10克,地龙15克,丹参30克,三七粉3克(冲服),土鳖虫10克,乳香10克,没药10克。水煎服,每日1剂,连服1~2个月。

2. 中期

方药:党参30克,黄芪90克,杜仲15克,益智仁10克,仙灵脾30克,山药30克,威灵仙30克,当归30克,淮牛膝30克,白术15克,甘草10克。水煎服,每日1剂,连服1~2个月。

3. 晚期

方药:川牛膝30克,淮牛膝30克,苍术15克,续断30克,狗脊30克,麻黄10克,全蝎10克,僵蚕10克,乳香10克,没药10克,马钱子0.3克(冲服),熟地30克。水煎服,每日1剂,连服1~2个月。

(三)专方治疗

方一:党参30克,黄芪60克,茯苓15克,白术15克,当归30克,川芎10克,赤芍30克,熟地30克,木瓜30克,淮牛

膝30克，狗脊30克，杜仲15克，制附片10克（先熬），三七粉6克（冲服），鸡血藤30克。水煎服，每日1剂，连服10剂，再服方二。

方二：杜仲15克，枸杞15克，地龙30克，续断30克，桃仁10克，红花10克，乳香10克，没药10克，熟地30克，当归30克，白芍30克，川牛膝30克。水煎服，每日1剂，连服10剂，再服方三。

方三：山萸30克，菟丝子15克，枸杞15克，地龙30克，党参30克，黄芪60克，当归30克，木瓜30克，淮牛膝30克，狗脊30克，熟地20克，杜仲15克，苏木10克。水煎服，每日1剂，连服10剂。

以上三方，须轮流服用，每方服用10天后轮换服用。

针灸治疗

（一）体针治疗

取穴：损伤平面上下各1~2个棘突的督脉穴，或损伤平面上下各1~2个棘突间的夹脊穴，关元，中极，天枢，秩边，殷门，委中，昆仑，髀关，伏兔，足三里，阳陵泉，绝骨。

方法：直刺进针，提插。腰背部穴位提插时手下如出现电掣样感觉应停止进针。下肢穴可提插、捻转结合。腹部穴针刺前应排空尿液。

（二）电针治疗

取穴：会阳，秩边、承扶、委阳、委中、承山、昆仑、复溜、照海、太溪、涌泉、伏兔、阴市、足三里、丰隆、血海、阳陵泉、阴陵泉、三阴交、悬钟（轮流选用）。

进针后，针柄上接电疗机（脉冲电流），电流强度以患者能耐受为度，使局部肌肉呈节律性跳动，留针30分钟，每日1次。

穴位注射治疗

取穴：腰俞、秩边、殷门、伏兔、足三里、阳陵泉、委中、承山、血海。

药物：维生素B₁、B₁₂针剂各100毫克混合后注入以上穴位（每次选用4~5穴），每穴注射药物0.5毫升，隔日1次。

推拿治疗

在以上介绍过的穴位及其附近区域进行按、揉、推、拿、提等手法。

TDP照射治疗

TDP照射腰背部及下肢，每日1次，1个月为1疗程，需5个疗程。

功能锻炼

外伤性截瘫患者进行功能锻炼是治疗中不可忽视的部分，它不仅可以防止肌肉萎缩，防止关节僵直，而且为以后肢体功能的重建奠定基础。锻炼时，初教患者凭自己上肢之力，作活动腰胯、伸腿蹬足、爬行等练习，继则作左右翻身、靠坐、扶坐、自坐、床边垂足坐、扶跪、自跪、跪行、床边靠站、扶物自站、双足向前滑行、扶物原地踏步，以至持拐、人扶、提腰拖行等锻炼。

68. 手术切口久不愈合

手术切口久不愈合系指外科、妇产科等手术后，切口迟迟不愈合，长达数十天甚至更长。有渗出物多，切口周围皮

肤颜色暗淡，给患者造成很大痛苦。

中医认为手术切口久不愈合多由气虚血瘀所致。治宜补气益血，活血化瘀。

内治法

方药：黄芪90克，当归30克，白芨30克，合欢皮15克。水煎服，每日1剂，直至切口愈合。

外治法

方一：先用双氧水、生理盐水清洁创面。渗出物少者，创面上涂万花油，再撒一层云南白药（约0.3~0.7克）。若渗出物多者，万花油与白药混合（3:1）成糊剂外涂伤面或填入伤口，每天换药1次。

方二：蜂蜜适量。将外科应用的纱布条浸入盛有蜂蜜的带盖容器里，行高温、高压灭菌消毒后备用。用时对切口作常规处理，保持相对无菌状态。再将蜂蜜纱布条覆盖在整个切口上，外用无菌纱布包扎固定。1~3天一换。

《本草纲目》载蜂蜜能“解毒，止痛”。现代研究认为蜂蜜能加速伤口（包括手术切口）愈合，因蜂蜜可抑制革兰氏阳性或阴性细菌生长，切口局部在分解代谢的情况下有极佳的能量来源。蜂蜜还有吸湿作用，可减轻水肿，构成粘胶屏障，防止切口被细菌侵犯。

69. 药物性龟头炎

药物性龟头炎是一种变态反应性疾病，是因某种药物进入体内后引起龟头粘膜的炎症反应。表现为局部痒痛、红

肿、渗液、糜烂。可引起龟头炎的药物有：磺胺、鲁米那、安乃近、APC等。过敏体质的患者服用上述药物后即易导致龟头炎。

药物性龟头炎属于祖国医学的“湿阴疮”范畴。中医认为系风、湿、热搏结所致。治宜清热解毒燥湿。

内治法

方一：知母12克，黄柏12克，龙胆草12克，七叶一枝花20克，元参15克，白芷6克，蝉蜕10克，苡仁30克，丹皮15克，赤芍30克。水煎服，每日1剂，直至痊愈。

方二：生地30克，木通10克，竹叶10克，甘草梢10克，龙胆草15克，泽泻30克，石苇30克，桂枝10克，银花30克，连翘30克，赤芍33克，人参叶30克。水煎服，每日1剂，直至痊愈。

外治法

方一：七叶一枝花60克，生甘草60克，煎水三碗，外洗患处。

方二：人参叶30克，七叶一枝花30克，野菊花30克，黄芪60克，白芷15克，紫草30克。水煎，纱布蘸药液湿敷患处，或用药液洗患处，每日洗3~4次。

方三：苦参60克，蛇床子30克，黄柏20克，荆芥15克，生苍术20克，蒲公英30克，紫花地丁30克。地肤子30克，川椒10克，枯矾6克。煎水熏洗患处。

方四：黄芩30克，银花30克，蛇床子30克，苦参30克，黄连20克，紫草20克，香附20克，鱼腥草40克，大黄10克，川芎10克，甘草15克，土茯苓30克，蒲公英30克。加水煎30分钟，用纱布过滤，再将冰片4克，芒硝10克兑入药液中溶化，凉后洗患处20分钟。用过的药液再煎10分钟后第二次再用，每日洗4~6次。每剂用3天。

70. 化脓性肉芽肿

化脓性肉芽肿是一种后天性、良性结节状肿瘤。由新生成的血管组成，迅速长大，但到一定大小即停止生长。

皮损常隆起有蒂，红色或棕红色，无自觉痛或压痛，也不能压缩。轻度外伤即易出血，而且出血量较多。肿瘤直径约5~10毫米，也可达到数厘米。可发生于身体各处，但好发于容易外伤的露出部位。新生儿则易发生于脐部。

化脓性肉芽肿须通过病理切片检查确诊。

化脓性肉芽肿宜用外治法治疗：

方法：胶布一块，按肉芽肿瘤体大小剪一孔套上，以护围正常皮肤，然后用棉球以生理盐水浸湿后，轻轻撒上薄薄一层白降丹粉末，盖敷于瘤体上，周围再用少量消毒棉球垫压，外加胶布固定。等2~3天便可取下，瘤体呈灰黑色，自行脱落，或用剪刀剪去坏死组织。坏死组织较大者可分2~3次腐蚀及修剪，同时注意修剪周围“缸口”状皮肤。消除瘤体后，用20%生理盐水湿敷至愈合。

白降丹由硝石、白矾、水银等组成，外用能拔毒去腐。因白降丹毒性较强，临床上一一般少用此药。但化脓性肉芽肿反复生长，不易根治，故以毒攻毒，用白降丹使瘤体腐蚀坏死，并使之与正常组织分离，继而修剪周围阻碍表皮生长之“缸口”，促使正常组织生长，表皮自然愈合。

71. 颈肩综合征

颈肩综合征是一种发生于老年人的炎症性退行性病变，是一种综合症状。可由颈椎病、颈部急性软组织损伤、颈背肌筋膜炎、颈椎小关节紊乱、胸椎后关节紊乱、背部外伤、肩周炎、肩峰下滑囊炎、肩部外伤、肱二头肌长头腱鞘炎等引起。

诊断要点：①本病多发生于40岁以上的中老年人。②X线片证实有颈椎骨质增生或伴有椎间隙变窄、颈韧带钙化等病理改变。③肩臂胀痛、酸痛、放射痛痉挛性疼痛，夜间尤甚。压痛点主要在肩内陵、肩外陵三角肌、肱二头肌长头肌腱等处。④病程在3个月以上者多半形成肩关节粘连，出现不同程度的功能障碍，后期可有肌肉萎缩。⑤椎间孔压缩试验及臂丛牵拉试验阳性。

颈肩综合征属于祖国医学的“骨痹”、“肩痹”等范畴。多因督阳痹阻，经络不通所致。中医认为，脾主运化，主统血，主四肢肌肉。颈肩综合征主要原因为气血不足，营卫不固，致风寒湿邪乘虚而入。

颈肩综合征的治疗，宜活血化瘀，益气通络。

中药治疗

方药：桂枝15克，桃仁15克，茯苓30克，黄芪60克，防风10克，羌活10克，桑枝30克，杜仲15克，淮牛膝30克，木瓜30克，当归30克，党参30克，鸡血藤30克，补骨脂15克，骨碎补15克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

加减：阳虚加附片。阴虚加龟板、知母、生地。筋挛加

地龙、乌蛇。血痹痛甚加桃仁、红花、丹参。

针灸治疗

1. 取穴中平奇穴（在足三里下1寸处，偏于腓侧）直刺，留针30分钟，每10分钟行针1次。

2. 针刺风池、肩井、肩髃、臂臑、曲池、手三里、外关、合谷、后溪、太阳。留针30分钟，每日1次，10次为1疗程。可作1~3个疗程。

点穴治疗

用拇指、食指点揉、按压风池、大椎、肩井、肩髃、肩胛内缘侧以及健侧肩关节腋前腋后、手三里、中渚穴。每穴点揉按压1分钟。

双极磁镊针按压（穴位同上）。

按摩治疗

（一）捏颈肌法

患者俯卧或直坐，头微前倾。医者坐或站其侧方，以两手并置一侧之枕后风池穴处，拇指在颈肌外侧，其余四指并置颈项肌内侧，将肌肉微向上提起后，再自上向下拿捏至肩中俞穴止，操作5~6分钟。左侧颈肌拿捏后再施用于右侧。

拿捏向下移动时宜缓慢，用力宜均匀有力，以局部微红为度。操作时有拉扯及肌肉酸胀感，治疗后有头脑清爽、颈项活动灵活的感觉。

（二）拿肩井法

患者取坐位，医者坐或站其后方，以手四指置肩后或两手四指掌侧置肩后，拇指掌侧置肩井穴处，着力向上拿捏5~6分钟。

手法用力大小，以患者能耐受为度。拿捏后可用轻柔的指揉手法，以消除拿捏法后之不适。治疗时局部有沉重、

酸、胀感，治疗后同侧肩背、颈项及上肢有轻松舒适感。如拿两侧肩井穴，则有头脑清爽、增益精神的感觉。

（三）揉大椎阳关法

患者直坐，头向前倾，医者坐其侧，以拇指掌侧揉背部之上方大椎穴2~5分钟，再指揉腰部之阳关穴1~3分钟。然后以掌心先后置上述两穴，作旋转团摩3~5分钟。

指揉大椎穴应较指揉阳关穴用力稍大。团摩时动作应缓慢而有力，以皮肤微汗为度。指揉时局部有酸胀感，团摩时有温热感，治疗后颈背部有舒适感。

（四）掌推肩胛法

患者直坐或侧卧，医者站或坐其侧，以一手拿定患者左或右肩，并向后方掀扳，另一手用掌根推自肩中俞穴沿肩胛脊柱缘经膏肓穴，向外下方斜推至腋中线止，反复掌推2~3分钟。

操作时患者头向右仰，向前挺胸。在掌推至膏肓穴时应着力推动，并同时使患者咳嗽。在肩胛上部掌推时用力应较肩胛下部为重。治疗时有重压感，治疗后有局部温热感。

（五）摩按肩周法

患者直坐，医者坐其侧，以双手自病侧颈项部沿肩峰与肩胛区反复摩按5~10分钟。再自患侧肩峰、三角肌处向肘部、腕部顺序向下，反复摩按5~10分钟。

摩按肩部时应摩动肌肉，不应限于摩擦皮肤。摩按用力应均匀而有节律，用力大小以皮肤微红为度。

72. 岗下肌综合征

岗下肌综合征为岗下肌急慢性劳损产生的无菌性炎症反射而产生的一组上肢、胸壁疼痛症候群。临床表现为一侧肩背酸痛，上臂沉重麻胀，乏力，不适。少数病人有胸部缩窄感，多数病人不感肩胛部疼痛，故常误诊为颈椎病。检查时颈肩活动度无异常，可发现一侧岗下肌有条索状硬物，压之疼痛难忍，有不同程度的向同侧上臂反射。应排除颈椎病、肩周炎等疾病。

岗下肌综合征多发生于伏案书写的人员，长期伏案工作，可使岗下肌、下圆肌紧张而产生劳损。

凡上肢沉重麻木胀痛的患者，检查无颈椎病、肩周炎，而岗下肌有压痛。按压痛点可使其原有症状加重，手法按摩片刻后症状减轻或消失者，则可诊断为岗下肌综合征。

岗下肌综合征属于祖国医学的“痹证”范畴。中医认为跌仆劳损，加之风寒湿邪乘虚而入，客于筋肉，阻遏经络，气血凝滞，运行不畅，筋肉失其濡养，不通则痛。《症因脉治》说：“凡痹之因，或元气不充，或病后体虚，或饥饿劳役，风邪乘之，则风痹之证作矣。”《医林改错》说：“凡肩痛、臂痛、腰痛、腿痛……总名曰痹证。”

岗下肌综合征的治疗，宜活血通络。

手法治疗

方法一：医者以拇指指尖或指腹持续垂直加压于岗下部激痛点上，由轻到重，使患者逐步适应，使压痛向上肢或胸肌

原痛区反射。然后逐渐改变拇指推压方向，变作用力与肌纤维侧方垂直，使筋束被推向一侧，再作弹拨和旋转按揉，以剥离粘连，缓解肌痉挛，消结止痛。每天操作一次。

治疗期间患者应适当挺胸、旋转肩关节，配会治疗。

方法二：用手法重拨、理筋为主，揉按及手攀悬吊为辅。医者用拇指触摸条索状物或压痛点以确定病位，以拇指在患侧肩胛内角下方岗下肌触及条索状硬物后，尽力按住，然后左右弹拨3~6次，用力由轻而重，以患者能忍受为度。继而沿岗下肌走向自内下往上顺理5~10次，至拇指下条索状硬物不能明显触到，最后用掌根部滚揉痛处及大小圆肌数次。

施术时患者甚感疼痛，并向同侧手臂反射麻胀。但术毕患者即感肩背酸痛骤减，胸背舒畅，肩臂轻松自如。

4天施术一次。治疗期间，患者可配合进行功能锻炼，即双手攀住单杠，身体悬空作引体向上运动。

中药治疗

（一）内治法

方药：黄芪60克，茯苓30克，当归30克，桃仁12克，桂枝15克，乳香10克，没药10克，三七粉6克（冲服），山甲15克，络石藤30克，肿节风30克。水煎服，每日1剂，连服30~60剂。

（二）外治法

方一：麝香虎骨膏，外贴患处。

方二：麝香舒活灵（成药，药水）外涂患处。

方三：土鳖虫30克、蜈蚣2条，山栀15克，大黄10克，血竭6克，白芷10克，全蝎6克，共研细末，白酒调敷患处，外贴麝香虎骨膏，胶布固定，每日换药1次。

中药治疗期间，同样须配合作功能锻炼，以提高疗效。

73. 骨筋膜间隔区综合征

骨筋膜间隔区综合征, 又称骨-筋膜室综合征、缺血性肌挛缩症、挤压综合征、创伤性张力性肌肉缺血、运动性缺血症、肌群高压症等, 是由于创伤后肢体血脉损伤或受压, 血供不足, 引起肌肉变性、坏死, 结果形成瘢痕、挛缩而影响其功能的一种严重病征, 是骨伤科的常见病。

筋膜间隔区是由肌间隔、深筋膜与骨间膜等构成, 几乎闭合而少弹性, 血管与神经大多通过其中。肢体受到创伤, 长时间受压, 剧烈运动, 或筋膜室内肿物等因素影响, 而致骨筋膜室内压力增高, 阻断室内血液运行, 使室内肌肉、神经等组织缺血失养。缺血后毛细血管内渗透压迅速升高, 大量血浆和液体渗入肌肉和神经组织间隙, 形成组织瘀血水肿, 进一步增高室内压力, 使缺血进一步加重。这样, 缺血水肿恶性循环, 最终导致肌肉组织大量坏死。坏死组织毒素进入血液循环, 使体液代谢紊乱, 酸碱平衡失调, 引起心、肝、肾等器官功能失调而成本病。

临床上遇到急性损伤、肢体长时间受压或剧烈运动病史, 又有患肢灼痛难忍、肿胀、张力高, 被动牵引该筋膜室内肌肉则疼痛加剧, 或患室内肌肉肌力减弱, 或肢体远端动脉搏动消失, 或局部皮肤青紫、苍白, 感觉异常等时, 应首先考虑骨筋膜间隔区综合征。本病早期也可能肢体肿胀不甚明显, 远端血液循环、运动感觉均好, 仅肢体局部深层灼痛难忍, 表皮麻木, 这也是神经肌肉缺血的表现, 应进一步检

查确诊。也可结合全身症状，如肢体肿胀一段时间后患者出现发热、烦躁、呼吸深长、恶心、呕吐、口渴引饮、神志不清、血压下降、脉搏加快，尿中出现肌球蛋白等也应疑为本病。换言之，当患者肌肉丰富的部位受重物挤压，在重物移去后，随之而产生的病症（包括急性肾功能衰竭），应首先考虑为本病。如在塌方时，伤员被大量的土块、石头或重金属物挤压1小时、几小时或更长一些时间后获救，即有可能发生本病。因此，凡肢体受压的伤员，受压时间超过1小时以上，均有发生挤压综合征的可能。有的伤情较轻，在伤后好几天才发现少尿、血尿、高血钾等，应提高警惕。

本病有如下特点：①肢体肿胀、疼痛与原发损伤不符。②伤肢肿胀，有偏侧性紧张发硬。③受累肢体牵拉试验阳性（受累肢体肌肉被动伸展活动引起疼痛）。④伤后可出现肾功能衰竭及继发性神经损害体征。

骨筋膜间隔区综合征属于祖国医学的“痿证”、“跌打损伤”等范畴。多由肢体损伤后，血溢脉外，瘀血蓄积，凝滞肢体筋膜间隔区内，引起区内压力增高，微循环障碍和组织损害。《内经》说：“经脉者，所以行气血而营阴阳，濡筋骨而利关节也。”治宜活血化瘀，利水通络。

分期治疗

（一）少尿或无尿期：二便不通，腹胀，水肿，口干渴，苔腻或干，脉滑数。治宜化湿利水。

方药：丹参30克，茯苓30克，冬瓜皮60克，大腹皮15克，泽泻30克，桃仁12克，天花粉12克，红花12克，黄芪30克，生地30克，厚朴10克，黑白丑各5克。水煎服，每日1剂，连服10～20剂。

（二）多尿期：尿量多，面色苍白，出汗，舌红无苔，

脉细无力。治宜益气养阴固肾。

方药：山萸30克，芡实15克，覆盆子15克，五味子15克，黄芪30克，党参30克，黄精30克，木香10克，石斛15克。水煎服，每日1剂，连服10～20剂。

加减：高血钾加大黄50克煎水300毫升保留灌肠。发烧加银花、连翘各30克。

（三）恢复期：尿毒症解除。但肢体、肌肉尚肿痛，脉弦无力。治宜益气养血，通经活络。

方药：当归30克，鸡血藤30克，党参60克，黄芪30克，木瓜30克，桃仁12克，丹参30克，木香10克，川芎10克，伸筋草30克。水煎服，每日1剂，连服10～20剂。

辨证分型治疗

（一）瘀阻脉络型：跌打损伤后，肢体肿胀掣痛，压痛明显，肢端麻木，屈伸无力，舌青紫，脉涩。治宜活血化瘀，消肿通络。

方药：当归30克，川芎10克，党参30克，三七粉6克（冲服），赤芍30克，黄芩30克，木通10克，泽兰15克，乳香10克，没药10克，橘络10克，大黄10克。水煎服，每日1剂，连服1～3个月。

（二）肝肾亏虚型：损伤后期，筋腱拘挛，肢体萎废，手或足呈爪状畸形，麻木不仁，活动障碍。舌红少苔，脉细弦。治宜补益肝肾，滋阴清热。

方药：知母10克，黄柏10克，龟板30克，熟地30克，锁阳15克，白芍30克，女贞子30克，菟丝子15克，仙灵脾30克，虎骨30克。水煎服，每日1剂，连服1～3个月。

专方治疗

方一：水蛭3克，土鳖虫10克，大黄10克，木通15克，

泽兰10克，三七粉10克（冲服），当归20克，炮甲珠15克，桃仁10克，生地30克，赤芍30克，蒲公英30克，丹皮12克，黄芪30克。水煎服，每日1剂，连服1~3个月。

方二：苏木10克，乌药10克，续断30克，当归30克，赤芍30克，生地30克，乳香10克，没药10克，大黄10克，木香10克，泽兰15克，桃仁10克，红花10克。水煎服，每日1剂，连服1~3个月。

方三：猪苓30克，地龙30克，车前草30克，黄芪30克，川芎10克，鸡血藤30克，当归30克，白术30克，茯苓30克，桃仁10克，红花10克。水煎服，每日1剂，连服1~3个月。

74. 胸椎小关节紊乱症

胸椎小关节紊乱症在临床上并不少见。但由于本病临床表现复杂，加之X线检查常不易察觉（改变不显著），故常易误诊和漏诊。

临床表现：背部疼痛而无定点，不能固定某种姿势持续工作、休息，需反复改变体位方能暂时缓解，夜间因疼痛而失眠、多梦，白天精神萎靡。背部疼痛呈持续性，休息后无明显减轻，且疼痛与天气变化无关。两肩胛间大面积酸、困、钝痛，痛无定点。也有患者表现为胁肋疼痛，心前区疼痛（但心电图正常）。

诊断依据：①胸背部大多数无外伤史。少数患者因劳累、闪挫而突然诱发本病。②胸椎2~7夹脊穴或膀胱经循行处有酸胀、钝痛和明显散在的压痛。③背肌紧张，旋转后伸

活动受限。④X线胸椎平片检查、血沉、抗“O”检查均无异常发现。

本病多发生于40岁以上的中年人，由于胸椎骨和椎间盘的退行性变而使椎间盘变薄、椎间隙变窄，相应地出现脊柱韧带松弛，使其处于不稳定状态。因背部斜方肌、背阔肌、大小菱形肌均支配上肢的运动，胸椎上段受运动牵拉错位的机会较多，所以紊乱多见于第2~7胸椎小关节。

手法治疗

手法一：患者坐于矮方凳上，医者立于其后，在背部局部痛点区域揉、滚、按、弹拨数次。嘱患者10指互扣置于枕后部，头微屈，胸稍前倾，背部放松，医者一膝部紧抵于胸椎2~7旁压痛点最明显处，双手分别从患者腋下穿出，重迭环抱于相对称的前胸肋骨及胸骨边缘上，膝部与手同时缓慢用力向后上方提端牵引，再嘱患者深吸气至最大限度时，医者膝与手借巧向前后方面骤然一顶扳，即可听到“格答”声响。表示手法成功。

手法二：患者俯卧，术者站其侧，用右手掌在患处作滚、揉约3分钟，再以手掌置于疼痛部位向下按压，一手握住患侧肩部向上搬拉，两手密切配合，上下同时操作，可听到局部有“格答”声响，说明关节已复位。

75. 急性腰椎后关节紊乱症

急性腰椎后关节紊乱症，又称腰椎后关节错位，是骨伤科的常见病。

下腰部是人体躯干与下肢活动的枢纽，在日常生活、工作中，若腰部姿势不当 极易引起损伤。人体运动系统组织大多呈对称性，正常的双侧运动系统组织相互制约而处于平衡状态，一旦不同的外因作用使这种平衡失调，是产生病痛的原因之一。急性腰椎后关节紊乱症患者多有腰部不同程度的损伤史，下腰部酸痛，深压痛，下肢牵涉痛。患者多采屈身侧卧位，腰部活动受限（前屈后伸均受限，前屈受限明显）。腰背肌紧张，但无肿胀及压痛。腰肌有不同程度痉挛、僵硬感。拾物试验阳性。X线检查多能发现阳性体征。

急性腰椎后关节紊乱症，宜采取综合治疗。

中药治疗

方一：黄芪60克，桂枝15克，桃仁12克，茯苓15克，当归30克，丹参30克，大黄10克，赤芍30克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

方二：红花10克，桃仁10克，当归30克，熟地30克，川芎15克，赤芍30克，乳香10克，没药10克，乌药10克，杜仲15克，大黄10克，续断30克，寄生30克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

其他治疗

1. 理疗

TDP照射，每次40分钟。

2. 电针

取穴：阿是穴，阳关，腰眼，委中，承山，脾俞。电流刺激强度以能引起肌肉收缩，患者能耐受为度。

3. 磁疗

用双极磁镊针按压阿是穴 及腰眼、阳关、肝俞、脾俞穴，每次共操作40分钟。

4. 手法治疗

手法一：患者取坐位，屈肘贴胸，两手交叉搭于肩部。助手半蹲位，两膝紧夹患者双膝部，两手分别按住其双侧髂嵴，以固定患者骨盆。术者立于患者背后，一膝及大腿预贴其腰背部，一手其肩置前，另一手置其另侧肩后，将患者上半身向后倾斜45度左右，令其腰部肌肉尽量放松，此时术者一手扳压肩部向后，一手推挤另侧肩向前，两手同时用力。通过肩部被动的一前一后活动，从而带动腰部向左向右旋转，先小幅度来回活动数次，趁患者未加注意且腰部肌肉比较松弛时，术者两手骤然用力，将肩向左向右扳绞各一次（一般可使上半身左右转体60~70度），此时常可听及腰部“格答”声响，尔后在其腰椎棘上及棘旁自上而下施行按、摩、揉等手法数次，以理顺经筋，疏通气血。

手法二：患者俯卧，取垫腹屈背体位，双手前伸，尽量放松躯体。腹下置枕至适当高度，腰段成后凸状，使患者下肢能落空，以加强自重牵引力，维持体位5~10分钟。

76. 第三腰椎横突综合征

第三腰椎横突综合征是慢性腰痛中的常见病症，是椎管外软组织的疼痛性疾患。

临床表现：腰部疼痛，俯仰不利，下蹲及弯腰活动时疼痛加剧，咳嗽、打喷嚏时疼痛反射至臀部及大腿后侧（不过膝），形成假性坐骨神经痛。第三腰椎横突尖端部位压痛明显，重压有轻度向下放射痛，腰肌紧张，并可触及块状肿胀

物。直腿抬高试验阴性，加强试验阴性，挺腹试验（±）。患者均有习惯性腰部扭伤史和慢性劳损史，常与天气阴晴变化有关。

第三腰椎横突综合征属于祖国医学“劳伤腰痛”范畴。中医认为与气血经络功能失调有关。《素问》说：“久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋。”中医认为，腰者，一身之要，若有损伤则血脉凝滞，腰不能挺直，患处不能近。《圣济总录》说：“腰者一身之要，屈伸俯仰，无不由之，或风寒所客，或肾气损伤，使筋脉拘急，动摇转侧不得，故腰痛也。”

第三腰椎横突综合征的治疗，宜补肾壮筋，活血通络，散瘀消肿。

中药治疗

（一）内治法

方一：熟地30克，杜仲15克，当归30克，续断30克，山萸30克，淮牛膝20克，茯苓15克，五加皮15克，鸡血藤60克。水煎服，每日1剂，连服10～30剂。

方二：健身全鹿丸（成药），每次服10克，每日服3次，开水送服，连服1个月。

（二）外治法

方一：麝香虎骨膏外贴患处。

方二：川乌30克，附子30克，吴萸15克，麝香0.2克，共研细末，酒水各半调敷患处。

针灸治疗

方法：用2.5～3寸毫针在患侧横突压痛点，直刺一针，再距该针一寸、针尖朝中心点斜刺1针，均至横突停止进针，少提插，多捻转，留针30分钟，每日1次，7次为1疗程。伴有

臀上皮神经分布区压痛者在该痛点加针，其他反射性疼痛区不必处理。

中西药物混合注射治疗

方法：患者俯卧，前臂交叉置于前胸下面，腹部垫软枕，腰部肌肉放松。医者先用5毫升注射器（5号针头）抽“祖师麻注射液”2毫升，醋酸可的松25毫克，奴夫卡因0.5毫升，用左手大拇指按压住腰三横突尖端，将拇指末端与封闭区皮肤一同消毒。右手持针，与皮肤呈 60° 角斜向横突尖端刺入，触及骨质后缓慢注入药物，每周2次，5次为1疗程。可作1~3个疗程。

手法治疗

手法一：患者俯卧，医者用右手肘尖抵住第三腰椎横突尖端，左手握住治疗床对侧边缘，嘱患者放松全身，作深呼吸，术者随其呼吸慢慢加力，待患者呼气之末，向外方突加用力，当听到“卡嚓”一声后，术毕。

作完以上手法后，辅以轻揉、摩法等。

手法二：患者俯卧，医者站其侧，以双手拇指重叠按在第三腰椎横突处作与条索状硬块垂直方向的弹拨，速度以3~4次/秒为宜，用力由轻到重，再由重到轻。弹拨至硬块较柔软后，再以双拇指，在顺条索方向上顺理按压5~6遍，最后施以轻揉，至患者感到腰部有发热感为止。

77. 骶髂关节错位

骶髂关节错位不仅见于小儿，也见于成人，是骨伤科的

常见病。但由于未受到应有的注意，故常被误诊而影响及时治疗。

急性病例常表现为骤然起病，一侧下腰部疼痛，患侧下肢麻木或胀痛乏力，沿坐骨神经通路具有放射痛或“触电”感。患者呈臀部歪向病侧、腰部往健侧斜、身体朝病侧前倾的特殊姿势，不能直腰挺胸。翻身起坐时疼痛加剧。患肢呈半屈曲位，主动或被动伸屈均受限，并引起剧痛。咳嗽或打喷嚏时患侧下肢常有放射性痛。慢性病例上述症状较缓和，自觉下腰部隐痛，患侧下肢“短了一截”和酸软乏力。如勉强行走，则呈不同程度的歪臀倾身跛行。站立时多以健肢负重，坐时以健侧臀部触椅。仰卧伸直下肢时患肢可有牵扯痛或麻胀感，故患者喜屈曲患肢仰卧或向健侧侧卧。临床上常误诊为“坐骨神经痛”。有的患者表现为骶部麻胀并向尾骨及肛门放射。个别病例仅尾骨疼痛、触痛，疼痛甚者，不能睡硬板床。

骨盆分离与挤压试验、骶髂关节旋转试验、“千”字试验、患肢直腿抬高试验、床边试验等，急性病例呈阳性，慢性患者可呈阴性。

骶髂关节错位的治疗，宜以手法治疗为主

手法（均以右侧为例）

1. 屈髋屈膝冲击法：适用于骶髂关节前错位的治疗。患者仰卧，两手置于枕部，术者站立于患者右侧，医者右腋下夹住患者右足踝部，以右前臂托住小腿后侧，右手掌心朝下，虎口顶住腘窝，左手掌按膝关节的前侧。以强力过屈髋膝关节，可连续冲击2~5次（患侧下肢稍外展，以免引起季肋部挫伤）

2. 侧卧斜扳伸髋法：适用于骶髂关节后错位的复位。患

者侧卧，病侧在上，术者立于患者右侧，左足跟顶于患者髂后上棘，用力向前蹬顶；右手持握患者右踝上部，向后强力牵拉患肢过伸；左手掌按压患者右肩前侧，使患者躯体旋转贴向床面。整复时术者左手、右手、左脚同时瞬间用力“蹬、拉、按旋”，可连续2~3次，此时可在腰骶部听到弹响。

78. 股骨头无菌性坏死

股骨头无菌性坏死多由于股骨骨折或其他损伤，股骨头的血液循环发生障碍而引起。临床表现为髋关节疼痛，并有压痛，活动受限，肌肉萎缩。X线检查可确诊。

1. 急性期：患髋疼痛，肌痉挛，髋关节活动受限。

2. 坏死期：患者髋部疼痛与肌痉挛加剧，肢体屈曲、内收，有轻度短缩，关节疼痛。

3. 恢复期：患者髋部疼痛、肌痉挛等症状缓解，但肢体有些内收、短缩，走路轻微跛行。

股骨头无菌性坏死属于祖国医学的“痹证”范畴。多因肾气不足，肾阳虚衰，瘀血痰湿闭阻经络关节所致。中医认为，肾为先天之本，主骨生髓。髓乃骨之海，髓旺骨必长。肾气不足则不能生髓长骨。骨髓化源不足，加之气血虚弱，使骨失其养而易造成骨坏死。其治疗，宜填精益髓，益气补血，活血通络。

内治法

方一：熟地30克，鹿角胶15克（烊服），续断30克，骨碎补15克，桂枝10克，淮牛膝30克，丹参30克，地骨皮15

克，知母12克，黄柏12克，山萸30克，当归30克，山药30克，丹皮12克，党参30克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

方二：黄芪60克，当归30克，蜈蚣2条，全蝎10克，五加皮30克，木瓜30克，赤芍30克，仙灵脾30克，淮牛膝20克，续断30克，丹参30克，山甲15克，骨碎补12克，海桐皮30克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

方三：地龙30克，桃仁12克，红花12克，黄芪60克，赤芍30克，当归30克，秦艽15克，香附10克，淮牛膝30克，川芎10克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂。

外治法

方一：麝香0.1克，威灵仙30克，红花30克，川芎30克，透骨草30克，泡酒（淹没药面）外擦患处。

方二：乳香30克，没药30克，沉香30克，血竭30克，白芷60克，羌活60克，栀子60克，骨碎补60克，三七粉30克，五加皮90克，自然铜90克，续断60克，山甲60克，共研细末，水酒各半，调成糊状，外敷患处，每日1次，每次敷6小时。

方三：伸筋草30克，桑寄生30克，威灵仙30克，苏木30克，桃仁30克，红花30克，桑枝30克，当归30克，川芎30克。煎水熏洗患处，每日洗2次，每次洗30分钟。

79. 血 胸

血胸系胸部创伤、肋骨骨折的常见并发症，因外伤

(包括交通事故、斗殴、锐器穿透胸壁、摔跌伤等)而大量血液流入胸腔,导致胸膜腔内积血,合并气胸者称为血气胸。

小量的胸膜腔内积血,常无自觉症状,而只在X线检查时被发现。严重血胸可导致休克。

血胸的症状:呼吸困难,胸痛胸闷,咳嗽时胸痛更剧,胸部不能随意转侧,气短不能平卧。血胸可通过X线检查确诊。

血胸须及时抢救。在瘀血消散较慢的情况下可用中药治疗,使胸腔积血及早消散吸收,避免粘连。

血胸属于祖国医学的“悬饮”、“胸部内伤”范畴。中医认为系外伤后瘀血停留胸腔,气机受阻。“肺为贮痰之器”,胸肺受损,瘀血内阻,痰因瘀生,痰瘀互结,郁而化热,气机升降不利,若瘀血积久不消则变为“干血”粘连,形成“凝固血胸”、“纤维胸”。治宜行气活血,化瘀散结,清热利水。

内治法

方一:葶苈子15克,大枣15克,丹参30克,黄芩30克,香附30克,旋覆花10克。水煎服,每日1剂,连服30~60剂。

方二:水蛭10克,桃仁10克,杏仁10克,桑白皮30克,浙贝15克,地榆15克,冬瓜子30克,茅根30克,银花15克,生大黄15克(后下),三七粉6克(冲服),葶苈子15克。水煎服,每日1剂,连服30~60剂。

方三:当归30克,生大黄15克,生地30克,赤芍30克,川芎10克,桃仁10克,红花10克,苏木10克,连翘15克,黄芩15克,栀子10克,三七粉6克(冲服),羌活10克,独活10克,枳壳10克,桔梗10克。水煎服,每日1剂,连服30~60剂。

外治法

方药：桃仁10克，红花10克，三棱10克，莪术10克，木通10克，川芎10克，当归15克，郁金15克，香附10克，木香10克，川牛膝15克，五灵脂10克，山甲15克，乳香10克，没药10克，泽兰10克，黄芪35克，续断30克，合欢皮10克，骨碎补10克，桂枝10克，生南星10克。煎汤，熏洗患处。然后用纱布浸药汁湿敷患处（胸背部）。

皮 肤 科

80. 剥脱性角质松解症

剥脱性角质松解症，又名层板状出汗不良，是一种表浅的掌跖部角质剥脱性皮肤病。

本病病因尚未肯定，有学者认为属真菌疹之一，但许多患者并无真菌感染灶。也有学者认为本病是先天性疾病，多汗症可能是发病因素。

临床表现：皮损初起为针头大白点，由表皮角层与下方松离形成，逐渐向四周扩大，类似疱液干涸的疱膜，容易自然破裂，或经撕剥成为薄纸样鳞屑，其下皮肤正常。皮损不断扩大，互相融合，再加撕扯鳞屑，致累及大片皮肤，通常仅累及掌跖，偶见于手足背侧，常对称分布。本病易在暖热季节复发，往往合并局部多汗。无炎症发生，有瘙痒感。

中医认为剥脱性角质松解症系脾虚血燥，皮肤失于濡养所致。治宜养血润燥。

方一：生地30克，熟地30克，制首乌30克，黄精30克，生牡蛎30克，当归15克，麦冬15克，石斛15克，赤芍15克，白蒺藜15克，白芷10克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂，并用第三次煎液浸洗患处。

加减：血热甚者加丹皮、紫草。阳明热重加生石膏、知母。瘙痒、手汗多加苦参、白藓皮、地肤子、黄柏。手心发热加地骨皮、丹皮。

方二：黄芪30克，党参30克，当归30克，黑芝麻15克，阿胶15克（烔服），核桃仁30克，制首乌30克，火麻仁10

克。水煎服，每日1剂，连服20~40剂，并用小磨麻油外搽患处。

81. 射线皮炎

射线皮炎又名放射性皮炎。是由于应用 β 射线、 γ 射线、或X射线放射而引起的一种皮肤炎症。病因为射线剂量过大、时间过长，或技术人员长期接触射线而防护设备不周所致。

（一）急性型：多见于用放射线治疗恶性肿瘤的病例。按症状轻重可分为三度：

I度：照射部位发生红斑，有轻度灼热感及瘙痒，也可见皮肤干燥，小片脱屑，遗留色素沉着，一般数天后消失。

II度：照射部位发生红斑、水肿、水疱、大疱、渗液、糜烂、结痂、伴有瘙痒、灼热、或疼痛感，继后可脱屑而愈。

III度：照射部位红肿热痛，形成较深的溃疡，表面组织坏死，伴有毛细血管扩张，色素脱失（皮肤变白）或沉着（皮肤变黑）。溃疡不易愈合。

（二）慢性型：由于多年小剂量长期反复应用放射线所致。皮损为暗红色肿胀，皮肤干燥变厚、萎缩，有毛细血管扩张及雀斑样改变，指甲变脆且生长缓慢，头发稀疏。个别病例由于射线皮炎长期不愈，可以变生癌变（恶变）。

放射皮炎的治疗，宜补养气血，扶正固本。

内治法

方药：十全大补丸（成药）每次服6克，每日服3次，开

水送服。或杞菊地黄丸（成药）每次服6克，每日服3次，开水送服。连服1~3个月。

外治法

方药：茶叶、艾叶、女贞子叶、皂角各15克。加水250毫升煎至100~150毫升，纱布过滤，取其煎液外洗或湿敷溃疡面，每日3次。

82. 播散性颜面粟粒性狼疮

播散性颜面粟粒性狼疮是一种发生在颜面的慢性皮肤病，多发生于成年人。过去被认为是结核疹之一，现研究表明与结核无关。

本病除多发生于颜面部外，亦可发生于耳轮、颈部、肩胛及四肢部。皮疹为圆形丘疹，如粟粒至豌豆大，迅速布满面部，常对称地分布在颊部及眼睑，在下眼睑处往往有数个丘疹融合成堤状，这是本病的特点之一。

丘疹很浅，呈半球形或略带扁平，色鲜红，有的呈半透明，也有的呈紫红色或黄褐色或红褐色。质坚韧，表面光滑。丘疹顶部可有黄色小脓点或鳞屑痂。丘疹多为散在分布，也可融合。患者感灼热不适。

本病病程缓慢，数月或数年后丘疹渐消退而留有萎缩性疤痕，成为点状凹陷下坑。

全身症状有潮热、盗汗、腰酸背痛。

中医认为本病多由肺肾不足，痰热蕴阻肌肤所致。肺主皮毛，肺虚则卫外不固，邪热侵袭，痰热交凝，蕴结肌肤，

发为本病。治宜养阴清热，化痰软坚。

方药：生地30克，玄参30克，麦冬30克，丹参30克，海藻30克，生牡蛎30克，夜交藤30克，鱼腥草30克，夏枯草30克，百部12克，皂角刺12克，地骨皮30克，青蒿30克（后下）。水煎服。本方也可作外治冲洗患处。

皮疹消退后，尚须服用本方1~2个月，巩固疗效。但需在方中加用肉苁蓉15克，续断15克，锁阳10克。取阴阳双补之义。中医认为，善补阴者，必于阳中求阴，阴得阳升，则泉源不竭。

83. 眼睑黄疣

眼睑黄疣是一种脂质代谢障碍性皮肤病，患者多有血脂增高史。眼睑部黄色斑块如疣，因而称之为眼睑黄疣，多见于中年以上的妇女或男性。

临床表现：黄疣主要发生于两眼睑特别是上眼睑内侧，一般对称。皮损为黄豆大小的柠檬黄色或橘黄色的柔软斑块（斑丘疹），呈圆形、椭圆形或不规则形，部分蔓延成马蹄状，边缘鲜明，表面平滑，病情发展缓慢，可长期存在，不会自行消失。患者无主观感觉。

眼睑黄疣被认为是血脂增高的标志，而血脂增高则是冠心病的危险因素，故眼睑黄疣患者应积极治疗血脂增高。

中医认为眼睑黄疣系肝胆湿热上蒸。阻于肌肤所致。治宜活血疏肝。

方一：泽泻60克，山楂30克，丹参30克，虎杖30克，制

首乌30克，三七粉6克（冲服），枸杞15克。水煎服，每日或隔日1剂，连服3个月。

方二：复方丹参片（成药），每次服3片，每日服3次。连服3个月。

方三：龙胆泻肝片（成药），每次服3片，每日服3次。连服3个月。

方四：水牛角粉12克。加水煎2小时后分2次连渣服，连服3个月。服后有轻泻、腹胀等反应，不需处理。本方不仅能降血脂，还能治疗单纯性肥胖，减轻体重，适用于肥胖型高血脂患者。

84. 中毒性红斑

中毒性红斑为多种原因引起的全身性弥漫性红斑，常见于儿童和青年。

中毒性红斑常由食物过敏引起（鱼、虾、蟹、可可、草莓等），或由药物过敏引起（磺胺、巴比妥、颠茄、血清制剂），但大多数由内脏疾患引起，如扁桃体炎、咽炎、上呼吸道感染、毛囊炎、疖、风湿热、单核细胞增多症、疟疾、肺炎、肠伤寒、脑脊髓膜炎等均可引起中毒性红斑。

本病由于人体出现感染病灶时，病原体及其代谢产物引起抗体的超敏反应。在微生物生长繁殖过程中，产生多种有害物质，如胶原纤维酶、溶蛋白酶、透明质酸酶、致红斑毒素、多种表面抗原以及组织坏死崩解产物使机体致敏。

临床表现

初起为孤立性小红斑，迅速扩展，融合成片，颜色由鲜红色转为暗红色。皮疹分布于躯干，四肢、重症者波及全身，粘膜亦可累及。有猩红热样红斑、麻疹样红斑、荨麻疹样红斑。患处自觉瘙痒、灼热。全身症状有：发热、乏力、头晕、烦躁、口渴多饮、小便短赤。

本病发热、皮疹、瘙痒同步发生，而且皮疹广泛对称单一。白细胞总数增高及中性粒细胞增高也是诊断依据。

中毒性红斑，属于祖国医学“温疫发斑”、“时疫发斑”范畴。多由邪留血分，伏邪不得外透所致。治宜清热解毒。

方一 银花30克，连翘30克，牛蒡子15克，麦冬15克，山豆根15克，升麻10克，大青叶30克，射干12克，生地30克，玄参20克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服10～30剂。

方中银花、连翘清热解毒，牛蒡子疏风透疹消肿，麦冬清心润肺生津，山豆根清热解毒，消肿止痛，升麻解毒透疹，大青叶清热解毒凉血，射干泻火解毒散瘀，生地、玄参凉血养阴，甘草调和诸药。全方具有清热解毒，凉血透疹之功，治疗中毒性红斑，有较好疗效。

方二：黄连10克，黄芩30克，黄柏10克，栀子12克，赤芍30克，水牛角屑30克，生地30克，丹皮15克。水煎服，每日1剂，连服10～30剂。

方中黄连、黄柏、栀子、黄芩合用能泻火解毒，有较强的抗菌作用。赤芍、丹皮清热凉血，活血祛瘀，生地凉血滋阴，水牛角屑清热凉血解毒。全方合用，有清热解毒，凉血化瘀之功。

治疗中毒性红斑，应及时去除病因，如系食物过敏引起

者，应停吃有关食物。由药物过敏引起者，应立即停药。由原发病引起者，应积极治疗原发疾病。

85. 关节型银屑病

关节型银屑病又称银屑病性关节炎，系指在银屑病发生之后，发生类风湿性关节炎的症状，关节炎症状与皮肤症状同时加重或减轻。除银屑病皮损外（银屑病皮损为点滴状红色斑丘疹，以后扩大成各种形态如松树皮或如铜钱，或如地图，表面覆盖银白色鳞屑，刮去鳞屑可出血）关节炎多发生在手、腕、足等小关节，尤以手指足趾末节受累为甚。关节红肿疼痛，屈伸不利，甚者骨质破坏。

皮损呈急性进行状态，呈蛎壳状，病程长久。

关节型银屑病属祖国医学的“痹证”范畴。多因外受湿热之邪，或内有湿邪，内不得疏泄，外不得透达，湿与热搏于肌肤关节之处，郁久化热，以致血热，血燥。或因肝肾亏损，营血不和，脏腑阴阳失调而成本病。治宜祛风通络，清热利湿。

辨证分型治疗

（一）湿热毒盛型：全身有银白色鳞屑，基底鲜红，刮之易出血。小关节红肿疼痛，屈伸不利。舌红苔黄腻，脉滑数。治宜清热除湿，解毒通络。

方药：苡仁60克，丝瓜络30克，秦艽15克，黄柏15克，川牛膝30克，苍术30克，防己15克，六一散10克，王不留行15克，络石藤30克，海风藤30克，红藤30克，白藓皮30克，青

蒿30克（后下）。水煎服，每日或隔日1剂，连服60～90剂。

（二）肝肾阴虚型：皮损色淡，经久不愈，腰膝酸软，周身疲乏，小关节疼痛变形，屈伸不利，骨质受损，舌淡苔薄脉细。治宜调补肝肾，祛湿通络。

方药：狗骨90克，猫骨90克，淮牛膝90克，山萸60克，苡仁60克，续断90克，龟板90克，寄生90克，熟地90克，黄精60克，共研细末，制成蜜丸，每丸重10克，早晚各服1丸。用枸杞30克煎汤送服（枸杞子亦可同时服下）。连服3～6个月。

专方治疗

1. 火把花根片（雷公藤制剂）或昆明山海棠片，每次服2片，日服3次，饭后服。病重者每次可增至4片（逐渐加量）。连服3～6个月。

卫矛科植物雷公藤及其同属植物昆明山海棠，具有祛风利湿、舒筋活络、清热解毒以及抗炎、抗真菌、抗肿瘤等作用，还具有调节机体免疫的功能。

雷公藤治疗类风湿关节炎疗效较好，能改善疼痛、红肿和软组织肿胀，主要是其抗炎、解毒、镇痛作用显著。因而治疗关节型银屑病也有效。

雷公藤及昆明山海棠还具有激素样作用，而无激素样副作用，可与激素合并用药，或替代激素而达到治疗的目的。

但是，雷公藤有毒，如不经过加工处理，病人服用后可出现毒副作用。只要经过加工处理，其毒性可以消除。近代药理研究表明雷公藤的主要成分是雷公藤定碱等生物碱，此外还有南蛇藤醇、卫矛醇、雷公藤甲素等，它的毒性成分可以由醚浸出，经过还原作用，毒性可完全消失。经科学工作者的努力，雷公藤制剂已成为安全无毒、临床疗效较好的良

药，患者可放心服用。但不要服用没有经过加工的雷公藤，以免中毒。

2. 大活络丸（成药），每次服1丸，每日服2次。连服2~3个月。

3. 土鳖虫50克，蜈蚣8条，乌梢蛇100克，五步蛇100克，全蝎50克，僵蚕50克，干地龙50克，共研细末，每次服6克，每日服3次，用青蒿30克（后下），党参30克，三棱10克，莪术10克，秦艽15克，续断30克煎汤送服。连服3~6个月。

86. 脓疱型银屑病

脓疱型银屑病是银屑病中治疗难度较大的一种类型。病因尚未阐明。临床表现为全身有炎症性红斑和针尖、米粒大小的密集或成群的小脓疱，四肢尤甚，红肿溃烂，脓液培养无细菌生长，但长期流脓，脓点此起彼伏，严重者手指可萎缩。病人常有寒颤、发烧、皮肤灼热感或伴关节酸痛。病情反复发作，缠绵难愈，最终常因内脏损害、衰竭或感染而死亡。

脓疱型银屑病属于祖国医学的“毒疮”等范畴。中医认为系湿热之毒搏结于肌肤所致。治宜清热，解毒，祛湿。

辨证分型治疗

（一）湿热瘀结型：低热，关节微痛，酸软乏力，四肢沉重，头重胸闷，全身有针尖大小的脓疱，脓液渗出（脓液无细菌生长）后结痂，呈白色鳞屑。口干不思饮，舌红苔黄

臌 脉滑数。治宜清热祛湿，活血化瘀。

方药：土茯苓30克，茵陈30克，苡仁30克，银花30克，黄芩20克，山栀10克，茯苓皮30克，生地30克，元参30克，苦参30克，白藓皮30克，三棱10克，莪术10克，赤芍30克，丹皮15克。水煎服，每日或隔日1剂，连服3~6个月。

（二）热毒壅盛型：高烧，关节疼痛，全身呈脓疱斑疹，红肿溃烂，渗液（脓液），结痂后形成白色鳞屑，烦渴，舌红，苔黄厚，脉弦数。治宜清热凉血，解毒祛湿。

方药：羚羊角粉1克（冲服），赤芍30克，生地60克，丹皮15克，板蓝根30克，生石膏30克，知母12克，黄芩15克，黄连10克，栀子10克，连翘15克，竹叶12克，水牛角屑30克。水煎服。每日或隔日1剂，连服3~6个月。

专方治疗

方一：炙麻黄10~15克，桂枝10克，苍术15克，白芍30克，土茯苓30克，蛇床子30克，红藤30克，鸡血藤60克，当归30克，川芎15克，玄参20克，露蜂房18克，紫草30克，槐花15克。水煎服，每日或隔日1剂，连服3~6个月。

方二：火把花根片（雷公藤制剂）或昆明山海棠片（成药），每次服2~4片，日3次，饭后服，连服3~6个月。

眼 科

87. 交感性眼炎

交感性眼炎是眼科比较严重的疾病。患眼因穿透伤发生色素层炎后的2~8周(潜伏期)内,在另一未受伤的眼亦发生色素层炎,称交感性眼炎。临床上称受伤眼为“诱发眼”,未受伤眼为“交感眼”。

交感性眼炎主要发生在眼球穿透伤之后,但眼内手术(白内障、青光眼手术)、角膜溃疡、眼球的恶性肿瘤也可引起交感性眼炎。临床上并非所有的眼球穿透伤都引起交感性眼炎,只有在下列情况下容易发生交感性眼炎:①眼球穿透伤的伤口在睫状体区。②穿孔伤的处理不当。③受伤眼的虹膜睫状体炎持续不退或消退后又有反复发作。④眼球内有异物存留。

一般受伤半年内发病较多,距受伤时间越长,发病可能性越少。

交感性眼炎病势急,病情重,病程长。症状有视力下降,视物模糊、跳动伴头痛。临床上可分两种类型:一种是眼球前部炎症明显,主要表现为虹膜睫状体炎,病变由前向后波及到脉络膜,产生色素层炎。另一种类型是炎症最先把由眼球后部开始。眼底检查时,视乳头边缘模糊水肿,视网膜有渗出物,甚至发生浅度网膜脱离,病变由后向前发展,波及虹膜睫状体,最终成色素层炎。

中医认为,肝开窍于目,眼部炎症,主要责之于肝火上炎。此类患者多数还伴有阳明腑实症状。治宜清肝泻火,清

热解毒。

方一：龙胆草12克，木通10克，泽泻30克，柴胡10克，车前草30克，生地30克，当归30克，栀子10克，黄芩30克，丹皮10克，赤芍30克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

方二：生石膏90克，知母15克，银花30克，连翘30克，甘草10克，枸杞15克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

88. 电光性眼炎

电光性眼炎是由紫外线过度照射引起的眼外伤。电焊工、水银灯下从事拍摄的电影工作者、从事紫外线操作的医务人员，如果在工作中不注意保护眼睛，不戴防护镜或防护罩，一般易得此病。

临床表现：照射当时无不适感，经一段潜伏期才开始出现症状。初起，眼内有异物感或砂粒样摩擦感，随即剧烈疼痛、流泪、怕光、视物模糊、头痛，严重者双眼睑痉挛不能入睡。

检查可见眼睑水肿，球结膜充血，分泌物增多，角膜可有点状混浊，瞳孔缩小，对光反应迟钝。

单方验方治疗

新鲜人乳10毫升，点眼，每2小时1次，每次3滴。采集新鲜人乳时应十分注意清洁卫生，乳头须用肥皂水洗净，再用冷开水冲洗，直接将乳汁挤入洁净的眼药瓶内，备用。

针刺治疗

取穴：睛明、攒竹、阳白、承泣。

得气后留针30分钟，进针时宜轻轻提插，刺激不宜强烈。

89. 视神经乳头水肿

视神经乳头水肿是颅内压增高的一种临床症状，是一种机械性压迫现象。

当颅内压力增高时，视神经鞘间隙的压力也随着增加，造成视网膜静脉及淋巴间隙被压的网膜中央静脉扩张，乳头处壅滞，以致发生视神经乳头水肿。

视神经乳头水肿的形成，可发自眼球、眼眶、颅内以及全身疾病等方面，其中以颅内因素最为重要。脑瘤为最常见的病因，患脑瘤者80%有视神经乳头水肿；脑脓肿、脑膜炎、脑出血、颅骨骨折或颅骨发育异常，都可导致视神经乳头水肿；全身性疾病如恶性高血压、肾炎或妊娠中毒症的晚期，亦可发生视神经乳头水肿；眼眶内肿瘤和炎症，眼球穿孔伤，青光眼手术后，都可引起视神经乳头水肿。

临床表现

视力减退，头痛头晕，恶心呕吐，有时可出现眼肌麻痹和视野特殊改变。外眼正常，双眼视盘边界模糊，充血水肿，隆起4个屈光度，生理凹陷消失，血管迂曲爬行其上。乳头处或附近网膜面上有出血和白色病灶。

中医认为视神经乳头水肿系气滞血瘀，脉络瘀阻所致。治宜解郁通络，养阴明目。

方药：柴胡10克，白术15克，茯苓30克，当归20克，枸杞15克，五味子10克，蝉蜕10克，木贼10克，磁石50克，茺蔚子10克，生地30克，天麻10克，鸡血藤60克。水煎服，

每日1剂，连服10~20剂。

注：当视神经乳头水肿消退后，当服六味地黄丸（成药）善后，以巩固疗效。

90. 闪辉性暗点症

闪辉性暗点症又称暂时性不全黑蒙、眼性偏头痛，是一种功能性视觉障碍，由脑和眼底动脉一过性痉挛致功能障碍而出现的症候群，多见于青壮年女性，并有家族史。

本病病因尚不十分清楚，但与血管运动中枢功能失调有关。首先是颈内动脉分支的痉挛，继之为颈外动脉分支的扩张，搏动增强，因而产生头痛。一般月经来潮、精神疲劳、情绪波动或屈光不正时可诱发此病。

临床表现：发作时，突然双眼同侧视野中出现暗点，视力模糊。而在模糊的视野中有如电灯钨丝状的黄色或红绿色的闪辉性弧形光带。这种闪辉性眩目的光带开始甚少，逐渐扩大，扩大到一定范围又逐渐缩小，直到消失。且弧形光带有一缺口。双眼具有一致性，但很少双眼同时出现。此种闪辉性的弧形暗点从不越过视野的中间分界线。每次发作时间约持续几分钟到半小时。闪辉性暗点消失后，可在对侧发生剧烈的头痛，疼痛多在颞部额部，亦可波及到全头部及颈部。可伴有恶心、呕吐，眼部畏光，结膜充血。在闪辉样暗点发作时，眼底可见有视网膜中心动脉痉挛现象。头痛开始时，痉挛现象消失，头痛可持续半小时至1周不等。一般不超过12小时，但可反复发作。

闪辉性暗点症属于祖国医学的“头风”范畴。中医认为

系由于气血不利，脉络失和，经脉壅滞不通，不通则痛。治宜活血化瘀。

方药：赤芍30克，红花15克，川芎30克，桃仁20克，葱白3枚，生姜12克，大枣15克，麝香0.15克（冲服）。水煎服，每日1剂，连服20～40剂。

91. 浅层点状角膜炎

浅层点状角膜炎是病毒性角膜炎的一种。病因尚未阐明，各种年龄均可发生。常见双眼同时患病，主要症状表现为畏光及眼部轻度异物感。结膜的反应很轻微。病程缓慢，常可自愈而无后患。

本病须通过裂隙灯检查确诊。荧光素染色后，可见角膜浅层有散在的大小不等、数目不一的荧光素着色点。

此类角膜炎只涉及角膜上皮层，荧光素染色为浅层点状阳性，轻者为散在少量数点，重者为点状密集团聚，但始终不会互相融合成片，犹如秤星之聚，故中医称之为“聚星障”。

中药治疗

（一）初期

1. 外感风寒。恶寒无汗，鼻塞流涕，舌苔薄白，脉浮紧。治宜辛温解表。

方药：荆芥10克，防风10克，羌活10克，独活10克，柴胡10克，前胡10克，枳壳10克，桔梗10克，夏枯草30克。水煎服，每日1剂，连服7～15剂。

2. 外感风热。无恶寒，咽痛，口渴，眼涩痛畏光流泪，充血。舌红苔薄黄，脉浮数。治宜辛凉解表。

方药：银花30克，连翘30克，夏枯草30克，牛蒡子12克，竹叶12克，荆芥10克，薄荷10克，桔梗10克，芦根30克，玄参30克，天花粉10克，菊花20克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂。

（二）进行期

畏光流泪，患眼红赤，角膜萤光素染色可见点状较多，甚者密集。舌红苔黄脉细数。治宜疏风清热明目。

方药：草决明30克，山栀15克，连翘15克，夏枯草30克，谷精珠10克，防风10克，白蒺藜15克，蔓荆子10克，蝉蜕6克，茺蔚子10克，赤芍30克，丹皮12克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂。

（三）反复发作期（慢性阶段）

炎症时轻时重，时发时止，患眼畏光，干涩少泪，结膜微红。舌红苔黄脉细数。治宜泻肺养阴。

方药：生地30克，桑白皮30克，地骨皮30克，天花粉15克，谷精珠15克，黄芩30克，蝉蜕6克，白蒺藜10克，葶苈子10克，赤芍30克，夏枯草30克。水煎服，每日1剂，连服10~30剂。

外治法

方药：桑叶60克，野菊花30克，银花60克。分别将上药洗净，加蒸馏水1000毫升煎15分钟，过滤，取滤液350毫升，煮10分钟，备存。第二次加蒸馏水500毫升，煎10分钟，取滤液400毫升，与第一次滤液350毫升合并，放冷后洗眼。

92. 一般性角膜溃疡

一般性角膜溃疡是较为常见的眼病。角膜位于眼球前部表面,直接与外界接触,容易得病,一旦得病之后,透明的角膜就会变得混浊,引起视力下降。由于它有较丰富的三叉神经网,感觉非常灵敏,得病之后也就特别疼痛、羞明、流泪、眼涩不适等。

角膜溃疡系指角膜表面生翳、溃烂、坏死、组织脱落所致局部组织缺损。其特点是发病急,变化快,常发生合并症,以致失明。

一般性角膜溃疡多见于成年或老年人、身体虚弱、抵抗力差者;或有严重的沙眼及沙眼并发症如倒睫、睑内翻及外伤(如铁屑、沙石、谷壳、板栗刺等)致角膜上皮损伤,后被细菌、病毒感染而引起角膜局部浸润、组织坏死、脱落而形成溃疡。此外,慢性泪囊炎、结膜炎、眼不闭合(兔眼)常是引起本病的诱因。

临床表现

头痛,眼痛,眼睑痉挛,畏光,流泪,视力减退。检查可见角膜上有明显的点状或片状的灰白色或灰黄色局限性浸润。角膜病变处的上皮略显隆起。化脓后角膜浅层组织坏死脱落。

一般性角膜溃疡属于祖国医学的“凝脂翳”、“花翳白陷”等范畴。中医认为系风热上蒸所致。肝肺有热,风邪外侵,风热毒邪相搏,上乘目窍,则为“花翳白陷”;热毒深

入，风热壅盛，肝胃实火上攻，而成“凝脂翳”；若肝胆实热，郁而化火，上灼风轮，神水混浊，则为“黄液上冲”。

一般性角膜溃疡的治疗，宜疏风，清热，解毒。

辨证分型治疗

（一）风热壅盛型：角膜四周骤起白翳，中间凹陷，如覆薄脂，结膜红赤，羞明，流泪，头痛，眼痛，舌红苔黄脉浮数。治宜疏风清热。

方药：黄芩30克，黄连10克，连翘30克，栀子12克，菊花30克，赤芍30克，防风10克，大黄10克，木贼草15克，羌活10克，龙胆草15克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂。

（二）里热炽盛型：角膜上覆大片凝脂，窟陷深大，黄液上冲，结膜红赤，眼屎多，流热泪，头目剧痛，尿黄，大便秘结。舌红苔黄脉数。治宜清热通腑解毒。

方药：龙胆草15克，大黄15克，芒硝10克（冲），当归20克，防风10克，生地30克，菊花30克，赤芍30克，川芎10克，蝉蜕10克，银花30克，蒲公英30克，紫花地丁30克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂。

（三）正虚邪恋型：角膜凝脂渐见减薄，但久不吸收，仍目赤羞明。舌淡苔白脉细弱，治宜扶正祛邪。

方药：党参30克，黄芪30克，银花30克，连翘30克，升麻10克，柴胡10克，玄参20克，麦冬20克，生地30克，石决明30克，当归30克，赤芍30克，水煎服，每日1剂，连服10~30剂。

专方治疗

方一：桑叶30克，菊花30克，赤芍30克，黄芩30克，丹皮12克，天花粉15克，泽泻30克，车前子15克，玄参30克，银花30克，连翘30克，蒲公英30克，薄荷10克。水煎服，每

日1剂，连服10~30剂。

加减：结膜充血显著者加龙胆草、栀子。胸闷胁痛加青皮、香附。头痛且胀加石决明、珍珠母。便秘加生大黄。

方二：青箱子12克，茺蔚子12克，车前子10克，龙胆草15克，木通10克，柴胡15克，生地30克，当归30克，黄芩15克，栀子10克。水煎服，每日1剂，连服10~30剂。

方三：生石膏30克，芒硝10克（冲），大黄10克，天花粉15克，龙胆草15克，赤芍30克，丹皮15克，栀子15克，黄芩30克，水煎服，每日1剂，连服10~30剂。

外治法

方一：夏枯草30克，木贼草30克，虎杖30克，马鞭草30克，煎汁放冷后洗眼。

方二：苦参30克，黄连20克，荆芥15克，防风15克，五倍子15克，煎汁放冷后洗眼。

方三：鲜鸡蛋衣敷盖溃疡面（注意做到无菌操作），每日换药1次。

93. 霉菌性角膜溃疡

霉菌性角膜溃疡又称角膜霉菌病，由霉菌侵入角膜组织所致。常用的抗生素治疗无效，如果用激素治疗则病情发展更加迅速。在农村，因角膜外伤引起的霉菌感染的机会较多。对人眼有致病作用的霉菌，主要有白色念珠菌、镰刀菌、第状菌、青霉菌、孢子丝菌、放线菌属等。

临床表现：头痛，眼痛，畏光，流泪，视力减退。本病

主要发生于农忙季节眼外伤后，溃疡边界较清楚，有时有伪足样浸润。涂片培养证实有霉菌存在即可确诊。滴用抗生素眼药作治疗试验，如无效时亦可考虑为霉菌性角膜溃疡。

中医认为霉菌性角膜溃疡系风热毒邪侵袭，湿热上熏所致。治宜祛风，清热，解毒。

分期治疗

（一）炎症期：羞明流泪，头痛眼痛，口干，结膜红赤，角膜混浊，生翳下陷，表面粗糙不平，多合并前房积脓。舌红苔黄脉弦数。治宜祛风解毒，内清外解。

方药：千里光30克，银花30克，黄芩30克，天花粉15克，桑白皮30克，荆芥10克，防风10克，知母15克，枳壳10克，生石膏30克，甘草6克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。另以千里光30克，苦参30克，银花30克，煎汁过滤放冷后洗眼（注意无菌操作）。

（二）恢复期：症状减轻，食欲增加，患眼红赤消退，角膜浸润吸收，新生血管侵入。舌淡红苔厚，脉弦数。治宜祛风退翳，清解余热。

方药：千里光30克，苦参30克，银花30克，蒲公英30克，天花粉15克，生地30克，知母15克，龙胆草12克，黄芩10克，黄连10克，菊花30克，木贼草15克，草决明30克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

专方治疗

方药：野菊花30克，赤芍30克，银花30克，白术15克，生大黄15克，生地30克。水煎服，每日1剂，连服10~30剂，并用大蒜眼药水滴眼。

94. 匍行性角膜溃疡

匍行性角膜溃疡又称前房积脓性角膜溃疡，为进行性化脓性角膜炎症。本病多发生于农村，农民发病率较高。大多由外伤引起，如稻谷弹伤角膜或植物枝叶擦伤角膜。本病如不积极治疗，则易引起溃疡穿孔，虹膜脱出，角膜葡萄肿而致失明，给患者带来终生痛苦。

临床表现：怕光，流泪，眼红赤，视力下降，眼剧痛，眼内有异物感，角膜染色为阳性，前房有积脓（角膜有人指甲根白岩样脓液）。

匍行性角膜溃疡属于祖国医学的“凝脂翳”、“花翳白陷”、“花翳低陷”等范畴。前房积脓者称“黄液上冲”。角膜溃疡发展严重引起角膜穿孔、虹膜脱出者称“蟹睛”、“螺旋翳”等。中医认为本病多由邪毒外侵，风热之邪上扰，经络闭塞，三焦关格，黑膏受火蒸作脓所致。治宜通腑泻火，解毒排脓。

辨证分型治疗

（一）风热型：为本病早期表现，除上述眼部症状外，舌红苔黄脉数。治宜祛风清热。

方药：荆芥10克，防风10克，桔梗10克，柴胡15克，羌活10克，木贼草15克，龙胆草15克，当归30克，黄连10克，连翘15克，黄芪30克。水煎服，每日1剂，连服10~30剂。

（二）肝胆火炽型：除眼部症状外，有头痛、失眠、口苦、舌红苔黄脉弦。治宜泻火解毒。

方药：龙胆草15克，柴胡30克，栀子10克，当归30克，

泽泻30克，大黄10克，黄芩15克，蒲公英30克，桑白皮30克，生地30克，银花30克，甘草10克。水煎服，每日1剂，连服10~30剂。

（三）阴虚火旺型：除眼部症状外，有头晕、面潮红、手足心热、舌绛无苔脉细数。治宜滋阴降火。

方药：知母15克，黄柏15克，生地30克，丹皮11克，茯苓30克，蔓荆子12克，当归30克，柴胡30克，银花30克，大黄6克。水煎服，每日1剂，连服10~30剂。

（四）热结腑实型：除眼部症状外，头痛如劈，口臭气粗，赤丝满目，烦渴引饮，大便秘结，小便短赤。舌红苔燥脉沉实。治宜通腑泄热。

方药：大黄10克，芒硝10克（冲服），枳实10克，厚朴10克，生石膏30克，知母12克，天花粉15克，竹叶12克。水煎服，每日1剂，连服10~30剂。

专方治疗

方一：生石膏30克，知母15克，甘草10克，栀子15克，黄芩30克，银花30克，蒲公英30克，大黄10克，芒硝10克（冲服），龙胆草15克，蝉蜕10克，白菊花30克，水煎服，每日1剂，连服10~30剂。

方二：羌蔚子12克，玄参30克，黄芪30克，生石膏30克，知母12克，麦冬20克，天冬20克，大黄10克，前仁10克，防风10克，龙胆草15克，赤芍30克，生地30克，三七粉6克（冲服），甘草6克。水煎服，每日1剂，连服10~30剂。

95. 玻璃体积血

玻璃体积血是眼科的常见病，多由眼外伤、视网膜静脉周围炎、视网膜静脉阻塞、糖尿病性视网膜病变、高血压动脉硬化性视网膜病变、内眼手术后视网膜裂孔等许多疾病引起。玻璃体周围的血管破裂出血，血液进入玻璃体内。发病较急，常因大量积血使光觉消失，视力急骤下降，局部充血肿痛、流泪、眼眶不适。

玻璃体积血属于祖国医学的“暴盲”、“血灌瞳仁”等范畴。其病因多系阴虚血热，肝经郁热，上扰空窍，迫血妄行，溢于脉外，或外伤等，瘀血积于眼内。治宜滋阴凉血，清肝解郁，活血化瘀（如何使玻璃体积血吸收消散，是治疗的关键）。

分期治疗

（一）出血期（包括病程较长反复出血的）：玻璃体内系新鲜积血，局部充血肿痛。流泪，眼眶不适。治宜凉血止血，清热消肿。

方药：生地30克，丹皮15克，当归30克，白芍30克，川芎10克，菊花30克，防风10克，仙鹤草30克，小蓟15克，黄芩炭10克，栀子炭10克，刘寄奴10克。水煎服，每日1剂，连服7～15剂。

（二）瘀血期：积血较为陈旧，无新出血现象。治宜活血化瘀，益气养血。

方药：桃仁10克，红花10克，当归30克，赤芍30克，川

芎10克，熟地30克，元胡15克，郁金15克，枳实10克，大黄10克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂。

(三)恢复期：积血大部分吸收，机化物已形成，玻璃体混浊，视力恢复不好。治宜滋阴补肾，益气活血，软坚散结。

方药：黄芪60克，当归30克，白芍20克，海藻30克，桂枝10克，桃仁10克，川芎10克，生地30克，玄参15克，制首乌15克，枸杞15克，茯苓30克。水煎服，每日1剂，连服10~20剂。

辨证分型治疗

(一)阴虚火旺型：玻璃体积血，视力下降，头晕耳鸣，失眠多梦，口干，手足心热，舌红无苔，脉细数。治宜凉血止血，滋阴降火。

方药：大黄10克，知母12克，黄柏12克，生地30克，茅根30克，旱莲草30克，女贞子30克，泽泻10克，山萸15克，侧柏叶15克，茜草12克。水煎服，每日1剂，连服10~30剂。

(二)外伤血瘀型：外伤引起，眼前现红光，眼珠剧痛，头晕眼胀，舌暗苔薄脉弦涩，治宜活血化瘀。

方药：三七粉6克(冲服)，桃仁10克，红花10克，当归30克，熟地30克，赤芍30克，川芎10克，蒲黄10克，防风10克，羌活10克。水煎服，每日1剂，连服10~30剂。

(三)血热型：视力下降，玻璃体积血，颜面红赤，口干，大便秘结，烦躁易怒。舌红苔黄，脉数。治宜清热凉血。

方药：生地30克，茅根30克，三七粉6克(冲服)，丹皮12克，栀子12克，女贞子30克，赤芍30克，大黄10克，旱莲草30克，柴胡30克。水煎服，每日1剂，连服10~30剂。

(四)水血互结型：玻璃体积血久不吸收，眼干涩，口

干，视力下降。舌暗有瘀点，脉细涩。治宜活血利水。

方药：猪苓30克，茯苓30克，茅根30克，三七粉6克（冲服），麦冬30克，车前子10克，丹皮15克，大黄10克，木通10克，赤芍30克，生蒲黄15克。水煎服，每日1剂，连服10～30剂。

专方治疗

方一：菊花30克，木贼草15克，蝉蜕10克，银柴胡15克，生地30克，赤芍30克，菟丝子15克，女贞子30克，夏枯草30克，白术15克，羌活10克，防风10克，甘草6克。水煎服，每日1剂，连服10～30剂。

加减：反复出血加三七粉6克、小蓟15克、便结加大黄，便溏加吴茱萸。

方二：女贞子30克，旱莲草30克，黄芪30克，枸杞15克，制首乌15克，桑椹30克，阿胶10克，栀子10克，黄芩30克，桃仁10克，红花10克，当归30克，赤芍30克，川芎10克，侧柏叶15克，三七粉6克（冲服），茜草15克，水煎服，每日1剂，连服10～30剂。

耳鼻喉科

96. 爆震性耳聋

爆震性耳聋系指受强烈的爆炸声的震动而导致的耳聋，是五官科的常见病症。现代医学认为各种类型的感觉神经性聋(包括爆震性耳聋)，其主要病理变化之一是内耳微循环障碍。

爆震性耳聋属于祖国医学的“耳聋”范畴。中医认为耳聋与肾、心、肝胆、脾有关，特别是与“肾”的关系密切，因为，中医认为“肾开窍于耳”。

爆震性耳聋的治疗，宜补益肝肾，活血化瘀。

中药治疗

方一：丹参30克，黄精30克，川芎15克，葛根60克，菖蒲50克，赤芍30克，红花15克，党参60克，磁石60克，甘草10克，水煎服，每日1剂，连服7~15剂。

方二：骨碎补60克，菖蒲50克，葛根60克，磁石90克，山药60克，远志10克，川芎15克，生军10克，益智仁15克，赤芍30克，枸杞30克，当归30克。水煎服，每日1剂，连服7~15剂。

针灸治疗

(一)体针：取穴耳门、听宫、听会、翳风、下关、百会、外关、悬钟。得气后留针30分钟，每5分钟捻转1次，每日针刺1次，7天为1疗程。

以上穴位，除耳门、听宫、听会为每次必须针刺外，其余穴位可任选2~3穴针刺。

(二)双极磁镊针：取穴耳门、听宫、听会，重力按

压，以患者能耐受为度，轮流按压3穴，每次操作30分钟，每日2次，7天为1疗程。

97. 耳廓软骨膜炎

耳廓软骨膜炎是五官科的常见病，多因外伤破坏皮肤屏障，细菌得以侵袭耳壳软骨引起化脓性感染。致病菌多为绿脓杆菌，抗生素治疗效果多不理想。

耳廓软骨膜炎的临床表现：耳廓紫红肿胀（耳廓正常标志消失，状如水饺），疼痛（多为灼痛）或刺痒，局部有渗液或脓液。检查时局部可有波动感，触痛明显。

耳廓软骨膜炎属于祖国医学的“耳发”、“耳发疮”范畴。中医认为多系肝胆湿热循经积滞耳壳，营卫不和，气血凝滞，湿热之邪搏结肌肤，腐而成脓。治宜清热解毒，排脓消肿。

内治法

方一：茯苓30克，陈皮10克，法夏10克，甘草10克，白芥子15克，银花60克，赤芍30克，丹皮15克。水煎服，每日1剂，直至痊愈为止。

方二：当归30克，黄芪60克，桔梗15克，蒲公英30克，紫花地丁30克，银花30克，连翘30克，野菊花20克，皂刺15克，王不留行10克，夏枯草30克，蚤休30克。水煎服，每日1剂，直至痊愈。

外治法

方药：白芷20克，赤芍30克，连翘30克，黄芩30克，黄

连20克，共入铁锅中，用麻油炸枯，去药渣，用消毒纱布浸蘸药液，外敷患处，并随时挤压，以利脓液排出。

98. 鼻粘膜糜烂

鼻粘膜糜烂是耳鼻喉科的常见病。长期接触过氯乙烯油漆、聚氨酯漆、丙烯酸漆、沥青漆、氨基漆及化学溶剂（含苯、甲苯、二甲苯、丁醇、汽油等）的喷漆造成对鼻粘膜的直接刺激和溶解、腐蚀作用，致使鼻粘膜糜烂。临床表现为鼻粘膜充血、水肿、糜烂，表面粘附分泌物。患者自觉症状有鼻分泌物增多，不闻香臭。

鼻粘膜糜烂的治疗宜以局部治疗为主。

方一：辛糜10克，白芷20克，苍耳子6克，细辛5克，鹅不食草30克，冰片0.5克，薄荷6克（后下），粉碎加水煎煮过滤，取药液1000毫升蒸馏，得600毫升澄清透明液体，收贮滴瓶备用。用以滴鼻，每次1~3滴，每天滴3次。连续用药7~9日。

方二：锡类散。用小镊挟持消毒湿棉片（生理盐水浸湿），蘸锡类散贴于患处。贴敷时病人屏气片刻。每日用药1次，连续用药7~9日。

方三：云南白药粉。用法同上。

方四：复方薄荷油，滴鼻，每日滴3~4次。

口 腔 科

99. 放射性口腔炎

放射性口腔炎，系头颈部、咽喉部恶性肿瘤患者接受放射治疗后出现的常见症状，是射线造成的口腔粘膜反应。主要表现为：粘膜充血水肿，溃烂，破溃出血，口干舌燥，吞咽困难，严重影响进食，伴声音嘶哑，颌下肌肉僵硬。这种症状有的长达1~2年才能消除。

中医认为，放射性口腔炎属热毒耗阴伤津之证。咽喉为肺胃之门户，脾经连舌本而散舌下，口腔被热毒之邪灼伤，肺脾胃必受其累。肺伤则阴虚，脾胃受损则湿阻。治宜滋阴生津，清热解毒。

方一：生地60克，北沙参30克，麦冬30克，玉竹15克，石斛15克，玄参15克，天冬15克，银花30克，连翘15克，茯苓15克，甘草10克。水煎服，每日或隔日1剂，连服60~90剂。

加减：咽喉肿痛溃烂加山豆根、板蓝根。声嘶加蓝布裙、射干。伴恶心呕吐加藿香、佩兰、竹茹。舌苔厚腻加苡仁、白蔻。咳痰血加仙鹤草、旱莲草。气虚乏力加黄芪、党参。

方中生地、北沙参、麦冬、玉竹、石斛、玄参、天冬滋阴生津，银花、连翘清热解毒，茯苓健脾和胃，甘草和中。诸药合用，使津液渐复，热毒得除。

此症较顽固，疗程长，患者应坚持服药，耐心接受治疗，切不可因为恢复较慢而丧失治疗信心。

方二：生地30克，麦冬30克，玄参30克。水煎服，每日或隔日1剂，连服60~90剂。

加减：口干咽燥夜间为甚者加银花、菊花、沙参、山药、白芍、天花粉、丹皮。鼻流脓涕，头痛、咽干、口臭、粘膜充血，大便秘结者加黄芩、黄连、黄柏。纳差，恶心呕吐者加苍术、苡仁、茯苓、藿香。口腔腥味、口腔粘膜白斑者加太子参、白术、山药、扁豆、茯苓、苡仁、黄芪、女贞子。

100. 牙本质过敏

牙本质过敏症是口腔科的常见病之一。临床表现为：牙齿受过冷、过热、酸、甜的刺激时感觉酸痛难忍，受到机械性刺激（如刷牙、咬硬物）也会感到酸痛，不能咀嚼。

牙本质过敏的病因多是由于牙齿的过度磨损、酸蚀、脱钙、楔状缺损引起的牙釉质缺损，牙本质小管暴露、从而对外界刺激敏感所致。

值得注意的是：患牙髓炎时也会出现上述症状，因此，患者应到口腔医院检查确诊。

针灸治疗

取穴：上颌牙取下关、颧髎穴，配合谷、曲池穴；下颌牙取下关、颊车、大迎穴，或加地仓穴，配合谷、曲池穴。每隔1~2日针1次，每次留针30分钟。

中药疗法

方药：生石膏、生牡蛎、白芷、五倍子、滑石各等份，

冰片少许。共研细末，过筛，装瓶备用。用时用牙刷沾药物少许，刷牙，有症状的牙重点刷，每日刷两次，14天为1疗程。

方中生石膏清热泄毒。生牡蛎收敛、止酸，白芷消肿止痛，有抗菌消炎作用，五倍子可抑菌收敛、凝固局部蛋白质，滑石可形成粘结物质，保护组织，防止外来刺激。冰片清凉止痛。诸药合用，具有消炎、收敛、止痛、抗过敏、等作用，还可使蛋白质凝固。药物在刷牙时可渗入牙本质小管，使牙本质小管闭塞，阻止外界刺激传导到牙髓以达到治疗的目的。

《百病良方》 1—8集总目录

内 科

呼吸系统疾病

感冒·····	六集 1 页
流行性感冒·····	五集 1 页
胃肠型感冒·····	八集 1 页
感染性发热·····	六集 6 页
流行性咽结膜热·····	六集18页
扁桃腺炎·····	一集增订本 1 页
扁桃体周围脓肿·····	七集 1 页
军团病·····	七集 2 页
急性支气管炎·····	二集增订本 1 页
慢性支气管炎·····	二集增订本 2 页
支气管扩张·····	一集增订本 10 页
支气管结石·····	六集19页
支气管哮喘·····	四集 21 页
哮喘持续状态·····	四集 25 页
咯血·····	六集20页
胸腔积液·····	七集 3 页
脓胸·····	七集 6 页
霉草尘肺·····	七集 9 页
蘑菇肺·····	七集11页
肺脓肿·····	一集增订本 3 页
肺结核·····	一集增订本 5 页

阻塞性肺气肿·····	二集增订本 8 页
肺含铁血黄素沉着症·····	六集24页
迁延性肺嗜酸粒细胞浸润症 ·····	六集26页
休克型肺炎·····	四集27页
金黄色葡萄球菌肺炎·····	四集 29 页
成人急性肺炎·····	四集 31 页
老年性肺炎·····	八集 3 页
放射性肺炎·····	八集 2 页
肺水肿·····	四集 34 页
成人呼吸窘迫综合征·····	四集 36 页
慢性呼吸衰竭·····	四集 40 页
肺部霉菌感染·····	四集42页
自发性气胸·····	三集96页
创伤性气胸·····	五集 3 页
结核性干性胸膜炎·····	四集48页
结核性渗出性胸膜炎·····	四集49页
肺性脑病·····	四集44页

消化系统疾病

反流性食管炎·····	四集51页
食管贲门失弛缓症·····	三集 6 页

(贲门痉挛)

幽门梗阻.....	六集27页
胃下垂.....	一集增订本31页
胃扭转.....	三集3页
胃柿石.....	二集增订本17页
胃痉挛.....	六集31页
胃粘膜脱垂症.....	五集5页
化疗胃肠毒副反应.....	七集14页
胃肠型荨麻疹.....	五集10页
胃术后功能性排空障碍	六集29页
多发性胃息肉症.....	六集30页
急性单纯性胃炎.....	六集33页
急性出血性糜烂性胃炎	六集35页
萎缩性胃炎.....	二集增订本14页
胆汁返流性胃炎.....	三集1页
幽门弯曲菌相关性胃炎	八集7页
慢性糜烂性胃炎.....	六集36页
浅表性胃炎.....	六集40页
胃窦胃炎.....	六集41页
残胃炎.....	七集12页
肠腺上皮化生.....	七集15页
顽固性呃逆.....	一集增订本23页
神经性呕吐.....	三集4页
消化道憩室病.....	二集增订本18页
溃疡病.....	一集增订本25页
胃酸过多.....	八集10页
上消化道出血.....	四集60页

倾倒综合征(餐后早发综合征)

.....	八集11页
甲型肝炎.....	一集增订本15页
慢性肝炎血清蛋白倒置	五集20页
乙型肝炎.....	四集57页
无症状HBSAg携带者	八集17页
重症肝炎.....	四集53页
淤胆型肝炎.....	七集18页
脂肪肝.....	六集52页
高胆红素血症.....	八集16页
肝炎后综合征.....	六集58页
肝脓疡.....	三集86页
肝硬化.....	二集增订本34页
肝脾肿大.....	八集19页
肝脾结肠曲综合征.....	六集60页
胆道蛔虫病.....	一集增订本43页
急性胆囊炎.....	二集增订本45页
慢性胆囊炎.....	二集增订本47页
胆石病.....	二集增订本40页
胆绞痛.....	七集20页
胆心综合征.....	五集22页
急性胰腺炎.....	三集10页
慢性胰腺炎.....	三集12页
急性阑尾炎.....	一集增订本22页
阑尾周围脓肿.....	六集66页
急性腹膜炎.....	四集71页
结核性腹膜炎.....	六集64页
腹泻.....	一集增订本36页

功能性腹泻……………三集13页
 便秘……………一集增订本41页
 老年性便秘……………四集65页
 短肠综合征……………八集13页
 结肠激惹综合征……………五集11页
 肠道菌群失调症……………六集49页
 十二指肠壅积症……………六集38页
 吸收不良综合征……………八集14页
 克隆氏病……………四集70页
 急性细菌性痢疾
 ………………一集增订本11页
 慢性细菌性痢疾
 ………………一集增订本14页
 中毒性菌痢……………四集77页
 慢性非特异性溃疡性结肠炎
 ………………二集增订本20页
 急性出血性坏死性肠炎
 ………………四集73页
 肠粘连……………三集17页
 肠痉挛……………六集81页
 慢性肠套叠……………六集47页
 肠结核……………五集13页
 麻痹性肠梗阻……………五集18页
 结肠息肉……………六集43页
 伤寒……………四集5页
 阿米巴肠病……………二集增订本22页
 伪膜性肠炎……………六集44页
 霉菌性肠炎……………三集15页
 滴虫性肠炎……………三集16页
 放射性直肠炎……………三集101页

梅毒性直肠炎……………五集19页
 钩虫病……………二集增订本24页
 蛔虫病……………二集增订本26页
 蛲虫病……………二集增订本28页
 绦虫病……………二集增订本29页
 姜片虫病……………二集增订本31页
 囊虫病……………二集增订本32页
 华支睾吸虫病……………四集14页
 丝虫病……………四集16页
 血吸虫病……………四集19页
 旋毛虫病……………五集14页
 结肠小袋纤毛虫病……………五集16页

循环系统疾病

过早搏动……………一集增订本45页
 慢性房室传导阻滞……………三集40页
 心房纤颤……………三集57页
 阵发性室上性心动过速
 ………………四集92页
 蛇毒性窦性心动过缓
 ………………五集27页
 心电图ST-T改变…五集28页
 B-受体兴奋症……………五集24页
 病态窦房结综合征……………三集49页
 病毒性心肌炎……………三集37页
 急性心包炎……………六集90页
 慢性心包炎……………六集93页
 心绞痛……………二集增订本48页
 不稳定型心绞痛……………八集5页

贫血性心绞痛综合征… 六集94页
 冠状动脉粥样硬化性心脏病
 …… 一集增订本55页
 冠状动脉痉挛心绞痛… 三集42页
 急性心肌梗塞… 三集44页
 颈源性胸痛… 七集29页
 急性肺源性心脏病… 六集85页
 慢性肺源性心脏病
 …… 二集增订本12页
 慢性风湿性心脏病… 六集96页
 慢性心力衰竭… 三集47页
 急性左心衰竭… 四集86页
 原发性心肌病… 六集99页
 心源性水肿… 六集89页
 心源性休克… 四集93页
 感染性休克… 四集95页
 失血性休克… 八集6页
 心脏神经官能症… 三集54页
 高血压病… 本订集增47页
 高血压危象… 五集29页
 低血压… 一集增订本52页
 直立性低血压… 六集103页
 高原性低血压型脉压差小症
 …… 六集104页
 无脉症… 三集52页
 结节性多动脉炎… 六集105页
 肢端动脉痉挛病
 …… 二集增订本81页
 闭塞性动脉硬化… 七集27页
 脑动脉硬化症… 五集30页

椎-基底动脉供血不足
 …… 六集108页
 克山病… 四集89页

泌尿生殖系统疾病

急性肾炎… 一集增订本58页
 隐匿性肾小球肾炎… 七集31页
 慢性肾炎… 一集增订本60页
 狼疮性肾炎… 八集26页
 急性肾功能衰竭… 四集99页
 高氮质血症… 六集79页
 慢性肾功能衰竭… 四集105页
 肾盂肾炎… 一集增订本70页
 肾盂积水… 七集33页
 肾病综合征… 三集19页
 紫癜性肾炎… 三集23页
 直立性蛋白尿… 四集98页
 肾结石… 一集增订本73页
 输尿管膀胱结石… 四集113页
 肾绞痛… 三集25页
 乳糜尿… 八集28页
 庆大霉素肾损害… 五集66页
 镇痛药肾病… 五集67页
 急性前列腺炎… 四集110页
 慢性前列腺炎… 二集增订本66页
 前列腺肥大… 二集增订本64页
 膀胱炎… 二集增订本63页
 放射性膀胱炎… 七集35页
 压力性尿失禁… 四集97页

紧张性排尿迟缓综合征

.....	六集78页
肾周围脓肿.....	六集81页
精囊炎(血精).....	三集32页
遗精.....	一集增订本77页
男性性功能障碍(阳痿、早泄)	一集增订本78页
射精不能症.....	三集27页
精液不液化症.....	三集29页
缺无精子症.....	三集30页
脓精症.....	七集36页
精子密度过高不育症...	七集37页
精索静脉曲张.....	六集71页
精子功能低下.....	六集73页
阴茎异常勃起症.....	六集74页
阴茎硬结症.....	六集76页

造血系统疾病

贫血.....	一集增订本116页
血铁性贫血.....	一集增订本119页
缺失性贫血.....	五集49页
再生障碍性贫血	一集增订本122页
α 地中海贫血.....	六集82页
β 地中海贫血.....	六集34页
老年性贫血.....	八集20页
反甲.....	八集23页
化疗所致造血功能障碍	八集24页

血小板减少性紫癜

.....	一集增订本125页
血栓性血小板减少性紫癜	五集54页
过敏性紫癜.....	二集增订本121页
腹型过敏性紫癜.....	五集26页
老年性紫癜.....	五集54页
血小板无力症.....	五集55页
血友病.....	五集56页
白细胞减少症...	二集增订本118页
高血粘综合征.....	七集25页
原发性血小板增多症...	三集36页
真性红细胞增多症.....	三集33页
传染性单核细胞增多症	四集13页
弥漫性血管内凝血.....	四集141页
行军性血红蛋白尿.....	五集51页
阵发性睡眠性血红蛋白尿	四集139页
遗传性出血性毛细血管扩张症	五集52页
低蛋白血症.....	八集25页

神经精神疾病

中枢性发热.....	七集38页
头痛.....	一集增订本87页
良性性交时头痛.....	八集43页
肌肉收缩性头痛.....	五集35页
血管性头痛.....	六集109页

外伤性头痛…………… 七集40页
 枕大神经痛…………… 七集44页
 枕小神经痛…………… 七集45页
 三叉神经痛…………… 四集118页
 颅内压增高症…………… 五集34页
 脑外伤后综合征
 ……………… 二集增订本99页
 小脑共济失调症
 ……………… 二集增订本89页
 脑积水…………… 二集增订本101页
 脊髓空洞症…………… 二集增订本103页
 多发性硬化症…………… 八集31页
 内耳眩晕症…………… 一集增订本90页
 椎管狭窄症…………… 八集39页
 癫痫…………… 一集增订本103页
 癫痫持续状态…………… 四集124页
 奔走性癫痫…………… 五集34页
 腹痛型癫痫…………… 七集50页
 脑溢血…………… 二集增订本90页
 蛛网膜下腔出血
 ……………… 二集增订本94页
 脑血栓形成…………… 二集增订本96页
 脑栓塞…………… 二集增订本97页
 短暂性脑缺血发作…………… 三集58页
 腔隙型脑梗塞…………… 六集121页
 肝豆状核变性…………… 六集 23页
 流行性乙型脑炎
 ……………… 二集增订本107页
 散发性脑炎…………… 四集127页

流行性脑脊髓膜炎…………… 四集 1 页
 化脓性脑膜炎…………… 五集32页
 多发性神经炎… 二集增订本105页
 末梢神经炎…………… 八集44页
 股外侧皮神经炎…………… 八集46页
 坐骨神经痛…………… 一集增订本107页
 桡神经麻痹…………… 八集48页
 臂丛神经痛…………… 五集37页
 颈椎病…………… 三集60页
 肋间神经痛…………… 三集71页
 小舞蹈病…………… 一集增订本110页
 重症肌无力…………… 一集增订本111页
 多汗症…………… 一集增订本113页
 面部单侧味觉神经性多汗症
 ……………… 八集39页
 闭汗症…………… 一集增订本116页
 植物神经功能紊乱…………… 三集66页
 腓总神经损伤…………… 五集39页
 腓肠肌痉挛…………… 三集69页
 不宁腿综合征…………… 三集72页
 竞技综合征…………… 四集126页
 面肌痉挛…………… 三集81页
 周围性面神经麻痹…………… 三集77页
 麻痹性斜视…………… 三集74页
 动眼神经麻痹…………… 七集57页
 震颤麻痹…………… 三集83页
 周期性麻痹（低血钾型）
 ……………… 三集84页
 失眠…………… 一集增订本97页

嗜睡……………一集增订本102页
 梦游症……………一集增订本109页
 记忆力减退……………一集增订本92页
 精神分裂症……………二集增订本110页
 周期性精神病……………三期70页
 一氧化碳中毒性精神病
 ………………六集126页
 强迫性神经症……………五集44页
 笑性强迫症……………七集52页
 焦虑性神经症……………八集40页
 躁狂抑郁症……………五集45页
 老年性痴呆……………四集122页
 癔症……………二集增订本86页
 外伤性癔病……………七集47页
 癔病性黑蒙症……………五集41页
 癔病性瘫痪……………五集41页
 癔病性失音……………六集128页
 癔病性晕厥……………七集48页
 咳嗽晕厥综合征……………八集35页
 排尿性晕厥……………六集134页
 神经性厌食……………六集129页
 神经性暖气……………六集132页
 癔球症……………六集133页
 进行性脊髓性肌萎缩症
 ………………四集130页
 肌萎缩性侧索硬化症
 ………………四集132页
 痉挛性斜颈……………六集120页
 汉特氏综合征……………七集53页

多发性风湿性肌痛症
 ………………七集54页

新陈代谢疾病

糖尿病……………一集增订本127页
 糖尿病酮症……………五集57页
 糖尿病周围神经病变
 ………………八集66页
 低血糖症……………四集134页
 单纯性肥胖症
 ………………二集增订本55页
 血脂过高症……………二集增订本52页
 痛风……………三集88页
 血卟啉病……………三集86页
 骨质疏松症……………五集59页

结缔组织疾病

类风湿性关节炎
 ………………二集增订本78页
 系统性红斑狼疮……………四集150页
 皮炎和多发性肌炎
 ………………四集146页
 脂膜炎……………二集增订本123页
 干燥综合征……………四集154页

内分泌系统疾病

尿崩症……………一集增订本81页
 慢性肾上腺皮质功能减退症

.....	二集增订本83页
皮质醇增多症...	二集增订本85页
甲状腺机能亢进症	
.....	一集增订本83页
甲状腺术后低钙性抽搐	
.....	七集73页
甲状腺机能减退症	
.....	一集增订本86页
单纯性甲状腺肿	三集97页
亚急性甲状腺炎.....	七集75页
桥本氏甲状腺炎	七集77页
男性乳房增大症	三集90页
男性更年期综合征.....	三集92页
 职业病及物理、化学、生物 因素疾病	
矽肺.....	三集100页
急性铅中毒.....	七集89页
慢性铅中毒.....	五集78页
急性无机汞中毒.....	七集87页
慢性苯中毒.....	三集99页
酒（乙醇、酒精）中毒	
.....	五集74页
一氧化碳中毒.....	五集76页
慢性地方性氟中毒.....	五集69页
氟骨症.....	八集49页
有机磷农药中毒后遗症	
.....	七集85页
安定中毒.....	五集70页

乌头类药物中毒.....	六集154页
人参中毒综合征.....	六集156页
链霉素毒副反应.....	三集98页
阿托品过量反应	五集71页
阿托品依赖症.....	六集153页
输液反应.....	七集78页
糖皮质激素副作用.....	七集80页
糖皮质激素戒断综合征	
.....	七集83页
吸烟戒断综合征	七集84页
迟发性运动障碍	五集72页
中暑.....	二集增订本69页
急性砒霜（砷）中毒	
.....	八集72页
鱼胆中毒.....	八集73页
蜈蚣螫伤.....	五集18页
蝎螫伤.....	五集82页
蜂类螫伤.....	五集83页
蛭类螫伤.....	五集83页
毒蜘蛛螫伤.....	五集84页
 其 他	
坏血病.....	五集48页
糙皮病.....	八集67页
减压病.....	八集57页
低热.....	一集增订本132页
癌性疼痛.....	八集59页
鼠咬热.....	七集58页
获得性免疫缺陷综合征	

..... 七集62页
 钩端螺旋体病... 二集增订本60页
 疟疾..... 八集70页
 变态反应性亚败血症
 三集94页
 肩周炎..... 二集增订本72页
 关节风湿病
 二集增订本74页
 化脓性关节炎..... 八集51页
 创伤性关节炎..... 八集55页
 流行性出血热
 二集增订本114页
 登革热..... 四集 8 页
 慢性布鲁氏菌病 四集12页
 特发性水肿..... 四集144页

强直性脊柱炎..... 四集156页
 大骨节病..... 五集62页
 莱特氏综合征..... 五集65页
 结核性变态反应性关节炎
 六集136页
 肩手综合征..... 六集137页
 低钙血症..... 八集68页
 页粉症..... 六集139页
 晕动病..... 六集140页
 过早衰老..... 六集141页
 红斑性肢痛症(灼热足综合征)
 六集106页
 慢性疲劳综合征..... 六集61页
 下肢静脉曲张..... 六集69页

妇 产 科

功能性子宫出血
 一集增订本134页
 痛经..... 一集增订本137页
 闭经..... 一集增订本141页
 闭经泌乳综合征..... 七集119页
 月经疹..... 七集117页
 月经周期性水肿..... 六集158页
 代偿性月经(倒经)
 一集增订本144页
 放环后月经不调..... 三集103页

蜕膜样痛经..... 三集104页
 更年期综合征
 一集增订本145页
 经前期紧张综合征
 二集增订本125页
 痛性脂肪过多综合征
 八集 77 页
 精神药物性溢乳症..... 四集166页
 霉菌性阴道炎
 一集增订本146页

滴虫性阴道炎
 一集增订本148页
 阿米巴性阴道炎..... 八集 75页
 老年性阴道炎..... 四集162页
 细菌性阴道病..... 七集128页
 女阴瘙痒症..... 一集增订本150页
 阴道痉挛..... 八集 79 页
 习惯性尿道综合征..... 八集 75 页
 女阴白斑症..... 一集增订本152页
 外阴溃疡..... 四集160页
 女性外伤性外阴血肿
 八集81页
 前庭大腺炎..... 四集161页
 子宫颈糜烂..... 一集增订本154页
 盆腔炎..... 一集增订本157页
 盆腔脓肿..... 八集 80 页
 盆腔淤血症..... 三集108页
 子宫脱垂..... 一集增订本160页
 子宫肌瘤..... 三集111页
 女子不孕症..... 一集增订本163页
 黄体功能不健..... 七集122页
 排卵功能障碍..... 七集124页
 梅毒性不孕..... 五集85页
 梅毒性流产..... 五集88页
 输卵管阻塞..... 三集105页
 输卵管积水..... 七集133页
 多囊卵巢综合征..... 三集106页
 女性生殖道结核..... 三集110页
 子宫内膜异位症..... 四集165页

慢性子宫内膜炎..... 七集131页
 子宫内膜增生不孕症
 八集82页
 女习惯性流产..... 一集增订本166页
 先兆流产..... 四集170页
 稽留流产..... 四集173页
 难免流产..... 四集174页
 完全流产..... 四集174页
 不完全流产..... 四集175页
 感染性流产..... 四集175页
 羊水过多症..... 四集176页
 宫外孕..... 四集167页
 葡萄胎..... 八集84页
 胎位不正..... 一集增订本167页
 妊娠水肿..... 二集增订本126页
 妊娠高血压..... 二集增订本127页
 妊娠呕吐..... 二集增订本128页
 妊娠小便不通..... 四集166页
 妊娠膀胱炎..... 六集159页
 妊娠胆汁淤积症..... 六集160页
 先兆子痫·子痫
 一集增订本168页
 胎儿宫内生长迟缓..... 六集162页
 过期妊娠..... 八集88页
 妊娠合并疟疾..... 八集86页
 胎盘滞留..... 五集89页
 产后乳汁过少... 一集增订本170页
 产后脑垂体前叶机能减退症
 一集增订本174页

产后尿潴留… 二集增订本130页
产褥感染……二集增订本133页
会阴切口感染……七集130页
产后出血……四集177页
产褥中暑……八集91页
产后小便失禁
……一集增订本169页
产后子宫收缩痛……五集90页
产后血栓性静脉炎……八集89页
产后子宫复旧不良……八集92页

刮宫术后出血……六集165页
急性乳腺炎……一集增订本175页
乳腺增生……一集增订本177页
乳房下垂……七集134页
乳房纤维瘤……三集113页
奶痃……三集113页
奶科癌症放疗后阴道干涩
……六集166页
女扎术后综合征……六集163页

儿 科

新生儿肝炎综合征……八集95页
新生儿窒息……八集96页
新生儿脐炎……八集98页
小儿反复呼吸道感染
……八集99页
小儿肺部罗音久不吸收
……八集100页
小儿高热惊厥……六集171页
小儿脑性瘫痪……六集180页
儿童乙型肝炎相关性肾炎
……六集169页
小儿胆汁淤积综合征……七集139页
小儿抽动 - 秽语综合征
……七集140页
麻疹……一集增订本179页

风疹……五集92页
水痘……五集93页
猩红热……一集增订本148页
百日咳……一集增订本186页
流行性腮腺炎……一集增订本190页
鹅口疮……二集增订本135页
小儿大叶性肺炎……四集183页
小儿迁延性肺炎……五集97页
小儿重症肺炎……七集136页
小儿毛细支气管炎……八集102页
小儿腺病毒肺炎……八集103页
白喉……四集188页
脊髓灰质炎……五集95页
小儿夏季热……一集增订本192页
小儿秋季腹泻……三集118页

蚕豆黄.....二集增订本137页
 小儿营养不良...一集增订本194页
 进行性肌营养不良症...三集115页
 小儿缺锌症.....六集168页
 小儿肌性斜颈.....五集101页
 新生儿硬肿症.....三集119页
 佝偻病.....二集增订本139页
 小儿皮质盲.....四集139页
 蛔虫性肠梗阻...一集增订本195页
 脱肛.....一集增订本197页
 小儿厌食症.....七集142页
 小儿急性偏瘫.....八集108页
 小儿迁延性肠炎.....八集105页
 遗尿.....一集增订本199页
 小儿神经性尿频.....八集107页
 儿童多动症.....三集117页
 小儿流涎.....一集增订本202页
 小儿屏气发作综合征

.....二集增订本142页
 女童性早熟.....二集增订本143页
 小儿智能低下.....四集179页
 小儿情感性交叉擦腿症
五集 99页
 幼女蛲虫感染性阴道炎
八集133页
 幼女阴道炎... ..八集114页
 小儿过敏性包皮水肿...八集116页
 婴儿蒙被缺氧综合征...五集100页
 小儿误吞金属异物
一集增订本204页
 川畸氏病.....六集183页
 儿童直立性调节障碍...七集184页
 先天性巨结肠.....六集184页
 肠病性肢端皮炎.....七集150页
 小儿肺不张.....六集186页

外科

外伤性截瘫.....八集117页
 手术切口久不愈合.....八集121页
 化脓性肉芽肿.....八集124页
 骨质增生.....一集增订本205页
 毛囊炎·疖·痈
一集增订本206页
 丹毒.....一集增订本211页

慢性丹毒.....七集167页
 类丹毒.....四集213页
 破伤风.....一集增订本212页
 腱鞘囊肿.....三集211页
 桡骨茎突部狭窄性腱鞘炎
六集208页
 屈指肌腱狭窄性腱鞘炎

.....六集210页
 非化脓性肋软骨炎.....三集122页
 水火烫伤.....一集增订本214页
 肢慢性溃疡.....一集增订本222页
 毒蛇咬伤.....一集增订本220页
 蛇伤性溃疡.....六集191页
 胸部迸伤.....五集117页
 胸部挫伤.....五集119页
 血胸.....八集141页
 臀上皮神经炎.....七集99页
 梨状肌损伤综合征.....五集121页
 肩部软组织扭挫伤.....五集123页
 肘部软组织扭挫伤.....五集125页
 肾挫伤.....七集100页
 腕关节劳损.....五集129页
 桡神经挫伤.....七集99页
 腕管综合征.....五集131页
 跖管综合征.....五集134页
 踝关节扭伤.....五集137页
 臀部注射感染性慢性窦道
七集102页
 骨化性肌炎.....七集103页
 髌骨软化症.....七集108页
 骨折愈合迟缓.....七集110页
 脊柱结核.....七集112页
 肋骨尖端综合征.....七集115页
 膝关节滑膜炎.....七集106页
 膝关节创伤性滑膜炎.....七集105页
 冻疮.....一集增订本217页

皸裂.....一集增订本219页
 落枕.....三集124页
 直肠息肉.....三集125页
 急性睾丸炎.....六集189页
 急性附睾炎.....六集188页
 副睾郁结症.....七集95页
 睾丸鞘膜积液.....三集127页
 网球肘.....三集128页
 足跟痛.....三集129页
 下节腔积液.....三集131页
 肩关节结核.....八集58页
 膝关节结核.....三集133页
 褥疮.....三集135页
 乳头破裂.....三集139页
 疥疮.....三集37页
 急性腰扭伤.....二集增订本145页
 慢性腰背痛.....二集增订本147页
 腰椎间盘突出症.....六集198页
 颈肩综合征.....八集125页
 岗下肌综合征.....八集128页
 骨筋膜间隔区综合征.....八集130页
 胸椎小关节紊乱综合征
八集133页
 急性腰椎后关节紊乱综合征
八集134页
 第三腰椎横突综合征.....八集136页
 髌髁关节错位.....八集138页
 股骨头无菌性坏死.....八集140页
 糖尿病趾端坏死.....六集193页

化脓性指头炎
二集增订本194页
 甲沟炎.....二集增订本150页
 化脓性骨髓炎
二集增订本151页
 肛裂.....二集增订本154页
 急腹症术后综合征.....六集194页
 败血症.....四集193页
 膈下脓肿.....七集90页
 外伤性血肿.....七集91页
 血栓性静脉炎.....四集197页
 血栓闭塞性脉管炎.....四集199页
 输精管结扎术后痛性结节
四集202页
 阴囊血肿.....七集29页
 急性淋巴结炎.....四集204页
 淋巴结核.....四集205页
 蜂窝组织炎.....四集208页
 肛管直肠周围脓肿.....五集103页
 肛门周围化脓性汗腺炎
五集105页
 肛门直肠神经官能症
五集107页
 肛门失禁.....五集109页
 肛门部下疳.....五集111页

糖尿病并发疔肿.....五集113页
 变形性膝关节炎.....五集114页
 颅内血肿.....七集93页
 寻常疣.....一集增订本225页
 扁平疣.....一集增订本227页
 跖疣.....七集156页
 尖锐湿疣.....三集138页
 肛门扁平湿疣.....五集152页
 皮肤癣病.....一集增订本228页
 湿疹.....一集增订本232页
 异位性湿疹(遗传性过敏性皮炎)
七集152页
 玫瑰糠疹.....三集139页
 鳞状毛囊角化症.....五集142页
 掌跖角化病.....七集164页
 剥脱性角质松解症.....八集144页
 毛发红糠疹.....五集143页
 手足口病.....四集207页
 足口病.....五集146页
 皮肤划痕症.....三集148页
 荨麻疹.....一集增订本239页
 丘疹性荨麻疹.....七集154页
 荨麻疹性血管炎.....七集155页
 神经性皮炎.....一集增订本241页

皮 肤 科

梅毒.....六集212页
 麻风.....六集218页
 淋病.....七集59页

生殖器疱疹.....六集221页
 带状疱疹.....一集增订本228页

老年性瘙痒症……………四集214页
 肛门瘙痒症……………五集149页
 肛门疣状皮肤结核……五集151页
 银屑病……………一集增订本242页
 类银屑病……………七集161页
 关节型银屑病……………八集150页
 脓疱型银屑病……………八集152页
 痤疮……………一集增订本243页
 酒渣鼻……………一集增订本246页
 鱼鳞病……………三集146页
 利尔黑变病……………五集144页
 皮肤网状青斑……………七集158页
 皮肤淀粉样变……………七集159页
 色素性紫癜性苔藓性皮炎
 ………………七集163页
 溃疡性黑色素瘤……………七集169页
 脂溢性皮炎·脂溢性脱发
 ………………一集增订本248页
 白癜风……………一集增订本250页
 播散性颜面粟粒性狼疮。
 ………………八集146页
 面部黄褐斑……………三集144页
 雀斑……………三集141页
 眼睑黄疣……………八集 47 页
 寒冷性多形红斑……………三集142页
 中毒性红斑……………八集148页
 斑秃……………一集增订本252页
 硬皮病……………二集增订本162页

松毛虫病……………五集146页
 头虱病……………七集170页
 阴虱病……………七集171页
 生漆过敏性皮炎……………三集140页
 剥脱性皮炎……………三集148页
 剥脱性唇炎……………三集151页
 植物日光性皮炎……………三集152页
 隐翅虫皮炎……………三集153页
 稻田皮炎……………三集154页
 接触性皮炎……………二集增订本156页
 尿布皮炎……………二集增订本158页
 夏季皮炎……………五集138页
 沥青皮炎……………四集212页
 射线皮炎……………八集145页
 激素制剂皮炎……………六集223页
 脓疱疮……………二集增订本159页
 坏疽性脓皮病……………七集166页
 天疱疮……………四集210页
 眼口生殖器三联症
 ………………二集增订本165页
 糜烂性包皮龟头炎……………五集141页
 药物性龟头炎……………八集122页
 念珠菌性甲沟炎……………五集140页
 腋臭……………一集增订本255页
 胼胝……………五集153页
 鸡眼……………五集153页
 瘢痕疙瘩……………五集155页

眼 科

外伤性前房积血……七集182页
 交感性眼炎……八集154页
 电光性眼炎……八集155页
 急性结合膜炎…二集增订本167页
 麦粒肿……二集增订本169页
 霰粒肿……四集238页
 白内障……二集增订本170页
 闪辉性暗点症……八集157页
 老年性白内障……四集235页
 青少年近视眼……七集173页
 视神经萎缩……四集218页
 视神经乳头水肿……八集156页
 球后视神经炎……六集225页
 急性虹膜睫状体炎……七集176页
 慢性虹膜睫状体炎……七集178页
 青光眼……六集223页
 单疱病毒性角膜炎……四集220页
 浅层点状角膜炎……八集158页

一般性角膜溃疡……八集160页
 霉菌性角膜溃疡……八集162页
 匍行性角膜溃疡……八集164页
 玻璃体积血……八集166页
 中心浆液性视网膜脉络膜炎
 视网膜静脉周围炎……四集225页
 ……………四集229页
 视网膜静脉阻塞……四集232页
 视网膜色素变性……七集184页
 泪道阻塞……四集240页
 睑缘炎……四集241页
 泪囊炎……四集243页
 夜盲症……五集160页
 色盲……五集162页
 视力疲劳……七集179页
 眶上神经痛……五集163页
 眼底出血症……五集164页

耳鼻喉科

急性化脓性中耳炎
 ……………二集增订本173页
 慢性化脓性中耳炎
 ……………二集增订本175页
 急性渗出性中耳炎……七集188页
 慢性渗出性中耳炎……七集190页
 爆震性耳聋……八集169页

突发性耳聋……五集157页
 老年性耳聋……六集233页
 自觉性耳鸣……七集191页
 肌源性他觉性耳鸣……七集195页
 耳廓软骨膜炎……八集170页
 鼻出血……三集160页
 鼻息肉……三集161页

慢性单纯性鼻炎

.....二集增订本176页
萎缩性鼻炎.....二集订本178页
过敏性鼻炎.....二集增订本180页
鼻前庭炎.....七集197页
副鼻窦炎.....二集增订本181页
鼻粘膜糜烂.....八集171页

急性会厌炎.....三集157页

急性咽炎.....二集增订本184页

慢性咽炎.....二集增订本185页

声带息肉.....三集158页

声带结节.....三集159页

声带麻痹.....七集198页

骨刺鲠喉.....六集238页

口腔科

牙周病.....三集162页

牙本质过敏.....八集173页

下颌关节功能紊乱症

.....三集164页

口腔扁平苔藓.....三集166页

干槽症.....三集167页

复发性口腔溃疡.....三集168页

智齿冠周炎.....四集245页

急性多发性颌脓肿

.....四集247页

疱疹性口炎.....四集248页

放射性口腔炎.....八集172页

药物过敏性口炎.....四集249页

舌下腺囊肿.....六集239页

口腔粘膜白斑.....六集240页

肿瘤科

鼻咽癌.....二集增订本187页

食道癌.....二集增订本190页

喉癌.....二集增订本193页

甲状腺癌.....二集增订本194页

肺癌.....二集增订本196页

胃癌.....二集增订本199页

结肠癌.....二集增订本202页

直肠癌.....二集增订本205页

原发性肝癌.....二集增订本207页

胰腺癌.....二集增订本210页

肾癌.....二集增订本212页

膀胱癌.....二集增订本214页

睾丸肿瘤.....二集增订本216页

乳腺癌.....二集增订本217页

子宫颈癌.....二集增订本220页

卵巢癌.....二集增订本223页

白血病.....二集增订本225页

脑瘤.....二集增订本228页

后 记

系列丛书《百病良方》自1981年出版问世迄今十年以来，深得广大读者厚爱，现已连续出版了八集。8集共收载现代医学命名的病种800个，每一病症列方数首，可供临床医生辨证选用。希望广大读者阅后不吝指正，以便不断改进。

《中国当代中医名人志》入选人
《百病良方》1~8集主编
重庆市中医研究所副主任医师
重庆市科普作家协会理事

贾 河 先

一九九一年十月

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=百病良方 第八集

作者=贾河先 吴家福编著

页数= 1 9 2

S S 号= 1 0 2 9 7 9 7 0

出版日期= 1 9 9 2 年 0 8 月第 1 版